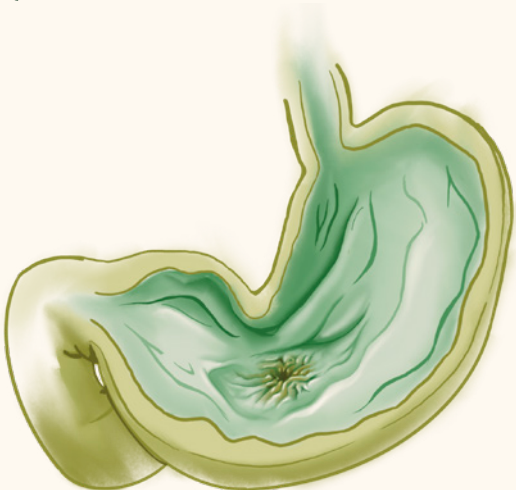


Digestivo



DESCGLOSES MIR

T02 Disfagia

P067 MIR 2022-2023

La disfagia orofaríngea es la dificultad de trasladar el alimento desde la cavidad oral hasta el esófago proximal. Entre las causas de disfagia orofaríngea motora están las siguientes, EXCEPTO:

- 1) Miastenia gravis.
- 2) Reflujo gastroesofágico.
- 3) Tétanos.
- 4) Dermatomopolimiositis.

Respuesta correcta: 2

T03 Trastornos motores del esófago

P080 MIR 2018-2019

Una mujer de 43 años refiere cuadros de dificultad para la ingesta de sólidos desde hace años. En el último año estos cuadros se han intensificado y en ocasiones se acompañan de dolor torácico. Ha perdido de 4 a 5 kg de peso. Aporta gastroscopia: restos alimentarios en esófago; estómago y duodeno sin alteraciones. Se completa el estudio con la realización de manometría esofágica. ¿Qué alteración, de entre las que se describen a continuación, cree que presenta la paciente?

- 5) Esfínter esofágico superior hipertenso.
- 6) Ondas peristálticas en cuerpo esofágico y esfínter esofágico superior hipotenso.
- 7) Aperistalsis de cuerpo esofágico y esfínter esofágico inferior hipertenso.
- 8) Esfínter esofágico inferior hipotenso con relajaciones completas.

Respuesta correcta: 3

P138 MIR 2021-2022

Mujer de 27 años que consulta por disfagia y odinofagia. En los últimos meses nota sensación de dificultad al tragar, más con líquidos que con sólidos, dolor centrotorácico, algún vómito aislado, sin esfuerzo y más parecido a una regurgitación. No refiere pérdida de peso ni de apetito. Exploración física normal. Analítica completa dentro de la normalidad. Endoscopia oral sin alteraciones estructurales ni lesiones mucosas. Manometría esofágica de alta resolución: actividad vigorosa y ausencia de peristalsis en el cuerpo esofágico con relajación normal del esfínter esofágico inferior. El diagnóstico MÁS probable es:

- 1) Espasmo esofágico distal.
- 2) Esófago hipercontráctil.
- 3) Acalasia tipo I.
- 4) Peristalsis fragmentada.

Respuesta correcta: 1

P024 MIR 2022-2023

Pregunta vinculada a la imagen nº 24. Mujer de 36 años sin antecedentes de interés que acude a Urgencias por molestias retroesternales con la deglución, sin fiebre ni clínica infecciosa. Refiere un cuadro de años de evolución de episodios intermitentes de detención alimentaria a nivel retroesternal tras la ingesta de sólidos y líquidos. Se acompaña de pérdida de peso progresiva. La analítica sanguínea es normal. En la radiografía de tórax se observa ensanchamiento mediastínico, por lo que se realiza la TC torácica con contraste intravenoso que se muestra en la imagen vinculada. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

- 1) Acalasia.
- 2) Gran divertículo esofágico de Zenker.

- 3) Espasmo esofágico difuso.
- 4) Retención alimentaria por tumor submucoso (leiomioma) obstructivo en tercio distal esofágico.

Respuesta correcta: 1

P121 MIR 2024-2025

Respecto al divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker, es cierto que:

- 1) Es un divertículo por tracción y consta de todas las capas de la pared esofágica.
- 2) Es menos frecuente que los divertículos del tercio medio del esófago en la actualidad.
- 3) No se trata con miotomía del cricofaríngeo si el tamaño es igual o menor a 2 cm.
- 4) Cuando se interviene mediante abordaje abierto para practicar una diverticulotomía o una diverticulopexia, la incisión se realiza en el lado izquierdo del cuello.

Respuesta correcta: 4

T04

Enfermedades inflamatorias del esófago

P044 MIR 2010-2011

Un hombre de 60 años de edad refiere pirosis diaria desde la juventud que trata con alcalinos. Se le practica una endoscopia digestiva alta que muestra esofagitis erosiva leve y la unión escamosa columnar desplazada aproximadamente 7 cm respecto a la porción más proximal de los pliegues gástricos. Las biopsias del esófago distal revelan que el epitelio escamoso normal ha sido reemplazado por epitelio columnar de tipo intestinal con displasia de bajo grado. ¿Cuál es la opción más apropiada para el manejo de este paciente?

- 1) Dado que la esofagitis es leve y la displasia de bajo grado, se aconseja continuar tratamiento con alcalinos.
- 2) Tratamiento indefinido con dosis altas de inhibidores de la bomba de protones ya que se ha demostrado que así se evita la progresión del esófago de Barrett a adenocarcinoma haciendo innecesaria la vigilancia endoscópica.

- 3) Endoscopias de vigilancia periódicas y tratamiento con inhibidores de la bomba de protones durante menos de 12 semanas, ya que tratamientos más prolongados se asocian a un alto riesgo de desarrollo de gastrinomas.
- 4) Endoscopias de vigilancia periódicas y tratamiento indefinido con inhibidores de la bomba de protones.
- 5) Esofagectomía.

Respuesta correcta: 4

P031 MIR 2011-2012

La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede producir síndromes extraesofágicos, algunos de ellos están establecidos confirmados, y otros sólo están propuestos. ¿Cuál de ellos no es un síndrome extraesofágico establecido?

- 1) Sinusitis.
- 2) Erosión dental por reflujo.
- 3) Asma.
- 4) Laringitis.
- 5) Tos crónica.

Respuesta correcta: 1

P046 MIR 2012-2013

¿Cuál de las siguientes entidades clínicas NO es objeto de estudios endoscópicos repetidos (de seguimiento) para el despistaje precoz de neoplasia digestiva?

- 1) Esófago de Barrett.
- 2) Pólipos adenomatosos de colon.
- 3) Hernia hiatal en pacientes con reflujo clínico sintomático.
- 4) Familiares de primer grado con cáncer de colon.
- 5) Pancolitis ulcerosa de más de 10 años de evolución.

Respuesta correcta: 3

P090 MIR 2013-2014

¿Qué enfermedad sospecharíamos en un paciente joven que refiere historia frecuente de disfagia a sólidos y a líquidos con impactaciones de alimentos repetidas, sin clínica de pirosis, y en el que en la endoscopia oral se observan múltiples

anillos esofágicos concéntricos con mucosa normal (aspecto traquealizado)?

- 1) Esofagitis herpética.
- 2) Esofagitis eosinofílica.
- 3) Esofagitis candidiásica.
- 4) Esofagitis por *citomegalovirus*.
- 5) Adenocarcinoma de esófago.

Respuesta correcta: 2

P039 MIR 2014-2015

Respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿Cuál de los siguientes enunciados es cierto?

- 1) La intensidad y frecuencia de pirosis tiene poca relación con la presencia y gravedad de esofagitis endoscópica.
- 2) La mayoría de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico presentan esofagitis en la endoscopia.
- 3) El tratamiento con inhibidores de la bomba de protones suele conseguir un buen control de los síntomas, pero no es superior a placebo en la curación endoscópica de la esofagitis.
- 4) El esófago de Barrett puede progresar a displasia epitelial de bajo grado, displasia epitelial de alto grado y finalmente a carcinoma escamoso de esófago.
- 5) Los programas endoscópicos de cribado y vigilancia han demostrado de forma inequívoca ser capaces de reducir la mortalidad en pacientes con esófago de Barrett.

Respuesta correcta: 1

P071 MIR 2015-2016

Joven de 18 años de edad, con antecedentes de asma, alergia a pólenes, ácaros y pelo de gato, acude a urgencia refiriendo sensación de detención de alimentos a nivel retroesternal con práctica incapacidad para deglutir su propia saliva. Refiere episodios similares en otras ocasiones que han cedido de forma espontánea en pocos minutos. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- 1) Esófago de Barrett.
- 2) Anillo esofágico distal (Schatzki).
- 3) Esofagitis infecciosa.
- 4) Esofagitis eosinofílica.

Respuesta correcta: 4



P012 MIR 2016-2017

Pregunta vinculada a la imagen nº 12. Paciente de 58 años con clínica de pirosis de larga evolución. Se realiza una endoscopia digestiva alta que se muestra en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS PROBABLE?

- 1) Esófago de Barrett.
- 2) Esofagitis péptica.
- 3) Esofagitis eosinofílica.
- 4) Enfermedad de Mallory-Weiss.

Respuesta correcta: 1

P005 MIR 2017-2018

Pregunta vinculada a la imagen nº 5. Carlos tiene 31 años y es la tercera vez que acude este año a Urgencias por presentar episodios de impactación esofágica tras la ingesta de carne que han precisado de su extracción por endoscopia oral. Como antecedentes cabe reseñar que presenta asma bronquial y es alérgico a los frutos secos. Señale la afirmación VERDADERA en base a los hallazgos esofágicos encontrados en una nueva endoscopia oral (imagen vinculada):

- 1) La imagen corresponde a la tráquea, el endoscopista ha entrado a la vía respiratoria.
- 2) La sospecha diagnóstica debería confirmarse con histología tomando biopsias de esófago distal y proximal.
- 3) Si el paciente refiere dolor torácico la imagen es diagnóstica de espasmo esofágico difuso.
- 4) La imagen corresponde a una acalasia.

Respuesta correcta: 2

P040 MIR 2017-2018

El hallazgo histológico que permite un diagnóstico de esófago de Barret en una biopsia es la presencia de:

- 1) Epitelio plano papilomatoso.
- 2) Epitelio columnar especializado con células caliciformes.
- 3) Infiltrado inflamatorio mononuclear.
- 4) Acantosis glucogénica.

Respuesta correcta: 2

P014 MIR 2018-2019

Pregunta vinculada a la imagen nº 14. Una mujer de 68 años, diagnosticada de hipercolesterolemia en tratamiento con simvastatina, consulta por disfagia y odinofagia intensas de una semana de evolución. Se realiza una gastroscopia (imagen vinculada). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- 1) Aunque no existen datos de inmunosupresión, no puede descartarse la etiología herpética.
- 2) La etiología más probable es farmacológica, dado su tratamiento actual con simvastatina.
- 3) La infección por *citomegalovirus* es la causa más frecuente de las lesiones en personas inmunocompetentes.
- 4) La presencia de células gigantes y de cuerpos de inclusión eosinofílicos en el estudio histopatológico de las biopsias, confirmarían la etiología candidiásica.

Respuesta correcta: 1

P013 MIR 2021-2022

Pregunta vinculada a la imagen nº 13. Mujer de 64 años que consulta por dolor centrotorácico de 24 horas de evolución sin otras manifestaciones clínicas. En la radiografía de tórax de la imagen vinculada, ¿qué hallazgo se encuentra?

- 1) Aneurisma aórtico.
- 2) Pericarditis aguda.
- 3) Neumonía.
- 4) Hernia hiatal.

Respuesta correcta: 4

P209 MIR 2021-2022

En la endoscopia oral de un paciente con pirosis de larga evolución se aprecia una mucosa rosada ascendente en llamas, sin erosiones ni úlceras. Se toman biopsias esofágicas que demuestran la presencia de epitelio metaplásico, con 3-4 eosinófilos por campo y sin displasia. El diagnóstico MÁS probable es:

- 1) Esófago de Barrett.
- 2) Esfagitis eosinofílica.

- 3) Enfermedad por reflujo gastro-esofágico no erosiva.
- 4) Esfagitis grado B de Los Ángeles.

Respuesta correcta: 1

P040 MIR 2022-2023

Con respecto a la esofagitis eosinofílica, es INCORRECTO que:

- 1) El diagnóstico de certeza se realiza mediante endoscopia digestiva alta y biopsia.
- 2) El tratamiento inicial es recomendar dieta de eliminación de aquellos alimentos en los que se demuestran reacciones positivas *in vivo* o *in vitro*.
- 3) La inflamación subyacente indica un mecanismo patogénico de hipersensibilidad Th1.
- 4) La inmunoterapia específica frente a los alérgenos respiratorios y alimentarios a los que se ha demostrado sensibilización es una práctica habitual.

Respuesta correcta: Anulada

P042 MIR 2023-2024

Un paciente acude a consulta recientemente diagnosticado de esofagitis eosinofílica y tras exponerle las opciones de tratamiento prefiere hacer tratamiento dietético con dieta de exclusión de dos alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que tendría que retirar de la dieta?

- 1) Huevo y trigo.
- 2) Leche de vaca y pescado.
- 3) Legumbres y leche de vaca.
- 4) Leche de vaca y trigo.

Respuesta correcta: 4

P127 MIR 2024-2025

La forma más eficaz de evaluación preoperatoria de la función del cuerpo esofágico y del esfínter esofágico inferior en un paciente con sospecha de reflujo gastroesofágico es:

- 1) La monitorización ambulatoria del pH y la impedancia.
- 2) Manometría esofágica.

- 3) Esofagoduodenoscopia.
- 4) Esofagograma con bario.

Respuesta correcta: 2

P100 MIR 2025-2026

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación con el divertículo faringoesofágico de Zenker?

- 1) Se trata de un divertículo por tracción.
- 2) Es más frecuente en pacientes jóvenes.
- 3) Entre sus síntomas se encuentran: disfagia, regurgitación y halitosis.
- 4) La localización específica en la parte posterior de la faringe se denomina triángulo de Farabeuf.

Respuesta correcta: 3

P148 MIR 2025-2026

Paciente varón de 58 años, con historia de más de 15 años de pirosis y regurgitación, tratada de forma intermitente con inhibidores de la bomba de protones. No fumador, con índice de masa corporal de 35 kg/m². Consulta por empeoramiento de los síntomas. Se realiza gastroscopia en la que se objetiva un segmento de mucosa columnar de 5 cm por encima de la unión esofagagástrica (C3M5), sin lesiones nodulares. Se toman biopsias con el resultado siguiente: metaplasia intestinal con displasia de bajo grado en dos cilindros. La revisión por un patólogo experto en esófago de Barrett confirma la presencia de displasia de bajo grado verdadera. Según las recomendaciones actuales de manejo del Barrett con displasia confirmada, la actitud MÁS adecuada es:

- 1) Mantener el inhibidor de la bomba de protones a demanda y repetir la endoscopia de control a los tres años.
- 2) Repetir la endoscopia en 12 meses sin otras medidas, dado que es displasia de bajo grado.
- 3) Ofrecer ablación por radiofrecuencia mediante endoscopia en un centro experto, manteniendo el inhibidor de la bomba de protones.
- 4) Indicar esofagectomía subtotal profiláctica por el riesgo acumulado de carcinoma.

Respuesta correcta: 3

P149 MIR 2025-2026

Paciente de 52 años, con pirosis y dolor retroesternal. Se le realiza una endoscopia alta en la que se observa esofagitis erosiva grado C de Los Ángeles. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- 1) Un ciclo corto de dos semanas de inhibidor de la bomba de protones sería suficiente para asegurar la curación mucosa esofágica.
- 2) Debe plantearse tratamiento de mantenimiento con inhibidor de la bomba de protones a largo plazo.
- 3) Una vez curada la esofagitis, no existe riesgo aumentado de Barrett.
- 4) El tratamiento de elección son los anti-H₂ nocturnos como monoterapia.

Respuesta correcta: 2

T05 Tumores esofágicos

P026 MIR 2009-2010

Entre las causas de carcinoma epidermoide de esófago se consideran las siguientes excepto:

- 1) Tabaco.
- 2) Alcohol.
- 3) Acalasia.
- 4) S. de Plummer-Vinson.
- 5) Reflujo gastro-esofágico.

Respuesta correcta: 5

P080 MIR 2017-2018

Hombre de 56 años, fumador y bebedor, que presenta disfagia principalmente a sólidos, regurgitaciones y dolor retroesternal. Se le realiza endoscopia, encontrando tumoración de 3 cm estenosante en esófago distal. La biopsia es informada como adenocarcinoma. En la TC torácica se observa engrosamiento de 2 cm en esófago torácico sin metástasis a distancia. En la ecografía transesofágica se observa tumoración que invade la muscular, sin observar adenopatías mediastínicas. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

- 1) Quimiorradioterapia neoadyuvante y posteriormente esofagectomía.
- 2) Radioterapia como tratamiento definitivo.
- 3) Colocación de prótesis de tipo stent.
- 4) Esophagectomía y plastia gástrica con anastomosis cervical.

Respuesta correcta: 4

P129 MIR 2019-2020

Hombre de 65 años que consulta por disfagia a sólidos desde hace dos meses. La esofagoscopia evidencia tumoración a 30 cm de arcada dental, parcialmente estenosante, con anatomía patológica de carcinoma epidermoide. Se le solicita ecografía endoscópica y PET-TC donde no se observan adenopatías patológicas. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la MÁS correcta?

- 1) Esophagectomía trashital.
- 2) Esophagectomía según la técnica de Ivor-Lewis.
- 3) Quimioterapia + radioterapia preoperatoria.
- 4) Quimioterapia neoadyuvante.

Respuesta correcta: 3

P155 MIR 2020-2021

Los tumores benignos MÁS frecuentes del esófago son:

- 1) Los pólipos fibrovasculares.
- 2) Los leiomiomas.
- 3) Los papilomas escamosos.
- 4) Los hemangiomas.

Respuesta correcta: 2

T07 Infección por *Helicobacter pylori*

P032 MIR 2011-2012

En relación con el *Helicobacter pylori*, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- 1) La transmisión es por vía oral-oral o fecal-oral.
- 2) Se asocia casi siempre a gastritis crónica.
- 3) Es un microorganismo microaerófilo gramnegativo.



- 4) Está diseñado para vivir en el medio ácido del estómago.
- 5) El test de ureasa para el diagnóstico del *H. pylori* presenta una sensibilidad y especificidad inferior al 50%.

Respuesta correcta: 5

P035 MIR 2012-2013

En relación con la infección por *H. pylori*, señalar la respuesta FALSA:

- 1) Se recomienda la erradicación de esta bacteria en personas con historia previa de enfermedad ulcerosa péptica, aunque se encuentren asintomáticas.
- 2) Es recomendable la realización de un amplio despistaje y tratamiento de esta infección en la población general para disminuir la incidencia de cáncer gástrico y de enfermedad ulcerosa péptica.
- 3) Para comprobar la eliminación de la infección por *H. pylori* con la prueba del aliento con urea marcada tras el tratamiento se debe suprimir la toma de inhibidores de la bomba de protones al menos 2 semanas antes.
- 4) Se recomienda la erradicación de esta bacteria en familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico.
- 5) En pacientes con úlcera gástrica se recomienda que la comprobación de la erradicación de esta bacteria se realice con endoscopia y toma de biopsias gástricas para asegurarse de la cicatrización ulcerosa.

Respuesta correcta: 2

P079 MIR 2013-2014

En la fisiopatología de la úlcera péptica, ¿cuál es la FALSA?

- 1) Gran parte de las úlceras gastroduodenales se pueden atribuir a la infección por *H. pylori* o lesión mucosa por AINES.
- 2) *H. pylori* no se relaciona con el desarrollo de linfoma gástrico.
- 3) La transmisión de *H. pylori* se produce de persona a persona vía oral-oral o focal-oral.
- 4) Un menor nivel educativo y un estatus socioeconómico bajo predisponen a mayores índices de colonización.
- 5) La incidencia de adenocarcinoma gástrico

es mayor en pacientes portadores del *H. pylori*.

Respuesta correcta: 2

P233 MIR 2015-2016

Acude a consultas de pediatría un niño de 13 años de edad por presentar sensación de pirosis, durante y tras las comidas, y disfagia ocasional, que aumenta con la ingesta de alimentos sólidos como la carne. En los antecedentes familiares, destacar que su madre está diagnosticada de hernia hiatal. En los antecedentes personales, nos refiere alergia a pólenes, ácaros y látex. En la exploración física, no muestra hallazgos significativos, salvo lesiones eczematosas en huecos poplíteos y antecubitales. ¿Cuál de las siguientes pruebas complementarias NO realizaría de acuerdo con los diagnósticos más probables?

- 1) Endoscopia digestiva superior.
- 2) pHmetría esofágica de 24 horas.
- 3) Test de aliento con carbono 13 para *Helicobacter pylori*.
- 4) Estudio baritado esófago-gastro-duodenal.

Respuesta correcta: 3

P045 MIR 2016-2017

En el estudio de la secreción gástrica, ¿Cuál de las siguientes pruebas carece de valor?

- 1) Test de la ureasa.
- 2) Determinación de pepsinógenos.
- 3) Estimulación con pentagastrina.
- 4) Prueba de la comida ficticia.

Respuesta correcta: 1

T08 Gastritis: aguda y crónica.
Gastropatía.
Gastroparesia

P036 MIR 2012-2013

El diagnóstico de gastritis crónica se realiza fundamentalmente mediante:

- 1) Valoración de *Helicobacter pylori*.
- 2) Ecoendoscopia.

- 3) Determinación de la vitamina B₁₂.
- 4) Estudio histológico.
- 5) Estudios radiológicos.

Respuesta correcta: 4

P037 MIR 2012-2013

Una mujer de 46 años de edad, diabética en tratamiento con insulina desde hace unos 12 años, presenta sensación de saciedad, náuseas, vómitos y pérdida de unos 3 kg de peso en el último mes. Se sospecha una gastroparesia diabética, siendo la mejor prueba para este diagnóstico una de las siguientes:

- 1) Estudio de vaciamiento gástrico de sólidos con isótopos radiactivos.
- 2) Manometría gástrica.
- 3) Gastroscoopia.
- 4) Electrogastrografía.
- 5) Rx con contraste baritado (tránsito gastrointestinal).

Respuesta correcta: 1

P089 MIR 2013-2014

Existen la gastritis tipo A y la tipo B. Señale cuál de las siguientes es una característica de la primera:

- 1) Predomina en el antro.
- 2) Es más frecuente que la B.
- 3) Está causada por *H. pylori*.
- 4) Cursa con aclorhidria.
- 5) En el 50% hay antirreceptor anticélulas parietales.

Respuesta correcta: Anulada

P072 MIR 2015-2016

Señale la respuesta FALSA, de entre las siguientes, en relación con el concepto de gastritis:

- 1) Es un término que debe reservarse para definir la existencia de inflamación histológica en la mucosa gástrica.
- 2) Existe un espectro de manifestaciones clínicas claramente definidas en relación con la existencia de gastritis.
- 3) El *Helicobacter pylori* es una causa frecuente de gastritis.

4) Existe una escasa correlación entre los datos histológicos, los síntomas del paciente y los datos endoscópicos.

Respuesta correcta: 2

P035 MIR 2016-2017

¿Cuál de los siguientes rasgos morfológicos no esperamos encontrar en la biopsia del cuerpo gástrico de un paciente con deficiencia de vitamina B₁₂?

- 1) *Helicobacter pylori*.
- 2) Metaplasia intestinal.
- 3) Hiperplasia de células endocrinas.
- 4) Atrofia.

Respuesta correcta: 1

P081 MIR 2017-2018

Mujer de 39 años, diagnosticada de diabetes mellitus tipo 1 hace más de 20 años. Desde hace varios meses refiere presentar cuadros de náuseas, con algunos vómitos alimentarios y distensión abdominal. Ha perdido 6 kg de peso. Gastroscoopia: esófago normal, estómago con restos alimentarios y resto de la exploración hasta segunda porción duodenal sin alteraciones. ¿Qué prueba considera que es de MAYOR utilidad para su diagnóstico?

- 1) Ecografía de abdomen.
- 2) Manometría esofágica.
- 3) TC de abdomen.
- 4) Estudio isotópico de vaciamiento gástrico.

Respuesta correcta: 4

P081 MIR 2018-2019

Se nos remite un hombre de 45 años tras la extirpación endoscópica de al menos 7 pólipos gástricos de entre 1 y 2 mm. El diagnóstico anatomopatológico es de gastritis crónica con marcada atrofia corporal y metaplasia intestinal, y focos de microcarcinóide que afecta a las biopsias de cuerpo gástrico y *fundus*. Indique la afirmación CORRECTA:

- 1) La mayor parte de los casos cursa con hipogastrinemia.
- 2) La metaplasia intestinal en el estómago es indicación de gastrectomía por la alta tasa de transformación a adenocarcinoma.

- 3) En el caso de indicar cirugía, la gastrectomía distal es la cirugía más indicada.
- 4) Está indicado el tratamiento con análogos de la somatostatina.

Respuesta correcta: 3

T10

Úlcera péptica producida por *H. pylori* y por antiinflamatorios no esteroideos (AINE)

P028 MIR 2009-2010

Un hombre de 40 años sin enfermedades concomitantes acude a Urgencias por melenas de 24 horas de evolución sin repercusión hemodinámica. Refiere consumo de antiinflamatorios no esteroideos los días previos por cefalea. La analítica es normal salvo el hematocrito de 33%. La endoscopia digestiva alta realizada de forma urgente a las 6 horas del ingreso muestra una úlcera antral excavada de 8 mm de diámetro con base de fibrina limpia y bordes lisos y regulares. Las biopsias de la úlcera resultan benignas y muestran infección por *Helicobacter pylori*. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- 1) En la endoscopia inicial está indicado aplicar una terapéutica endoscópica para disminuir el riesgo de recidiva hemorrágica.
- 2) Dada la ausencia de malignidad en las biopsias iniciales y el aspecto endoscópico de la úlcera, se puede descartar de manera fiable el cáncer gástrico y es innecesario el seguimiento endoscópico.
- 3) Sólo está indicado el tratamiento erradicador del *Helicobacter pylori* si se constata recidiva de la úlcera en ausencia de antiinflamatorios no esteroideos.
- 4) Dado que se trata de una úlcera complicada (hemorragia) la mejor opción terapéutica es una vagotomía y piloroplastia.
- 5) El paciente podría ser dado de alta hospitalaria de forma precoz.

Respuesta correcta: 5

P035 MIR 2010-2011

Hombre de 43 años sin enfermedades de interés que acude a Urgencias del hospital por 4 deposiciones melénicas en las últimas 12

horas. Refiere toma de antiinflamatorios en días previos. En la exploración física destaca palidez de piel y mucosas. TA 95/65 mmHg y frecuencia cardíaca 110 lpm. El abdomen no es doloroso y en el tacto rectal se demuestran deposiciones melénicas. En la analítica se encuentra una cifra de Hb de 8,1 g/dL. Tras infusión de suero salino y comenzar la transfusión de concentrado de hemáties, la TA es 120/85 mmHg y la frecuencia cardíaca 90 lpm. Se realiza endoscopia digestiva urgente en la que se encuentran coágulos en el estómago y una úlcera de 2 cm en el antro gástrico con fondo de fibrina y una pequeña protuberancia blanco-grisácea de 3 mm en el centro de la úlcera (trombo plaquetar o "vaso visible"). ¿Qué actitud le parece más correcta?

- 1) Dado que el paciente es joven, sin enfermedades asociadas y la úlcera ha dejado de sangrar, puede ser dado de alta precozmente con tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones y erradicación de *H. pylori*.
- 2) Retirar endoscopio, colocar sonda nasogástrica para aspiración continua e iniciar tratamiento con un inhibidor de la bomba de protones y con somatostatina.
- 3) Tomar biopsia para la detección de *H. pylori*, retirar el endoscopio procurando no desprender el trombo plaquetar y continuar tratamiento farmacológico con administración intravenosa de inhibidor de la bomba de protones.
- 4) Consulta al Servicio de Cirugía para considerar tratamiento quirúrgico urgente.
- 5) Tratamiento endoscópico mediante inyección de adrenalina en la úlcera y colocación de "clips" (grapas metálicas), seguido de la administración intravenosa de inhibidor de la bomba de protones.

Respuesta correcta: 5

P052 MIR 2013-2014

Los fármacos inhibidores de la bomba de protones, administrados por vía oral:

- 1) Neutralizan el ácido clorhídrico de la secreción gástrica.
- 2) Tiñen las heces de color negro.
- 3) Bloquean el receptor histaminérgico.
- 4) Bloquean el receptor de la gastrina.
- 5) Requieren cubierta entérica.

Respuesta correcta: 5



P078 MIR 2013-2014

Mujer de 65 años de edad, con antecedentes de dolores articulares en tratamiento con antiinflamatorios, que es remitida a estudio por presentar anemia. En los estudios complementarios presenta hemáties 3,164.000, Hto. 32%, Hb 11 g/dL, VCM 69 fL, leucocitos 7800, plaquetas 370.000, PCR 0,29 mg/dL, Fe 20 ng/mL, ferritina 18 ng/mL, glucosa 105 mg/dL, GOT, GPT, GGT, F. Alcalina, bilirrubina total, colesterol, creatinina, calcio y fósforo normales y Ac antitransglutaminasa y Ac anti gliadina negativos. Gastroscofia: hernia de hiato de 3 cm, resto sin alteraciones. Colonoscopia: hasta ciego, aislados divertículos en sigma. Tránsito intestinal sin alteraciones. Ecografía de abdomen sin alteraciones. ¿Cuál de las exploraciones que se enumeran a continuación le parece más adecuada para completar el estudio?

- 1) Biopsia de yeyuno.
- 2) Arteriografía.
- 3) Cápsula endoscópica.
- 4) Radioisótopos.
- 5) RM pélvica.

Respuesta correcta: 3

P081 MIR 2013-2014

Un paciente acude a un servicio de urgencias hospitalarias presentando hematemesis franca. En la valoración inicial, el paciente está pálido y sudoroso, tiene una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y una presión arterial de 98 mmHg. ¿Cuál de las siguientes acciones NO realizaría en la atención inicial a este paciente?

- 1) Asegurar una adecuada oxigenación del paciente.
- 2) Canalizar dos vías periféricas de grueso calibre.
- 3) Utilizar el hematocrito como índice de pérdida hemática.
- 4) Reponer la volemia con soluciones de cristaloides.
- 5) Colocar una sonda nasogástrica.

Respuesta correcta: 3

P003 MIR 2014-2015

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. Hombre de 65 años con antecedentes

personales de hepatopatía crónica etílica en estadio funcional A de Child en tratamiento con ibuprofeno por lumbalgia, presenta cuadro de hematemesis de sangre roja. A su llegada a urgencias presenta tensión arterial de 120/60 mmHg. En la analítica muestra como datos más destacados hemoglobina 10 g/dL, plaquetas 250.000 /mCL, urea 85 mg/dL y creatinina 1,1 mg/dL. Se realiza endoscopia urgente que muestra la imagen. Ante dichos hallazgos cuál es la respuesta correcta:

- 1) Tan solo es preciso realizar trasfusión de concentrados de hemáties y vigilar la estabilidad hemodinámica del paciente.
- 2) Los hallazgos endoscópicos sugieren una clasificación de Forrest III.
- 3) La colocación de bandas es el tratamiento endoscópico de elección ya que se trata de un paciente hepatópata.
- 4) Se necesita la realización de una endoscopia a las 12 h para vigilar la posibilidad de resangrado de manera sistemática.
- 5) Es precisa la realización de tratamiento endoscópico con adrenalina 1:10000 asociada a la colocación de un endoclip.

Respuesta correcta: 5

P004 MIR 2014-2015

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. En el caso anteriormente descrito y respecto al tratamiento farmacológico cuál es la afirmación correcta:

- 1) No es preciso el tratamiento farmacológico ya que se ha identificado la lesión sangrante.
- 2) El tratamiento ideal para este paciente es la perfusión de somatostatina ya que se trata de un paciente hepatópata.
- 3) La utilización de omeprazol a altas dosis reduce la recidiva de sangrado.
- 4) La ranitidina es el fármaco de elección para evitar la toxicidad farmacológica al tratarse de un paciente con hepatopatía crónica.
- 5) La erradicación del *Helicobacter pylori* es la primera medida a tomar.

Respuesta correcta: 3

P041 MIR 2014-2015

Un paciente ingresa con el diagnóstico de hemorragia digestiva alta en situación

hemodinámica estable. Se practica una gastroscopia que informa: Lesión ulcerada en cara posterior del bulbo duodenal con hemorragia activa no pulsátil. Forrest Ib. Se practica esclerosis endoscópica con adrenalina consiguiéndose hemostasia. Señala la afirmación correcta:

- 1) La lesión descrita tiene un riesgo bajo de recidiva hemorrágica.
- 2) En caso de recidiva hemorrágica es imprescindible la intervención quirúrgica.
- 3) Por la localización de la lesión puede estar afectada la arteria gastroduodenal.
- 4) La descripción y localización de la úlcera sugieren una lesión de Dieulafoy.
- 5) En caso de intervención quirúrgica es obligatoria la práctica de una vagotomía troncular.

Respuesta correcta: 3

P070 MIR 2015-2016

¿Cuál de las siguientes técnicas de endoscopia digestiva está asociada a mayor riesgo de complicaciones mayores?

- 1) Endoscopia digestiva alta diagnóstica.
- 2) Esclerosis de varices esofágicas.
- 3) Colonoscopia diagnóstica en paciente con dolico colon.
- 4) Polipectomía de pólipo en colon descendente de morfología sésil.

Respuesta correcta: 2

P073 MIR 2015-2016

Un hombre de 52 años, sin enfermedades concomitantes, acude a urgencias por melenas de 24 horas de evolución sin repercusión hemodinámica. Niega consumo de antiinflamatorios no esteroideos. El hematocrito es de 33% y el resto de la analítica es normal. La endoscopia digestiva alta, realizada de forma urgente a las 6 horas del ingreso, muestra un estómago normal, sin sangre ni restos hemáticos y una úlcera excavada de 8 mm de diámetro en cara anterior del bulbo duodenal con "vaso visible" en su base, sin sangrado activo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- 1) En la endoscopia inicial, está indicado aplicar una terapéutica endoscópica, y posteriormente instaurar tratamiento en-

dovenoso con dosis altas de un inhibidor de la bomba de protones. Esta estrategia ha demostrado reducir el riesgo de recidiva hemorrágica y la mortalidad.

- 2) En la endoscopia inicial, dada la ausencia de sangrado activo, no está indicado aplicar una terapéutica endoscópica. Posteriormente, para reducir el riesgo de recidiva hemorrágica, se deberá instaurar tratamiento endovenoso con dosis altas de un inhibidor de la bomba de protones.
- 3) En la endoscopia inicial, está indicado aplicar una terapéutica endoscópica. No se ha podido demostrar que instaurar posteriormente tratamiento endovenoso con dosis altas de un inhibidor de la bomba de protones aporte beneficio adicional alguno.
- 4) Dado que se trata de una úlcera complicada (hemorragia), la mejor opción terapéutica, una vez resuelto el episodio hemorrágico, es una vagotomía y piloroplastia.

Respuesta correcta: 1

P075 MIR 2016-2017

Un hombre de 57 años de edad con artritis reumatoide sigue tratamiento habitual con corticoides. Está en estudio por presentar un cuadro de dolor en epigastrio, con náuseas ocasionales y disminución del apetito. En la analítica presenta: Hb 15 g/dL, Fe 55 mcg/dL, PCR 3 mg/dL, VSG 42 mm a la primera hora. Fibrogastroscoopia: hernia de hiato de 3 cm y una úlcera a nivel del antro, excavada, de 1 cm, con bordes elevados y regulares y con confluencia de pliegues, que se biopsia. El estudio histológico muestra signos de inflamación aguda y metaplasia intestinal. TC abdominal normal. ¿Qué actitud, de las que se mencionan a continuación, considera que es la **MÁS ADECUADA** para el tratamiento de este paciente?

- 1) Tratamiento erradicador del *Helicobacter pylori*.
- 2) Tratamiento con inhibidores de la bomba de protones y una gastroscopia de control con biopsia a las 8 semanas.
- 3) Suspender corticoides.
- 4) Tratamiento quirúrgico (Billroth I).

Respuesta correcta: 2

P076 MIR 2016-2017

Paciente de 63 años con antecedentes familiares de primer grado de cáncer colorrectal a los 56 años. En sus antecedentes personales destaca un episodio de rectorragia secundaria a síndrome hemorroidal hace 15 años por lo que se realizó una colonoscopia que fue normal y no ha vuelto a presentar rectorragia. Acude a urgencias por episodio de hematoquecia. FC 120 lpm y PA 70/40 mmHg. El análisis de sangre muestra hemoglobina de 8 g/dL. Señale la respuesta INCORRECTA en lo que respecta al manejo de este paciente:

- 1) Aún si no se logra la estabilidad hemodinámica hay que insistir en la preparación del colon.
- 2) Si la colonoscopia es normal, una endoscopia digestiva alta puede dar el diagnóstico en el 10-15% de los casos.
- 3) La colonoscopia es la exploración con la mejor relación coste/efectividad por su seguridad, sensibilidad y potencial terapéutico.
- 4) La gammagrafía con Tc99m es de contrastada utilidad si se sospecha un divertículo de Meckel.

Respuesta correcta: 1

P082 MIR 2017-2018

Hombre de 35 años, sin antecedentes patológicos de interés, que acude a Urgencias por presentar un cuadro de inestabilidad tras un episodio de deposiciones negras como el alquitrán. En la sala de Urgencias se objetiva hipotensión arterial que se recupera con fluidoterapia convencional. Hemoglobina al ingreso 8 g/dL, hematocrito 25%. En los siguientes días continúa con episodios melánicos y descenso del hematocrito que necesitan la transfusión de 3 concentrados de hemáties. Se practicó colonoscopia y endoscopia digestiva alta, no encontrando causa alguna de su cuadro hemorrágico. Tras una semana de ingreso hospitalario y la transfusión de 4 unidades de concentrados de hemáties continúa con melenas. El SIGUIENTE paso a seguir es:

- 1) Intervención quirúrgica inmediata.
- 2) Cápsula endoscópica.
- 3) Enteroscopia quirúrgica.

- 4) Continuar con tratamiento conservador y solicitar arteriografía.

Respuesta correcta: 2

P082 MIR 2018-2019

Mujer de 70 años con antecedentes de consumo de AINES que acude a Urgencias refiriendo melenas de 24 horas de evolución. A la exploración física, llama la atención una marcada palidez cutáneo-mucosa, con FC de 124 lpm y PA de 80/40 mmHg. ¿Cuál es la PRIMERA medida a tomar?

- 1) Interrogar a la paciente sobre sus antecedentes (AINEs, dosis, tipo, tiempo de consumo, historia ulcerosa previa, antecedente de hemorragia digestiva, etc.) y realizar tacto rectal.
- 2) Colocar sonda nasogástrica con lavado previo a la realización de endoscopia.
- 3) Realizar inmediatamente una endoscopia digestiva para establecer el diagnóstico y aplicar el tratamiento hemostático.
- 4) Canalizar al menos una vía periférica de grueso calibre para infusión de volumen y obtener determinaciones analíticas básicas.

Respuesta correcta: 4

P056 MIR 2022-2023

En un paciente con una úlcera duodenal y alto riesgo cardiovascular por cardiopatía isquémica, en caso de requerir tratamiento con un AINE, ¿cuál de los siguientes le recomendaría como MÁS seguro?

- 1) Naproxeno.
- 2) Celecoxib.
- 3) Ketorolaco.
- 4) Ibuprofeno.

Respuesta correcta: 1

P023 MIR 2025-2026

Paciente de 53 años sin antecedentes de interés, que acude a Urgencias por epigastralgia intensa que irradia difusamente al resto del abdomen. Había consultado en Urgencias tres días antes y se le dio el alta con paracetamol, que fue efectivo. Vuelve a acudir ahora por persistencia del dolor con sensación distérmica, náuseas y vómitos que condicionan la ingesta oral.



En la exploración tiene un abdomen duro con dolor difuso que mejora con la flexión ventral del tronco. Se le realiza una radiografía de abdomen en la que se observa lo que muestra la imagen vinculada. ¿Cuál es la principal sospecha diagnóstica?

- 1) Obstrucción de intestino grueso.
- 2) Perforación gástrica.
- 3) Suboclusión de intestino delgado.
- 4) Íleo adinámico.

Respuesta correcta: 2

P147 MIR 2025-2026

Mujer de 72 años, con antecedentes personales de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y artrosis. Toma antiinflamatorio no esteroideo clásico diario y ácido acetilsalicílico a baja dosis. Acude a Urgencias por presentar melenas. En la endoscopia de Urgencias se objetiva una úlcera gástrica Forrest III en curvatura menor, con biopsias negativas para malignidad y *Helicobacter pylori* negativo. ¿Cuál sería la conducta MÁS adecuada a medio plazo?

- 1) Reiniciar antiinflamatorio no esteroideo y ácido acetilsalicílico igual, con inhibidor de la bomba de protones dos semanas.
- 2) Mantener el inhibidor de la bomba de protones a dosis plenas, reevaluar la necesidad de antiinflamatorio no esteroideo y realizar una endoscopia de control para confirmar cicatrización.
- 3) Cambiar inhibidor de la bomba de protones por anti- H_2 .
- 4) Cambiar antiinflamatorio no esteroideo por paracetamol e inhibidor de la bomba de protones a demanda.

Respuesta correcta: 2

T11 Tumores gástricos. Complicaciones de la cirugía gástrica

P226 MIR 2009-2010

¿Cuál de los siguientes factores aumenta el riesgo de cáncer gástrico?

- 1) Dieta rica en grasas animales.
- 2) Rasgo genético con disminución de interleuquina 1.

- 3) Cepas de *Helicobacter pylori* cagA+.
- 4) Gastrectomía parcial de causa benigna reciente (menos de 5 años).
- 5) Hiperclorhidria.

Respuesta correcta: 3

P039 MIR 2010-2011

¿En cuál de las siguientes neoplasias gástricas en estadio incipiente, se puede considerar como primera opción terapéutica la erradicación de *H. pylori* con anti-bioterapia e inhibidores de la bomba de protones?

- 1) Adenocarcinoma gástrico tipo difuso.
- 2) Adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal.
- 3) Linfoma MALT gástrico.
- 4) Linfoma alto grado gástrico.
- 5) Linfoma de Hodgkin gástrico.

Respuesta correcta: 3

P003 MIR 2012-2013

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. Hombre de 57 años que acude al Servicio de Urgencias por melenas. En endoscopia alta se objetiva a nivel de la segunda porción de duodeno una masa con ulceración de la superficie intestinal en varios puntos. En la imagen radiológica del TAC (imagen nº 2) se objetiva un gran tumor dependiente de intestino delgado, abigarrado, con zonas de necrosis en su interior, con un diámetro mayor de 13 cm. Asimismo se observan múltiples metástasis hepáticas. En la biopsia que se toma durante la gastroscopia, se aprecian células fusiformes con inmunohistoquímica positiva para CD117 (c-Kit). ¿Cuál es el diagnóstico del paciente?

- 1) Adenocarcinoma de intestino delgado estadio IV.
- 2) Tumor Neuroendocrino Gastrointestinal (Carcinoide).
- 3) Tumor de Krukenberg.
- 4) Tumor del estroma gastrointestinal (GIST).
- 5) Linfoma gástrico de tipo MALT.

Respuesta correcta: 4

P004 MIR 2012-2013

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. En referencia al paciente del caso clínico an-

terior, señale cuál es la opción terapéutica más apropiada para el tratamiento sistémico de su tumor:

- 1) Imatinib.
- 2) Doxorubicina.
- 3) Lapatinib.
- 4) Bevacizumab.
- 5) Cisplatino y paclitaxel.

Respuesta correcta: 1

P227 MIR 2012-2013

¿Cuál de las siguientes NO puede ser considerada una condición premaligna de cáncer del aparato digestivo?

- 1) Adenoma de colon.
- 2) Esofagitis cáustica.
- 3) Úlcera gástrica.
- 4) Anemia Perniciosa.
- 5) Esófago de Barrett.

Respuesta correcta: 3

P085 MIR 2013-2014

Respecto a los tumores del estroma gastrointestinal (GIST), es cierto que:

- 1) Se trata de tumores de origen epitelial, localizados sobre todo a nivel de la mucosa del tubo digestivo.
- 2) Es característico de estos tumores la mutación del gen c-kit, que codifica un receptor tirosina-cinasa.
- 3) El tratamiento de los tumores localizados menores de 2 cm es fundamentalmente médico, con el empleo de Imatinib.
- 4) Son tumores que sólo excepcionalmente sangran.
- 5) La localización más frecuente de estos tumores es el intestino delgado.

Respuesta correcta: 2

P091 MIR 2013-2014

A un hombre de 45 años de edad se le realiza una vagotomía troncular y antrectomía con reconstrucción tipo Billroth II por padecer una enfermedad ulcerosa péptica crónica con estenosis piloro-duodenal. Seis semanas después de la cirugía, refiere que poco tiempo después (menos de media hora) de las ingestas presenta estado

nauseoso, astenia y sudoración, mareos y retortijones abdominales, generalmente acompañados de deshechos diarreicos. ¿Cuál de las siguientes es la actitud más adecuada para su manejo inicial?

- 1) Aplicar tratamiento con un análogo de la somatostatina (octreótido).
- 2) Seguir unas medidas dietéticas concretas.
- 3) Realizar un tratamiento de prueba con una benzodiacepina.
- 4) Realizar la búsqueda de un probable tumor neuroendocrino (p.ej. carcinoide).
- 5) Indicar tratamiento quirúrgico para efectuar una gastro-yeyunostomía antiperistáltica en Y de Roux.

Respuesta correcta: 2

P040 MIR 2014-2015

¿En cuál de estos pacientes el tratamiento quirúrgico adecuado sería la realización de una gastrectomía atípica en cuña por laparoscopia sin linfadenectomía ampliada?

- 1) Adenocarcinoma gástrico infiltrante y ulcerado a nivel de antro-píloro.
- 2) Adenocarcinoma gástrico infiltrante subcardial.
- 3) Tumor del estroma gastrointestinal a nivel de cuerpo gástrico-curvatura mayor.
- 4) Linfoma MALT.
- 5) Esófago de Barret con metaplasia intestinal y displasia.

Respuesta correcta: 3

P065 MIR 2015-2016

Señale, de entre las siguientes, la complicación más probable que presenta el paciente, intervenido, hace 20 años, de úlcera gástrica mediante antrectomía y gastroyeyunostomía (Billroth II), que acude a su consulta refiriendo dolor abdominal postprandial, distensión abdominal, diarrea y datos analíticos de malabsorción de grasas y de vitamina B₁₂:

- 1) Gastropatía por reflujo biliar.
- 2) Adenocarcinoma gástrico.
- 3) Síndrome de evacuación gástrica rápida (*dumping*).
- 4) Síndrome de asa aferente con sobrecrecimiento bacteriano.

Respuesta correcta: 4

P182 MIR 2019-2020

Hombre de 60 años con un cuadro de dolor abdominal y sangrado digestivo alto, en quien se encuentra una tumoración abdominal relacionada con la pared gástrica. La histología muestra un tumor de células fusiformes con escasas mitosis, positivas para CD117. El diagnóstico MÁS probable es:

- 1) Neurofibroma de la pared gástrica.
- 2) Tumor del estroma gastrointestinal.
- 3) Leiomioma.
- 4) Sarcoma granulocítico.

Respuesta correcta: 2

P003 MIR 2020-2021

Pregunta vinculada a la imagen nº 3. Mujer de 60 años, sin antecedentes patológicos de interés, que acude al hospital por pirosis. Durante el proceso diagnóstico se observa en un TC toracoabdominal una lesión nodular de 3 cm en la pared posterior de la región cardial, por lo que se le realiza una resección gástrica atípica. Se muestran dos imágenes, una macroscópica y otra microscópica (imagen vinculada). Las tinciones inmunohistoquímicas de la lesión son positivas para c-KIT y DOG1, y negativas para citoqueratinas, actina, desmina y S100. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico de la lesión gástrica?

- 1) Leiomiosarcoma.
- 2) Tumor del estroma gastrointestinal.
- 3) Schwannoma.
- 4) Adenocarcinoma poco diferenciado.

Respuesta correcta: 2

P156 MIR 2020-2021

Paciente de 46 años intervenido hace un año de gastrectomía Billroth II por úlcera péptica. Presenta un cuadro de dolor epigástrico y hemorragia digestiva alta. En la endoscopia se detectan úlceras tanto en estómago como en intestino delgado. Tras realizar estimulación con secretina i.v. no se aprecia aumento significativo de gastrina sérica. El cuadro corresponde MUY PROBABLEMENTE a:

- 1) Gastrinoma.
- 2) Síndrome de antro retenido.

- 3) Síndrome de asa aferente.
- 4) Carcinoma de muñón gástrico.

Respuesta correcta: 2

P017 MIR 2021-2022

Pregunta vinculada a la imagen nº 17. Varón de 74 años, sin antecedentes de interés, que consulta por presentar desde hace 15 días sensación continua de distensión abdominal e intolerancia oral con vómitos ocasionales de contenido maloliente. En la analítica únicamente destacan glucemia 110 mg/dL, PCR 6,3 mg/L (normal 0-5) y 13.140 leucocitos/mcL. Se le realiza TC abdominal con contraste intravenoso (imagen vinculada). Considerando los datos clínicos y la prueba de imagen ¿qué diagnóstico de los siguientes es MÁS probable?

- 1) Obstrucción gástrica por neoplasia antro-pilórica.
- 2) Gastritis enfisematosa.
- 3) Gastroparesia diabética.
- 4) Úlcera péptica con signos de perforación contenida.

Respuesta correcta: 1

T12 Cirugía bariátrica y cirugía metabólica

P093 MIR 2016-2017

Mujer de 43 años intervenida hace 6 años de obesidad mórbida mediante una técnica de derivación biliopancreática. Ha perdido un 75% del exceso de peso y mantiene una dieta oral de 1500 Kcal sin ningún problema en su tolerancia. Señale qué suplementación NO sería necesaria en esta paciente:

- 1) Hierro.
- 2) Calcio.
- 3) Vitamina D.
- 4) Suplemento proteico.

Respuesta correcta: 4

P093 MIR 2025-2026

En relación con las indicaciones de cirugía bariátrica, señale la CORRECTA.



- 1) El IMC es la mejor medida de correlación entre exceso de peso y gravedad de la enfermedad.
- 2) El IMC es una medida útil, pero que no se utiliza para la indicación de cirugía bariátrica.
- 3) El punto de corte del IMC es de 55, independientemente de las enfermedades asociadas.
- 4) Pacientes con IMC por debajo de 35 y enfermedades metabólicas poco controladas se pueden beneficiar de la cirugía bariátrica.

Respuesta correcta: 4

T13 Fisiología y fisiopatología intestinal

P045 MIR 2012-2013

¿En cuál de las siguientes entidades que se enumeran a continuación NO es característico la presencia de signos o síntomas de malabsorción?

- 1) Enfermedad de Whipple.
- 2) Linfangiectasia intestinal.
- 3) Esprúe celiaco.
- 4) Abetalipoproteinemia.
- 5) Enfermedad de Wilson.

Respuesta correcta: 5

P144 MIR 2025-2026

Un paciente de 56 años ha perdido 10 kg en el último año coincidiendo con un notable aumento de las deposiciones, que son pastosas, amarillas y flotantes. Presenta dolor epigástrico-mesogástrico posprandial que limita la ingesta. Hace cuatro años recibió tratamiento erradicador de *Helicobacter pylori* por úlcera duodenal recidivante. ¿Cuál de las siguientes exploraciones en heces le parece más útil en el primer estudio para orientar el diagnóstico?

- 1) Estudio coproparasitario.
- 2) Aclaramiento fecal de alfa-1-antitripsina.
- 3) Determinación de antígeno de *Helicobacter pylori* en heces.
- 4) Cuantificación de elastasa fecal.

Respuesta correcta: 4

T14 Síndromes malabsortivos

P027 MIR 2009-2010

Los linfomas del intestino delgado tienen los siguientes caracteres EXCEPTO:

- 1) El origen suele ser el linfocito T.
- 2) Se localizan más frecuentemente en el duodeno.
- 3) Se relacionan con la malabsorción crónica.
- 4) Se relacionan con el trasplante de órganos.
- 5) Se relacionan con el SIDA.

Respuesta correcta: Anulada

P034 MIR 2010-2011

Mujer de 27 años en estudio en el Servicio de Dermatología por presentar episodios de aftas bucales recidivantes. Es remitida a las consultas de Aparato Digestivo por objetivar en una analítica: Hb 11,5 g/dL, Hto 35%, Fe 38 µg/dL, AST 52 U/L, ALT 64 U/L, Ac antitransglutaminasa IgA 177 U/mL. La paciente sólo refiere presentar molestias abdominales difusas de forma ocasional. No refiere diarrea, signos de hemorragia ni ictericia. La exploración física es normal. ¿Qué prueba de las que se mencionan a continuación considera que es la más adecuada para realizar el diagnóstico?

- 1) Cápsula endoscópica.
- 2) Colonoscopia.
- 3) Serología para virus de la hepatitis B y C.
- 4) Biopsia intestinal.
- 5) Ecografía abdominal.

Respuesta correcta: 4

P080 MIR 2013-2014

A un hombre de 55 años, padre de un hijo celiaco, con anemia ferropénica y aumento reciente del ritmo deposicional, se le ha realizado una determinación de los alelos HLA-DQ2 y HLA-DQ8 que ha resultado negativa. ¿Qué estudio diagnóstico es el más apropiado en este caso?

- 1) Determinación de anticuerpos antitransglutaminasa IgA.
- 2) Endoscopia digestiva alta con toma de biopsias duodenales.

- 3) Test de D-xilosa.
- 4) Evaluar la respuesta a dieta sin gluten.
- 5) Colonoscopia.

Respuesta correcta: 5

P033 MIR 2014-2015

Pregunta vinculada a la imagen nº 17. Recibe usted la biopsia del duodeno de una mujer de 38 años sin otros datos clínicos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Linfoma intestinal: infiltración de la lámina propia y del epitelio superficial por una población celular linfocítica monótona.
- 2) Enteropatía sensible al gluten (celiaquía): atrofia de vellosidades intestinales, aumento del infiltrado inflamatorio y linfocitosis intraepitelial.
- 3) Linfangiectasias: dilatación de vasos linfáticos situados en la lámina propia de la mucosa.
- 4) Enfermedad de Whipple: acúmulos de macrófagos de citoplasma amplio y microvacuolado en la lámina propia de la mucosa.
- 5) Giardiasis: presencia de trofozoítos de *Giardia lamblia* en la superficie intestinal.

Respuesta correcta: 2

P034 MIR 2014-2015

Pregunta vinculada a la imagen nº 17. Según el diagnóstico emitido en la pregunta anterior, ¿Cuál es la mejor opción terapéutica?

- 1) Dieta rica en proteínas y baja en grasas.
- 2) Metronidazol.
- 3) Trimetoprim y sulfametoxazol.
- 4) Quimioterapia.
- 5) Dieta libre de gluten.

Respuesta correcta: 5

P093 MIR 2014-2015

La dieta sin gluten es el pilar fundamental en el tratamiento de la enfermedad celíaca. Al respecto, son numerosos los productos manufacturados con una composición incierta en cuanto al gluten, siendo frecuente encontrar etiquetados engañosos. De los siguientes grupos de alimentos ¿Cuál podemos considerar completamente seguro en la dieta de un paciente celiaco?

- 1) Conservas de carne: Hamburguesas, albóndigas.
- 2) Leche y derivados: yogur, queso, nata, cuajada.
- 3) Salsas, condimentos y aditivos alimentarios.
- 4) Pasta integral: fideos, macarrones, tallarines.
- 5) Productos de charcutería, embutidos, patés.

Respuesta correcta: 2

P047 MIR 2015-2016

Indique la variante genética del HLA que expresa el 90% de los pacientes celíacos:

- 1) DQ8.
- 2) DQ2.
- 3) B27.
- 4) B12.

Respuesta correcta: 2

P078 MIR 2015-2016

¿Cuál de las siguientes enfermedades NO se asocia a sobrecrecimiento bacteriano?

- 1) Enfermedad celíaca.
- 2) Esclerosis sistémica.
- 3) Divertículos yeyunales.
- 4) Enteritis por radiación.

Respuesta correcta: 1

P081 MIR 2016-2017

Ante la sospecha diagnóstica de sobrecrecimiento bacteriano intestinal, todas las siguientes afirmaciones son ciertas EXCEPTO:

- 1) La biopsia es la prueba diagnóstica.
- 2) Presencia de anemia.
- 3) Antecedentes de cirugía gastrointestinal.
- 4) Presencia de diarrea.

Respuesta correcta: 1

P082 MIR 2016-2017

Acerca de la enfermedad celíaca, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- 1) Los estudios serológicos para el diagnóstico de enfermedad celíaca se deben rea-

lizar con el individuo realizando una dieta que incluya gluten.

- 2) La causa más común de persistencia de títulos serológicos elevados es la ausencia de cumplimiento dietético o la ingesta inadvertida de gluten.
- 3) El test serológico inicial de cribado de enfermedad celíaca es la IgA antitransglutaminasa.
- 4) La investigación de HLA-DQ2/DQ8 se debe de emplear de rutina para descartar la existencia de enfermedad celíaca.

Respuesta correcta: 4

P085 MIR 2017-2018

Joven de 24 años que presenta anemia ferropénica crónica de origen no filiado, con ileocolonoscopia y esofagogastroduodenoscopia sin lesiones. Se realiza estudio con cápsula endoscópica, observando úlceras aisladas a nivel de yeyuno distal. ¿En cuál de las siguientes enfermedades se encuentran estas lesiones?

- 1) Enfermedad de Whipple.
- 2) Neumatosis quística intestinal.
- 3) Esprúe celíaco refractario.
- 4) Enteritis eosinofílica.

Respuesta correcta: 3

P081 MIR 2019-2020

En relación con la enfermedad celíaca, señale la afirmación CORRECTA:

- 1) Es necesaria la confirmación con biopsia intestinal para un diagnóstico definitivo.
- 2) La genética (DQ2/DQ8) tiene un elevado valor predictivo negativo.
- 3) Las personas con síndrome de Prader-Willi tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad celíaca que la población general.
- 4) Es frecuente adquirir tolerancia al gluten con la edad.

Respuesta correcta: 2

P150 MIR 2020-2021

Varón de 83 años que consulta por un cuadro recurrente de dolor abdominal en fosa iliaca izquierda, acompañado de diarrea de hasta 6 deposiciones al día sin productos patológicos, de 10-15 días

de evolución. No refiere fiebre ni afectación del estado general. En una analítica reciente no se observa leucocitosis y presenta una sangre oculta en heces negativa. En la exploración se observa leve dolor a la palpación de fosa iliaca izquierda sin irritación peritoneal. Tiene realizada una colonoscopia hace tres años en la que se informa de divertículos a lo largo de todo el colon, más numerosos en colon izquierdo, sin otras lesiones asociadas. De las siguientes, ¿Cuál sería la MEJOR actitud a seguir?

- 1) Realizar un tratamiento empírico con antibióticos.
- 2) Solicitar una colonoscopia preferente.
- 3) Solicitar una ecografía abdominal urgente.
- 4) Derivar a cirugía para valorar sigmoidectomía.

Respuesta correcta: 1

P151 MIR 2025-2026

Paciente con 23 años, que quiere saber si es celíaco, porque su madre lo es. Pregunta sobre el estudio genético. Respecto al papel del estudio genético HLA-DQ2/DQ8 en enfermedad celíaca, señale la opción CORRECTA:

- 1) Es una prueba diagnóstica confirmatoria cuando es positiva.
- 2) Un resultado negativo para HLA-DQ2 y HLA-DQ8 hace muy improbable el diagnóstico de enfermedad celíaca.
- 3) Solo es útil en el cribado poblacional general.
- 4) Debe solicitarse de rutina en todos los pacientes con serología positiva.

Respuesta correcta: 2

T15 Diarrea crónica

P083 MIR 2018-2019

Hombre de 40 años que viaja por turismo al Caribe. A la semana de su regreso presenta de 3 a 4 deposiciones líquidas diarias, acuosas, sin productos patológicos, así como dolor abdominal y malestar general. El médico que le atiende le prescribe hidratación oral y le propone la administración de una quinolona. ¿Con qué finalidad?



- 1) Acortar la duración de la diarrea.
- 2) Disminuir la mortalidad.
- 3) Evitar la aparición de complicaciones intraabdominales.
- 4) Evitar la diseminación séptica a distancia.

Respuesta correcta: 1

P084 MIR 2018-2019

Señale la afirmación **INCORRECTA** con respecto a un síndrome diarreico:

- 1) La presencia de sangre en heces y fiebre permiten establecer el diagnóstico de gastroenteritis bacteriana.
- 2) La diarrea osmótica suele autolimitarse después de un ayuno de 48 horas.
- 3) La diarrea secretora se caracteriza por heces voluminosas y acuosas, con gradiente de la osmolaridad entre las heces y el plasma pequeño.
- 4) La diarrea motora por hiperperistaltismo suele interpretarse como una respuesta fisiológica del intestino frente a diversas agresiones (contenido extraño, comida en malas condiciones, etc.).

Respuesta correcta: 1

T16 Enfermedad inflamatoria intestinal y otras alteraciones intestinales

P029 MIR 2009-2010

Acude a nuestra consulta un paciente de 45 años, diagnosticado previamente de colitis ulcerosa cortico dependiente e intervenido mediante proctocolectomía con creación de reservorio ileoanal hace un mes con un postoperatorio no complicado. ¿Cuál de las siguientes es la complicación más importante y frecuente derivada de esta intervención a la que deberemos prestar atención?

- 1) Aparición de reservoritis.
- 2) Aparición de yeyunitis ulcerativa.
- 3) Aparición de gastroduodenitis.
- 4) Aparición de esofagitis por citomegalovirus.
- 5) Aparición de absceso pélvico.

Respuesta correcta: 1

P030 MIR 2009-2010

En el tratamiento de mantenimiento a largo plazo en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, ¿Cuál de los siguientes fármacos es el menos recomendable?

- 1) Azatioprina.
- 2) Mesalazina.
- 3) Prednisona.
- 4) 6-Mercaptopurina.
- 5) Metotrexato.

Respuesta correcta: 3

P033 MIR 2010-2011

En relación con las indicaciones de cirugía en la enfermedad inflamatoria intestinal, señalar la respuesta incorrecta:

- 1) Muchos pacientes con enfermedad de Crohn van a requerir cirugía en algún momento de su evolución.
- 2) Las indicaciones quirúrgicas de la enfermedad de Crohn se limitan a las complicaciones.
- 3) La solución habitual del megacolon tóxico es quirúrgica.
- 4) En el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa la resección debe limitarse únicamente al segmento de colon afectado.
- 5) Las complicaciones extraintestinales de la EII suelen remitir tras la resección del intestino dañado, con excepción de la espondilitis anquilosante y las complicaciones hepáticas.

Respuesta correcta: 4

P041 MIR 2010-2011

La colitis ulcerosa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC) son dos trastornos inflamatorios crónicos y diferenciados de causa desconocida. Para establecer el diagnóstico diferencial entre ambas hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones excepto una:

- 1) La CU afecta el colon y la EC puede afectar todo el tracto digestivo.
- 2) En la EC las lesiones suelen ser focales. Segmentarias y asimétricas.
- 3) En la EC existen tres patrones de presentación clínica: inflamatorio, fistulizante y obstructivo.

- 4) La colonoscopia y la biopsia definen la extensión, siendo posible realizar el diagnóstico diferencial entre ambas.
- 5) El diagnóstico diferencial debe realizarse con el linfoma.

Respuesta correcta: 4

P033 MIR 2011-2012

Cuál de los siguientes datos clínicos, registrados durante la realización de la historia clínica de un paciente con diarrea de más de 4 semanas de evolución, puede ser encontrado en personas sin patología orgánica:

- 1) Pérdida de peso con o sin rectorragia.
- 2) Persistencia de la diarrea durante la noche.
- 3) Inicio de los síntomas después de los 50 años.
- 4) Presencia durante la exploración de dermatitis y/o artritis.
- 5) Expulsión de moco en más del 25% de las defecaciones.

Respuesta correcta: 5

P034 MIR 2011-2012

Un muchacho de 17 años de edad con enfermedad de Crohn con afectación colónica de 2 años de evolución, en tratamiento de mantenimiento con azatioprina, consulta por la aparición desde hace 5 días de nódulos subcutáneos rojo-violáceos, calientes, dolorosos, de localización pretibial, bilaterales asociados a un incremento del número de deposiciones y dolor abdominal. La actitud más adecuada en este caso es:

- 1) Recomendar reposo relativo y paños calientes en ambas piernas y añadir tratamiento antidepresivo.
- 2) Biopsiar zonas de piel alejadas de las áreas lesionadas y pautar analgésicos opioides de entrada.
- 3) Sospechar la existencia de una lesión tumoral maligna intestinal como desencadenante del proceso cutáneo.
- 4) Sospechar isquemia bilateral de extremidades inferiores de origen medicamentoso.
- 5) Ajuste del tratamiento de la enfermedad intestinal.

Respuesta correcta: 5

P226 MIR 2011-2012

La intervención quirúrgica más adecuada para un paciente con megacolon tóxico en el contexto de una colitis ulcerosa es:

- 1) Una hemicolectomía izquierda.
- 2) Una colectomía total con anastomosis ileorrectal.
- 3) Una colectomía total con ileostomía terminal.
- 4) Una proctocolectomía total y anastomosis ileoanal con reservorio ileal.
- 5) Una ileostomía terminal manteniendo el colon en reposo.

Respuesta correcta: 3

P001 MIR 2012-2013

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. Hombre de 35 años, ex fumador desde hace 3 meses, que presenta un cuadro de 1 mes de evolución de aumento del número de deposiciones, hasta 15 diarias, blandas, con sangre mezclada, así como molestias abdominales, urgencia defecatoria y tenesmo. En las últimas 48 horas presenta fiebre de hasta 38,5 °C, motivo por el cual acude a Urgencias. En la exploración destaca presión arterial de 85/50 mmHg y frecuencia cardíaca de 120 lpm. El hemograma muestra una cifra de hemoglobina de 8 g/dL, leucocitos 12.400 por microlitro, plaquetas 435.000 por microlitro. La PCR es de 9 mg/dL. El estudio microbiológico de las heces, incluyendo coprocultivo, examen de parásitos y determinación de toxina de *Clostridium difficile* es negativo. La endoscopia muestra a lo largo de todo el colon la imagen que se muestra en la imagen nº 1. El examen histológico demuestra la presencia de un proceso inflamatorio crónico, con áreas de infiltración polimorfonuclear, abscesos crípticos y depleción de células caliciformes. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección del cuadro clínico que más probablemente presenta el paciente?

- 1) Mesalazina 4.5 gramos diarios v.o.
- 2) Mesalazina 4.5 gramos diarios v.o. y mesalazina 1 gramo diario rectal.
- 3) Metilprednisolona 1 mg/kg/día por vía oral, si el paciente tolera esta vía.
- 4) Azatioprina 2.5 mg/kg/d por vía oral, repartidos en 3 tomas.

- 5) Infliximab 5 mg/kg, con dosis posteriores de mantenimiento cada 8 semanas.

Respuesta correcta: 3

P002 MIR 2012-2013

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. El paciente del caso anterior, estando en remisión clínica y ante la elevación persistente de enzimas de colestasis, es diagnosticado 4 años más tarde de colangitis esclerosante primaria mediante colangiorresonancia magnética; ¿Cuándo debe indicar iniciar un programa de cribado de carcinoma colorrectal mediante colonoscopia anual?

- 1) A la edad habitual del cribado en la población general, 50 años.
- 2) 10 años antes de la edad habitual recomendada para el cribado en la población general.
- 3) A los 20 años de evolución de la enfermedad.
- 4) Entre los 8 y 10 años de evolución de la enfermedad.
- 5) En el momento del diagnóstico de la colangitis esclerosante.

Respuesta correcta: 5

P082 MIR 2013-2014

Mujer de 37 años, afecta de una colitis ulcerosa extensa, presenta un brote grave por el que se inicia tratamiento con prednisona en dosis de 1 mg/kg. Tras una semana de tratamiento, la paciente no presenta mejoría. ¿Cuál es la siguiente medida terapéutica a realizar?

- 1) Colectomía subtotal de urgencia y, en un segundo tiempo, proctectomía y reservorio ileoanal.
- 2) Asociar un inmunosupresor como azatioprina.
- 3) Asociar mesalazina en dosis de 4 gramos al día oral y triamcinolona rectal, 1 aplicación cada 12 horas.
- 4) Ciclosporina endovenosa 2 mg/kg.
- 5) Debe valorarse el tratamiento con etanercept (un anticuerpo anti-TNFα).

Respuesta correcta: 4

P088 MIR 2013-2014

Ante un paciente con enfermedad de Crohn que va a comenzar tratamiento con terapia biológica antiTNF (anticuerpos anti factor de necrosis tumoral alfa), ¿Cuál de las siguientes pruebas diagnósticas NO es necesaria antes de iniciar dicha terapia?

- 1) Valoración del estadio inmunitario mediante conteo linfocitario.
- 2) Serología del virus de hepatitis B (VHB).
- 3) Prueba de la tuberculina.
- 4) Radiografía de tórax.
- 5) Serología del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Respuesta correcta: 1

P038 MIR 2014-2015

A un paciente con colitis ulcerosa con afectación hasta el colon transversal se le realiza una colonoscopia de cribado de cáncer colorrectal. La colonoscopia no muestra signos de actividad inflamatoria. Se realizaron múltiples biopsias cada 10 cm. Las biopsias fueron revisadas por 2 patólogos expertos demostrando un foco de displasia de alto grado en una de las biopsias realizadas en el colon sigmoide. ¿Qué indicaría a continuación?

- 1) Repetir la colonoscopia para confirmar el diagnóstico.
- 2) Vigilancia intensiva con colonoscopia cada 3 a 6 meses.
- 3) Repetir la exploración y realizar una cromosondoscopia para identificar la lesión y realizar una mucosectomía endoscópica.
- 4) Proctocolectomía total.
- 5) Tratamiento con mesalazina a dosis de 2-3 gramos al día y repetir la exploración a los 3 a 6 meses.

Respuesta correcta: 4

P011 MIR 2015-2016

Pregunta vinculada a la imagen nº 11. Mujer de 29 años que presenta dolor abdominal mesogástrico, continuo, de cinco días de evolución. Se realiza un estudio de imagen mediante tomografía computarizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Invaginación ileocólica.
- 2) Ileítis isquémica.



- 3) Enfermedad de Crohn.
- 4) Colitis r dica.

Respuesta correcta: 3

P032 MIR 2015-2016

Mujer de 59 a os que presenta diarrea cr nica acuosa de 4 meses de evoluci n. En la endoscopia, la mucosa no mostraba aspectos relevantes. En concreto, no se observaron  lceras o  rea friables. Se realiz  biopsia del colon transverso. En el estudio histopatol gico se reconoci  un  rea engrosada por debajo del epitelio de revestimiento superficial, que era m s evidente mediante t cnica de tricr mico de Masson, y que conllevaba atrofia y desnudaci n epitelial. Tambi n se apreci  un claro incremento en la densidad de linfocitos intraepiteliales. El diagn stico de la lesi n intestinal es:

- 1) Colitis ulcerosa cr nificada.
- 2) Colitis pseudomembranosa.
- 3) Colitis col gena.
- 4) Enfermedad de Crohn fibrosante.

Respuesta correcta: 3

P069 MIR 2015-2016

Un hombre de 60 a os de edad, con colitis ulcerosa extensa de 15 a os de evoluci n y en remisi n cl nica los  ltimos 3 a os, acude a nuestra consulta para informarse sobre el riesgo de c ncer colorrectal y sobre la posibilidad de participar en programas de prevenci n. Es correcto informarle que:

- 1) La colitis ulcerosa solo se asocia a un incremento en el riesgo de c ncer colorrectal en fumadores.
- 2) En su caso, dado que est  en remisi n de larga duraci n, se considera adecuado el cribado aconsejado en la poblaci n general.
- 3) En casos como el suyo, se considera adecuado someterse a colonoscopias peri dicas con toma de m ltiples biopsias escalonadas a lo largo de todo el colon.
- 4) En casos como el suyo, se considera adecuado el cribado mediante estudios peri dicos de sangre oculta en heces, pero con una frecuencia superior a la utilizada en el cribado de la poblaci n general.

Respuesta correcta: 3

P074 MIR 2016-2017

Un paciente de 55 a os, con historia de 15 a os de colitis ulcerosa, presenta en una colonoscopia de control un c ncer de recto a ocho cm del margen anal y actividad moderada de su colitis sobre todo en el lado izquierdo del colon. Se estadia como T2N0M0 tras realizar pruebas de imagen.  Cu l es la INTERVENCI N CORRECTA para su tratamiento?

- 1) Panproctocolectom  con reservorio ileoanal e ileostom  de protecci n.
- 2) Resecci n anterior baja de recto con ileostom  lateral de protecci n.
- 3) Amputaci n abdominoperineal de recto.
- 4) Radioterapia externa, y si hay buena respuesta, hacer una cirug a local y mantener tratamiento m dico de su enfermedad inflamatoria intestinal.

Respuesta correcta: 1

P079 MIR 2017-2018

En la colitis ulcerosa,  Qu  factor NO incrementa el riesgo de neoplasia colorrectal?

- 1) El tiempo de evoluci n.
- 2) La afectaci n extensa de la enfermedad.
- 3) La coexistencia de cirrosis biliar primaria.
- 4) Los antecedentes familiares de c ncer colorrectal.

Respuesta correcta: 3

P086 MIR 2017-2018

En el s ndrome de colon irritable, es CIERTO que:

- 1) Los estudios rutinarios de laboratorio (an lisis) muestran anomal as espec ficas de este s ndrome.
- 2) Dentro de los s ntomas que nos hacen pensar en un colon irritable se encuentran: dolor abdominal nocturno, dolor progresivo y p rdida de peso.
- 3) Cursa con diarrea o estre imiento; si se manifiestan ambos, queda descartada esta entidad.
- 4) En pacientes con colon irritable con predominio de diarrea, el estudio diagn stico debe incluir: cultivo de heces, cribado de enfermedad celiaque, colonoscopia con biopsias.

Respuesta correcta: 4

P079 MIR 2018-2019

Hombre de 29 a os, tratado por una colitis ulcerosa desde hace dos a os y sin episodios de descompensaci n en los  ltimos seis meses, que refiere un dolor sordo en hipocondrio derecho y as tenia en el  ltimo mes. La exploraci n f sica no demuestra ninguna alteraci n significativa y en los an lisis se observa una bilirrubinemia total de 1,2 mg/dL (bilirrubina directa 0,7 mg/dL), aspartato aminotransferasa 89 UI/L, alanino aminotransferasa 101 UI/L, fosfatasa alcalina 1.124 UI/L, gamma glutamiltransferasa 345 UI/L, albuminemia 38 g/L y tasa de protrombina 100%. Se ale cu l de las siguientes enfermedades padece con MAYOR probabilidad:

- 1) Enfermedad biliar primaria.
- 2) Hepatitis autoinmune.
- 3) Coledocolitiasis.
- 4) Colangitis esclerosante primaria.

Respuesta correcta: 4

P149 MIR 2020-2021

El diagn stico del s ndrome de intestino irritable es principalmente cl nico y se basa en s ntomas compatibles y la ausencia de signos o s ntomas de alarma.  Cu l de los siguientes NO se considera un signo o s ntoma de alarma?

- 1) Edad de aparici n de los s ntomas por encima de los 50 a os.
- 2) P rdida de peso.
- 3) Sangre oculta en heces positiva.
- 4) Urgencia defecatoria.

Respuesta correcta: 4

P152 MIR 2020-2021

Mujer de 79 a os hipertensa en tratamiento con olmesart n que acude a consulta por diarrea acuosa de 4 a 6 deposiciones al d a desde hace dos meses. Hace tres meses recib  tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos durante 3 semanas por lumboci tica. Se realiz  gastroscopia y colonoscopia, ambas sin alteraciones macrosc picas. Las biopsias duodenales fueron normales, mientras que en las biopsias de colon se observa un infiltrado inflamatorio cr nico de la l -

mina propia con una banda irregular de colágeno inmediatamente por debajo del epitelio de superficie de la mucosa con un grosor > 10 mm y un número de linfocitos intraepiteliales > 20 por cada 100 células epiteliales. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

- 1) Colitis microscópica.
- 2) Enteropatía por AINEs.
- 3) Enteropatía asociada a olmesartán.
- 4) Síndrome de intestino irritable.

Respuesta correcta: 1

P147 MIR 2021-2022

Con respecto a la calprotectina, indique la afirmación CORRECTA:

- 1) Es una proteína secretada por los neutrófilos que se determina en sangre para valorar la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal.
- 2) Sus niveles tienen muy buena correlación con la actividad objetivada por endoscopia, sobre todo en la colitis ulcerosa.
- 3) En los pacientes con síndrome de intestino irritable se detecta en niveles anormalmente elevados.
- 4) No es de utilidad en el seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal.

Respuesta correcta: 2

P131 MIR 2023-2024

Mujer de 24 años que consulta por un cuadro de dolor abdominal, astenia, diarrea de larga evolución con rectorragia ocasional y pérdida de 10 Kg de peso en 3 meses. En la exploración destacan signos de desnutrición, dolor abdominal difuso con mayor focalidad en fosa ilíaca derecha. En la analítica destacan una hemoglobina baja y una elevación de la PCR. En la colonoscopia se encuentran úlceras aftosas, inflamación segmentaria y un área de estenosis infranqueable, todo ello en ciego. La enterorresonancia confirma este hallazgo y la existencia de inflamación en íleon distal. El cuadro es refractario al tratamiento farmacológico, por lo que se considera la cirugía. De las siguientes, señale la técnica quirúrgica más adecuada:

- 1) Hemicolectomía derecha ampliada.
- 2) Panproctocolectomía con reservorio en J.

- 3) Ileocequ Coastomía.
- 4) Colostomía terminal.

Respuesta correcta: 3

P120 MIR 2024-2025

Un paciente con enfermedad de Crohn con antecedente de extirpación de un melanoma precisa iniciar un tratamiento avanzado por corticodependencia. ¿Cuál de los siguientes fármacos se debería evitar al estar descrito un aumento del riesgo de dicha neoplasia?

- 1) Azatioprina.
- 2) Infliximab.
- 3) Vedolizumab.
- 4) Ustekinumab.

Respuesta correcta: 2

P094 MIR 2025-2026

La cirugía de elección en un paciente con un brote grave de colitis ulcerosa que desarrolla un megacolon tóxico es:

- 1) Proctocolectomía total + reservorio ileoanal + ileostomía lateral.
- 2) Proctocolectomía total + ileostomía terminal.
- 3) Colectomía total + ileostomía terminal.
- 4) Colectomía total + anastomosis ileorrectal.

Respuesta correcta: 3

P150 MIR 2025-2026

Respecto a la diferenciación entre colitis ulcerosa y colitis de Crohn, señale la opción MÁS correcta:

- 1) La afectación parcheada y el recto respetado obligan siempre a diagnosticar Crohn.
- 2) La presencia de granulomas no caseificantes en biopsia colónica es fuertemente sugestiva de Crohn.
- 3) La afectación continua desde el recto hasta el ciego es típica de Crohn colónica pura.
- 4) La afectación del íleon terminal nunca aparece en la colitis ulcerosa.

Respuesta correcta: 2

P154 MIR 2025-2026

Mujer de 55 años con diarrea acuosa crónica, no sanguinolenta, de meses de

evolución, con colonoscopia macroscópicamente normal. Las biopsias colónicas muestran infiltrado inflamatorio de la lámina propia con banda colágena subepitelial engrosada >10 µm. El diagnóstico MÁS probable es:

- 1) Colitis ulcerosa izquierda.
- 2) Enfermedad de Crohn colónica.
- 3) Colitis microscópica linfocítica.
- 4) Colitis microscópica colágena.

Respuesta correcta: 4

P155 MIR 2025-2026

Paciente de 32 años con colitis ulcerosa extensa de 10 años de evolución, en remisión clínica y endoscópica, sin displasia en colonoscopias previas. ¿Cree que debe realizarse colonoscopias de revisión para la vigilancia endoscópica del cáncer colorrectal?

- 1) No precisa vigilancia hasta los 20 años de evolución.
- 2) Debe realizarse colonoscopia con cromosendoscopia dirigida cada 3-5 años.
- 3) Solo es necesario control si presenta antecedentes familiares de CCR.
- 4) La biopsia aleatoria en todos los segmentos ha sustituido completamente a la cromosendoscopia.

Respuesta correcta: 2

T17

Manejo de los pólipos y cribado del cáncer colorrectal

P226 MIR 2015-2016

En un programa de cribado de cáncer de colon, a un paciente de 52 años se le realiza una colonoscopia. Todo el colon es de aspecto normal, salvo el hallazgo de un pólipo pediculado de 2 cm en sigma que se extirpa con asa de diatermia. El resultado anatomopatológico nos indica que existe un carcinoma "in situ" limitado a la cabeza del pólipo. Tiene una TC toracoabdominal informada como normal. Indique cuál sería la conducta correcta a seguir:

- 1) Resección segmentaria del colon afecto.
- 2) Vigilancia periódica endoscópica.



- 3) Resección local de la base del pólipo.
- 4) Sigmoidectomía más linfadenectomía.

Respuesta correcta: 2

P139 MIR 2023-2024

Hombre de 45 años que presenta un pólipo sesil de aspecto macroscópicamente benigno en colon sigmoide. Extraído mediante polipectomía endoscópica, la biopsia muestra un adenocarcinoma. ¿Cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos indica alto riesgo de recurrencia y es indicación de colectomía segmentaria?

- 1) Tumor T1 con invasión de la submucosa sm3.
- 2) Distancia al borde de sección de 2,5 mm.
- 3) Tumor bien diferenciado.
- 4) Ausencia de invasión linfovascular.

Respuesta correcta: 1

T18 Cáncer colorrectal hereditario asociado a poliposis y síndrome de Lynch

P045 MIR 2010-2011

Hombre de 30 años, con antecedente familiar de padre fallecido por cáncer de colon a los 38 años. Se practica una colonoscopia que muestra cientos de adenomas a lo largo de todo el colon. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- 1) El paciente padece una poliposis adenomatosa familiar.
- 2) El manejo más apropiado es Sulindac, colonoscopias de vigilancia anuales y colectomía total a los 40 años.
- 3) De no someterse a tratamiento quirúrgico, casi con toda seguridad el paciente desarrollará un cáncer colorrectal.
- 4) Deben estudiarse los familiares de primer grado del paciente.
- 5) Los hijos del paciente tienen un 50% de riesgo de padecer la misma enfermedad.

Respuesta correcta: 2

P208 MIR 2010-2011

Durante una colonoscopia se detecta un tumor de 5 cm localizado en colon derecho en un hombre de 48 años. No se han encontrado otras lesiones. Su abuela materna también padeció un cáncer de colon. Las biopsias son superficiales y muestran un tumor pobremente diferenciado con abundantes células inflamatorias en el estroma, que se diagnostica como un carcinoma de tipo medular:

- 1) La quimioterapia es el tratamiento de elección.
- 2) Puesto que la biopsia es superficial debe repetirse antes de proceder al tratamiento.
- 3) El pronóstico del tumor depende principalmente de su alto grado de anaplasia.
- 4) Es poco probable que este tumor se haya desarrollado sobre un adenoma previo.
- 5) Deben estudiarse la inestabilidad de microsatélites y los genes de reaparición de errores del DNA.

Respuesta correcta: 5

P035 MIR 2011-2012

Una mujer de 35 años es diagnosticada de cáncer de colon localizado en ángulo hepático. Presenta antecedentes familiares de cáncer de colon en madre, una tía a la edad de 45 años y un abuelo. La intervención quirúrgica más aceptada es:

- 1) Hemicolectomía derecha.
- 2) Hemicolectomía derecha ampliada.
- 3) Colectomía subtotal.
- 4) Colectomía total con anastomosis ileo-rectal.
- 5) Colectomía total con anastomosis ileoanal.

Respuesta correcta: 4

P212 MIR 2011-2012

Hombre de 42 años de edad, con antecedentes familiares de cáncer colorrectal y cáncer endometrial de su madre y su hermana, presenta en una colonoscopia pólipos dispersos (4-5 pólipos), y en ángulo hepático, una masa tumoral ulcerosa y de apariencia infiltrativa, que se biopsia. Histológicamente se corresponde con un adenocarcinoma

moderadamente diferenciado de tipo mucinoso. Los pólipos resecaados son adenomas tubulares con displasia leve. ¿Ante qué síndrome hereditario y mutación genética es más probable que nos encontremos?

- 1) Poliposis adenomatosa familiar. Mutación de gen APC.
- 2) Síndrome de Li-Fraumeni. Mutación en TP53.
- 3) Cáncer de colon no polipósico (síndrome de Lynch). Mutación de MSH2 y MLH-1.
- 4) Síndrome de Cowden. Mutación en PTEN.
- 5) Síndrome de Gardner. Mutación del gen APC.

Respuesta correcta: 3

P038 MIR 2012-2013

¿Cuál de los siguientes supuestos cumple los criterios de Ámsterdam-II para el diagnóstico del síndrome de Lynch?

- 1) Hombre diagnosticado de cáncer colorrectal (CCR) a la edad de 52 años. Padre diagnosticado de CCR a los 75 años. Hermano diagnosticado de CCR a los 61 años.
- 2) Mujer de 48 años diagnosticada de CCR. Madre diagnosticada de CCR a los 78 años. Prima materna diagnosticada de cáncer de mama a los 39 años.
- 3) Hombre de 70 años diagnosticado de CCR. Padre con CCR a los 45 años. Hermana con cáncer de cérvix uterino a los 61 años.
- 4) Mujer de 71 años diagnosticada de CCR. Hermana diagnosticada de cáncer de endometrio a los 48 años. Abuela materna diagnosticada de CCR a los 80 años.
- 5) Hombre diagnosticado de CCR a los 51 años. Padre diagnosticado de CCR a los 70 años. Hermano diagnosticado de CCR a los 45 años.

Respuesta correcta: 5

P076 MIR 2013-2014

En cuanto a la poliposis intestinal, ¿Cuál de los siguientes síndromes NO es hereditario?

- 1) Síndrome de Gardner.
- 2) Síndrome de Cronkhite-Canada.
- 3) Síndrome de Turcot.

- 4) Poliposis juvenil.
- 5) Síndrome de Peutz-Jeghers.

Respuesta correcta: 2

P214 MIR 2014-2015

¿Qué estudios se deben realizar en un adenocarcinoma con diferenciación mucinosa prominente de colon ascendente diagnosticado en un hombre de 32 años?

- 1) Reordenamiento del gen MYC.
- 2) Análisis de inestabilidad de microsátélites.
- 3) Estudio de mutaciones del gen RET.
- 4) Estudio de mutaciones de BRCA1-2.
- 5) Estudios de mutaciones de TP53.

Respuesta correcta: 2

P068 MIR 2015-2016

La existencia de hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina es típica en los pacientes con:

- 1) Poliposis adenomatosa familiar.
- 2) Síndrome de Peutz-Jeghers.
- 3) Síndrome de Cronkhite-Canada.
- 4) Síndrome de Cowden.

Respuesta correcta: 1

P052 MIR 2018-2019

Señale la afirmación INCORRECTA con respecto a los mecanismos de carcinogénesis en el cáncer colorrectal:

- 1) La presencia de una alteración en los mecanismos de reparación del ADN que afectan a las proteínas del sistema MMR (*MissMatch Repair*) da lugar a un exceso de mutaciones e inestabilidad de microsátélites. Esto ocurre en aproximadamente el 15% de los cánceres colorrectales esporádicos y en los asociados al síndrome de Lynch.
- 2) El cáncer colorrectal hereditario no polipósico se asocia a la presencia de mutaciones germinales en genes reparadores del ADN (MLH1, MLH2, MSH6, PMS2).
- 3) Las mutaciones germinales en el gen APC se asocian al cáncer colorrectal asociado a la poliposis hereditaria.

- 4) El cáncer colorrectal hereditario no polipósico se hereda con carácter autosómico recesivo.

Respuesta correcta: 4

P131 MIR 2019-2020

Con respecto al síndrome de Lynch o carcinoma colorrectal no polipósico hereditario, señale la afirmación CORRECTA:

- 1) Es un trastorno autosómico recesivo.
- 2) El fenotipo incluye predominio de tumores malignos del colon en el lado derecho.
- 3) La progresión pólipo-cáncer es más lenta que en el cáncer de colon esporádico.
- 4) Los tumores malignos extracolónicos suelen asentar en pulmón o hígado.

Respuesta correcta: 2

P129 MIR 2023-2024

¿Cuál de los siguientes genes puede estar afectado en familias que desarrollan tumores malignos de colon en sucesivas generaciones?

- 1) RAS.
- 2) p53.
- 3) BRCA1.
- 4) MLH1.

Respuesta correcta: 4

P209 MIR 2024-2025

Hombre de 34 años con poliposis intestinal y manifestaciones extraintestinales como hipertrofia congénita de retina y osteomas mandibulares. Para hacer el diagnóstico genético se debe analizar el gen:

- 1) Gen MYH.
- 2) Gen PTEN.
- 3) Gen APC.
- 4) Gen p53.

Respuesta correcta: 3

P153 MIR 2025-2026

En relación con el cribado de cáncer colorrectal en el síndrome de Lynch (MLH1/MSH2), señale la opción CORRECTA:

- 1) El paciente debe hacerse colonoscopias cada 10 años desde los 50 años.
- 2) El paciente debe hacerse colonoscopias cada 5 años desde los 40 años o 10 años antes del caso más joven.
- 3) El paciente debe hacerse colonoscopias cada 1-2 años desde los 20-25 años o 2-5 años antes del caso más joven en la familia.
- 4) El paciente debe hacerse colonoscopias solo si test de sangre oculta en heces es positivo.

Respuesta correcta: 3

T19 Cáncer colorrectal esporádico

P031 MIR 2009-2010

Mujer de 80 años con diagnóstico de hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca de etiología valvular por estenosis aórtica severa, anticoagulada con acenocumarol por fibrilación auricular crónica. Acude a consulta refiriendo deterioro de su clase funcional en los últimos meses. Aporta analítica con hemoglobina de 9,5 g/dL, VCM 75 fL, ferritina de 5 ng/mL y se ha realizado gastroscopia y colonoscopia sin mostrar alteraciones. ¿Cuál de las siguientes técnicas solicitaría para su diagnóstico en primer lugar?

- 1) Resonancia magnética intestinal.
- 2) Tránsito esófago-gastroduodenal.
- 3) Cápsula endoscópica.
- 4) Ecoendoscopia.
- 5) Arteriografía.

Respuesta correcta: 3

P038 MIR 2009-2010

Un hombre de 75 años, diabético e hipertenso en tratamiento médico presenta un adenocarcinoma de recto a 7 cm del margen anal que tras la realización de ecografía endorrectal y resonancia magnética se estatifica como T3N+. No hay otra patología en el resto del colon y en TAC no se objetiva enfermedad a distancia. El tratamiento más adecuado es:

- 1) Resección anterior de recto con extirpación completa del mesorrecto y anastomosis.



- 2) Amputación abdominoperineal.
- 3) Quimiorradioterapia preoperatoria y resección anterior de recto con extirpación completa del mesorrecto y anastomosis.
- 4) Quimiorradioterapia preoperatoria y resección local con microcirugía endoscópica transanal.
- 5) Quimiorradioterapia preoperatoria y amputación abdominoperineal.

Respuesta correcta: 3

P233 MIR 2009-2010

En el diagnóstico y seguimiento del cáncer colorrectal, ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales utilizaría?

- 1) Alfafetoproteína.
- 2) Ca 125.
- 3) Cromogranina A.
- 4) Antígeno carcinoembrionario (CEA).
- 5) Ca 15.3.

Respuesta correcta: 4

P003 MIR 2010-2011

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. Paciente de 72 años sin antecedentes médicoquirúrgicos de interés que consulta por disnea de reposo y astenia de 1 mes de evolución. No refiere alteración del ritmo intestinal. A su llegada a Urgencias se encuentra hemodinámicamente estable. Se solicita analítica en la que presenta, en el hemograma, Hb 7,6 g/dL, VCM 72 fL y Hto. de 26%. La paciente ingresa para estudio. La imagen 2 muestra una sección axial del TC realizado a la paciente. En relación con los hallazgos de la prueba radiológica, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- 1) Se observa un engrosamiento mural excéntrico a nivel del colon ascendente compatible con adenocarcinoma.
- 2) Presencia de mínimo engrosamiento parietal del colon con hiperemia mucosa difusa compatible con cambios de colitis ulcerosa.
- 3) Se identifica una colección fluida en el área pericecal con nivel hidroaéreo compatible con diverticulitis perforada.
- 4) Se observa un voluminoso fecaloma colónico con obstrucción proximal.

- 5) Presencia de mínima distensión fisiológica de las asas intestinales compatible con la normalidad para la edad.

Respuesta correcta: 1

P004 MIR 2010-2011

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. En el paciente anterior, cuál sería la actitud a seguir a continuación:

- 1) Colocación de sonda nasogástrica.
- 2) Drenaje percutáneo.
- 3) Antibioterapia de amplio espectro.
- 4) Colocación de sonda rectal.
- 5) Pancolonoscopia con biopsia.

Respuesta correcta: 5

P036 MIR 2011-2012

Una mujer de 55 años, posmenopáusica, consulta por astenia y disnea de esfuerzo. En la anamnesis refería ligera epigastralgia y pirosis ocasional. No metrorragias. En la analítica: Hb 6 g/dL, VCM 69 fL, sideremia 13 microgramos/dL, ferritina 4 ng/mL. Endoscopia digestiva alta: pequeña hernia hiatal por deslizamiento sin signos de esofagitis. ¿Cuál es la actitud más correcta con esta enferma?

- 1) Administrar hierro oral y ver evolución de la anemia.
- 2) Tratar con inhibidores de la bomba de protones y evaluar a los tres meses.
- 3) Recomendar una colonoscopia completa.
- 4) Realizar un estudio con cápsula endoscópica.
- 5) Solicitar una evaluación ginecológica.

Respuesta correcta: 3

P037 MIR 2014-2015

Hombre de 80 años, con antecedentes de HTA, cardiopatía isquémica y EPOC, al que se le realiza una rectocolonoscopia completa por presentar rectorragia, con los siguientes hallazgos: lesión polipoida de 3 cm de diámetro situada a 10 cm del margen anal, que ocupa la mitad de la circunferencia. Resto de exploración sin hallazgos hasta ciego. En la biopsia del pólipo se aprecia un adenocarcino-

ma limitado a la submucosa. Ecografía endorrectal: uT1N0. RM pélvica: T1N0, TC: Sin evidencia de enfermedad a distancia. ¿Cuál será la decisión terapéutica más probable que se tome en la Comisión Multidisciplinar de Tumores?

- 1) Amputación abdomino-perineal de recto.
- 2) Radioterapia neoadyuvante y resección anterior baja de recto por vía laparoscópica.
- 3) Microcirugía transanal endoscópica.
- 4) Resección anterior baja de recto vía laparotómica.
- 5) Resección anterior baja de recto vía laparoscópica y radioterapia adyuvante.

Respuesta correcta: 3

P177 MIR 2015-2016

Paciente de 57 años, diagnosticado de adenocarcinoma de colon estadio T3N1M0. Fue tratado con resección, seguida de quimioterapia postoperatoria FOLFOX (fluorouracilo, leucovorín y oxaliplatino) durante seis meses. En un control rutinario, dos años después, se detecta elevación de antígeno carcinoembrionario (CEA) a 30 ng/mL (previo menor de 2 ng/mL). No tiene síntomas, el examen físico es anodino y la radiografía de tórax es normal. En la TC se aprecia una masa de 3 cm en el lóbulo hepático derecho, que capta en PET. No se observan otras alteraciones en TC ni en PET. ¿Qué actitud le parece más correcta?

- 1) Quimioterapia con FOLFIRI (fluorouracilo, leucovorín e irinotecán) más bevacizumab.
- 2) Monoquimioterapia con capecitabina.
- 3) Valoración por cirugía de resección de la lesión hepática.
- 4) Radioterapia hepática.

Respuesta correcta: 3

P078 MIR 2017-2018

Hombre de 52 años de edad derivado al servicio de digestivo por cuadro de hematoquecia, tenesmo y reducción del diámetro de las heces. Se realizan una serie de pruebas, diagnosticándose un adenocarcinoma de sigma sin metástasis a distancia. El paciente es intervenido quirúrgicamente y remitido a la consulta de oncología

médica para valorar tratamiento quimioterápico complementario. ¿Cuál de los siguientes factores es de mal pronóstico tras la resección quirúrgica y habrá que tener en cuenta a la hora de planificar el tratamiento de quimioterapia?

- 1) La presencia de anemia al diagnóstico.
- 2) La existencia de antecedentes familiares de cáncer colorrectal.
- 3) El tamaño de la lesión primaria y la diferenciación histológica.
- 4) La perforación o adhesión del tumor a órganos adyacentes.

Respuesta correcta: 4

P186 MIR 2017-2018

Mujer de 65 años sin antecedentes personales de interés, intervenida de adenocarcinoma de sigma que infiltra la serosa (T4) con afectación de 2 ganglios de 35 aislados (N1). En el estudio de extensión no se evidencian metástasis a distancia (M0). ¿Cuál es el siguiente paso a realizar?

- 1) Determinar mutación de KRAS y NRAS para poder administrar un anti-EGFR en caso de no ser mutado.
- 2) Asociar al tratamiento con quimioterapia bevacizumab en caso de ser mutado.
- 3) Administrar una combinación de quimioterapia con fluorouracilo y oxaliplatino.
- 4) Realizar tratamiento con radioterapia al tener afectación ganglionar.

Respuesta correcta: 3

P157 MIR 2020-2021

La escisión mesorrectal total junto con resección anterior de recto en el tratamiento del cáncer de recto medio-bajo pretende:

- 1) Realizar una anastomosis con mayor facilidad.
- 2) Realizar una anastomosis más baja.
- 3) Disminuir el número de recurrencias locales.
- 4) Disminuir el intervalo libre de enfermedad.

Respuesta correcta: 3

P191 MIR 2023-2024

Según el Programa de Actividades Preventivas y Promoción de la Salud de la semFyC, así como de la US Preventive

Task Force y la American Cancer Society, ¿a partir de qué edad se aconseja, con una recomendación tipo A, iniciar las pruebas de cribado de cáncer colorrectal, en población general asintomática?

- 1) A partir de los 40 años.
- 2) A partir de los 50 años.
- 3) A partir de los 60 años.
- 4) A partir de los 65 años.

Respuesta correcta: 2

P143 MIR 2024-2025

En un paciente con cáncer colorrectal metastásico irresecable RAS nativo y con pérdida de expresión de proteínas reparadoras del ADN (MSI-H). ¿Cuál debe ser el tratamiento de elección de primera línea?

- 1) Quimioterapia + Anti-EGFR.
- 2) Inmunoterapia.
- 3) Quimioterapia.
- 4) Quimioterapia + Anti-VEGFR.

Respuesta correcta: 2

P099 MIR 2025-2026

Entre los principios oncológicos en el tratamiento del cáncer de colon se encuentran todas las siguientes afirmaciones, EXCEPTO:

- 1) Hay que realizar una resección intestinal con márgenes quirúrgicos amplios.
- 2) No hace falta hacer linfadenectomía.
- 3) Realizar resecciones en bloque si existe sospecha de infiltración de órganos vecinos.
- 4) En ocasiones se da tratamiento neoadyuvante con quimioterapia previa a la cirugía.

Respuesta correcta: 2

P206 MIR 2025-2026

Varón de 62 años es diagnosticado de adenocarcinoma de recto medio, confirmado por biopsia endoscópica. La tomografía computarizada toracoabdominopélvica no muestra metástasis a distancia. ¿Qué prueba de imagen es MÁS adecuada para identificar la mejor opción terapéutica local en este paciente?

- 1) Tomografía computarizada de abdomen y pelvis con contraste intravenoso y angiografía (angio-TAC).
- 2) Tomografía por emisión de positrones de pelvis combinada con Tomografía computarizada (PET/TC).
- 3) Resonancia magnética pélvica (RMN) con secuencias de alta resolución del mesorrecto, con o sin contraste.
- 4) Ecografía combinada abdominopélvica y endorrectal.

Respuesta correcta: 3

T20 Cirugía en la enfermedad diverticular

P041 MIR 2011-2012

La causa más frecuente de fístula colovesical es:

- 1) La colitis ulcerosa.
- 2) La enfermedad de Crohn.
- 3) El cáncer de colon.
- 4) La diverticulitis de colon.
- 5) La cirugía abdominal.

Respuesta correcta: 4

P093 MIR 2013-2014

Una mujer de 78 años acude a Urgencias por dolor en fosa ilíaca izquierda de 24 horas de evolución, asociado a fiebre y algún vómito ocasional. En la exploración destaca dolor a la palpación de forma selectiva en la fosa ilíaca izquierda con sensación de ocupación, defensa y descompresión positiva. Ante la sospecha de diverticulitis aguda, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- 1) La exploración complementaria más segura y de mejor rendimiento es el enema con contraste baritado.
- 2) En caso de absceso pélvico contenido, está indicada la colocación de un drenaje percutáneo guiado con TAC o ecografía.
- 3) En caso de precisar intervención quirúrgica tras solucionarse el episodio agudo, el abordaje laparoscópico está contraindicado.
- 4) En caso de diverticulitis aguda no complicada, está indicada la sigmoidectomía electiva tras la curación del primer episodio.



- 5) Si se produjera una peritonitis generalizada, la técnica quirúrgica más adecuada es la práctica de una colostomía derivativa sin resección del segmento sigmoideo afectado.

Respuesta correcta: 2

P077 MIR 2017-2018

Mujer de 80 años que acude a Urgencias con dolor abdominal de inicio en epigastrio e irradiado posteriormente a fosa iliaca izquierda. Se acompaña de fiebre de 37,5 °C. Se le realiza una TC abdominal, objetivando inflamación en las paredes del sigma y absceso mesentérico de 2 cm. El tratamiento de elección es:

- 1) Ingreso en planta con dieta absoluta y tratamiento antibiótico de amplio espectro.
- 2) Colostomía de descarga.
- 3) Drenaje mediante cirugía laparoscópica.
- 4) Cirugía urgente con sigmoidectomía y anastomosis colorrectal.

Respuesta correcta: 1

P013 MIR 2018-2019

Pregunta vinculada a la imagen nº 13. Mujer de 65 años que consulta por dolor cólico intermitente en fosa iliaca izquierda, alternancia en diarrea/estreñimiento y distensión abdominal con flatulencia de seis meses de evolución. Se le realiza una colonoscopia, con el siguiente hallazgo en sigma (imagen vinculada). ¿Cuál es la actitud MÁS apropiada en la consulta?

- 1) Recomendar una colonoscopia en 3 años y continuaría el estudio etiológico de sus síntomas.
- 2) Comenzar tratamiento con corticoides si la diarrea es grave.
- 3) Recomendar una dieta rica en fibra soluble y varios ciclos mensuales de rifaximina.
- 4) Realizar un estudio de estadificación previamente a indicar la resección quirúrgica.

Respuesta correcta: 3

P143 MIR 2021-2022

Mujer de 51 años que consulta, tras varios episodios de diverticulitis sigmoidea leve tratados de forma conservadora, por presentar ahora estreñimiento pertinaz

que mejora con el uso de laxantes. En ocasiones presenta dolor abdominal tipo retortijón que mejora con la expulsión de heces y gases. Se le practica colonoscopia, encontrándose una estenosis sigmoidea que impide el paso del colonoscopio. Se toma muestra para estudio anatómopatológico que no es concluyente. En el enema opaco se encuentra una estenosis sigmoidea de unos 5 cm de longitud. La actitud terapéutica MÁS adecuada sería:

- 1) Sigmoidectomía laparoscópica.
- 2) Tratamiento conservador con fibra dietética y rifaximina.
- 3) Dilatación endoscópica.
- 4) Stent en zona de estenosis.

Respuesta correcta: 1

P019 MIR 2024-2025

Pregunta vinculada a la imagen nº 19. Pregunta asociada a la imagen 19. Hombre de 60 años sin antecedentes de interés que acude a Urgencias con un cuadro de 48 horas de fiebre de 38 °C y dolor abdominal en fosa iliaca izquierda. A la exploración abdominal destaca cierta defensa a la palpación sin peritonismo generalizado. La analítica sanguínea solo destaca una discreta leucocitosis. La TC abdomino-pélvica se muestra en la imagen adjunta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Cáncer de colon izquierdo oclusivo.
- 2) Síndrome de Ogilvie.
- 3) Diverticulitis aguda.
- 4) Megacolon tóxico o infeccioso.

Respuesta correcta: 3

T21 Patología perianal

P042 MIR 2011-2012

Mujer de 26 años de edad, que presenta incontinencia fecal después de un parto prolongado e instrumental. Se practica ecografía endoanal apreciándose una sección del esfínter anal externo de 30° de amplitud. El estudio electrofisiológico demuestra un inervación normal. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

- 1) Tratamiento médico con normas higienodietéticas.

- 2) Biofeedback esfinteriano.
- 3) Esfinteroplastia quirúrgica.
- 4) Reparación quirúrgica del suelo pélvico.
- 5) Esfínter anal artificial.

Respuesta correcta: 3

P045 MIR 2014-2015

En el proceso de la defecación es VERDADERO:

- 1) Cuando las heces penetran en la ampolla rectal se produce una relajación del esfínter anal interno de forma consciente.
- 2) Cuando las heces penetran en la ampolla rectal se produce una relajación del esfínter anal externo de forma inconsciente.
- 3) El esfínter anal externo lo controlan fibras nerviosas del nervio pudendo, parte del sistema nervioso somático, y por tanto bajo control consciente voluntario.
- 4) Los movimientos propulsivos del colon en condiciones normales necesitan una hora para desplazar el quimo a través de todo el colon desde la válvula ileocecal.
- 5) Durante la defecación se produce la contracción del suelo de la pelvis.

Respuesta correcta: 3

P226 MIR 2016-2017

Hombre de 36 años remitido a la consulta de Cirugía tras drenaje urgente de absceso perianal dos meses antes, persistiendo supuración. El paciente estaba siendo estudiado previamente por digestivo por cuadro de diarrea, dolor abdominal y pérdida de peso. Colonoscopia: Recto de aspecto normal; a nivel de colon descendente y sigma se alternan zonas con aspecto de "empedrado" y úlceras lineales y profundas con otras de aspecto normal. Se completa estudio con Eco endoanal y RM observándose una fístula transesfinteriana alta. Sin tratamiento médico actual. ¿Cuál sería el tratamiento inicial más adecuado de la fístula?

- 1) Fistulotomía.
- 2) Colocación de sedal no cortante en el trayecto de la fístula asociado a tratamiento con metronidazol, infliximab e inmunosupresores.
- 3) Realizar drenajes repetidos cada vez que presente un absceso, asociando trata-

miento con infliximab e inmunosupresores.
4) Esfinterotomía lateral interna.

Respuesta correcta: 2

P226 MIR 2017-2018

Un hombre de 35 años acude a Urgencias con dolor perianal intenso y fiebre de 38 °C de dos días de evolución. En la exploración presenta una masa dolorosa en fosa isquiorrectal izquierda. ¿Cuál es la actitud MÁS adecuada?

- 1) Antibióticos de amplio espectro y controlar evolución.
- 2) Realizar ecoendoscopia y PAAF ecoguiada.
- 3) Drenaje bajo anestesia regional.
- 4) Realizar una TC y así valorar la vía de abordaje para su correcto tratamiento.

Respuesta correcta: 3

P134 MIR 2022-2023

Con respecto a la fisura anal, es INCORRECTO que:

- 1) Consiste en un desgarro longitudinal de la piel que recubre la porción del canal anal distal a la línea dentada y origina un dolor intenso con la defecación.
- 2) Tiene dos formas típicas: la primaria o idiopática aparece en individuos sanos y no se asocia a ningún tipo de enfermedad; la secundaria se detecta en pacientes que sufren otro proceso.
- 3) La mayoría de las fisuras primarias se localizan en la comisura anterior, al ser ésta una zona del canal anal más susceptible al traumatismo y a la isquemia de la mucosa.
- 4) Las fisuras secundarias a otras enfermedades aparecen con frecuencia en posiciones más laterales.

Respuesta correcta: 3

P018 MIR 2023-2024

Pregunta vinculada a la imagen nº 18. Mujer de 45 años con proctalgiya en relación con la deposición de 12 semanas de evolución. En la exploración en posición genupectoral se observa la siguiente imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Fisura anal anterior crónica.
- 2) Fisura anal aguda.
- 3) Fístula ano-vaginal.
- 4) Úlcera anal por enfermedad de Crohn.

Respuesta correcta: 1

P137 MIR 2023-2024

Paciente diabético de 50 años que acude a urgencias con fiebre de 39 °C y malestar general que refiere dolor anal desde hace 5 días. A la exploración destaca una gran tumoración perianal caliente y dolorosa, con necrosis de piel. El tratamiento de elección es:

- 1) Drenaje-desbridamiento quirúrgico.
- 2) Antibiótico de amplio espectro y esperar evolución.
- 3) Ingreso hospitalario para estudio.
- 4) Punción-drenaje guiado por radiología.

Respuesta correcta: 1

P118 MIR 2024-2025

Mujer de 42 años que consulta por dolor rectal descrito como una sensación de peso u ocupación continua que se agrava con la deposición. En la exploración física el ano es normal y en el tacto rectal se palpa el músculo puborrectal hipertónico y doloroso a la tracción. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- 1) Úlcera solitaria de recto.
- 2) Proctalgiya fugax.
- 3) Proctalgiya inespecífica.
- 4) Síndrome del elevador del ano.

Respuesta correcta: 4

T22 Patología del apéndice cecal

P083 MIR 2013-2014

El signo de Rovsing, característico en las apendicitis agudas, consiste en:

- 1) Dolor a la presión en epigastrio al aplicar una presión firme y persistente sobre el punto de McBurney.
- 2) Dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cresta ilíaca.

- 3) Sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal.
- 4) Pérdida de la sensibilidad abdominal al contraer los músculos de la pared abdominal.
- 5) Dolor en el punto de McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo del abdomen.

Respuesta correcta: 5

P071 MIR 2016-2017

Un hombre de 53 años, sin antecedentes de interés, presenta dolor en fosa ilíaca derecha de 12 días de evolución. Su médico de familia le prescribió antibiótico oral y analgesia por sospecha de infección de orina. Acude por persistencia del dolor y fiebre. En tomografía se detecta un plastrón apendicular y un absceso de 7 centímetros. Indique el tratamiento MÁS ADECUADO:

- 1) Apendicectomía urgente.
- 2) Antibioterapia, drenaje percutáneo de la colección y programar apendicectomía en 12 semanas.
- 3) Intervención urgente con hemicolectomía derecha y resección intestinal con drenaje del absceso.
- 4) Aspiración nasogástrica, fluidoterapia i.v, eritropoyetina i.v y reevaluación en una semana.

Respuesta correcta: 2

P141 MIR 2021-2022

Varón de 18 años que fue intervenido hace 10 días de una apendicitis gangrenosa por laparoscopia con peritonitis localizada pélvica. Acude a Urgencias por un síndrome febril en agujas, distensión abdominal y deposiciones diarreicas de 48 horas de evolución. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es MÁS probable?

- 1) Absceso en fondo de saco de Douglas.
- 2) Infección de la herida quirúrgica.
- 3) Infección urinaria complicada.
- 4) Absceso hepático.

Respuesta correcta: 1

P132 MIR 2022-2023

¿Cuál de los siguientes tipos de apendicitis aguda cursa MÁS frecuentemente con signo del psoas positivo?



- 1) Apendicitis pélvica.
- 2) Apendicitis mesoceliaca.
- 3) Apendicitis retrocecal.
- 4) Apendicitis medioinguinal.

Respuesta correcta: 3

T23 Obstrucción intestinal

P003 MIR 2009-2010

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. Paciente de 86 años de edad con antecedente de hipertensión arterial, diabetes mellitus e hipotiroidismo, que sufrió una fractura de cadera hace cuatro meses y desde entonces es dependiente para algunas actividades básicas (Barthel 55), presentando un deterioro cognitivo moderado con Pfeiffer de 4 errores. Tratamiento habitual con metformina 3 comprimidos al día de 850 mg, levotiroxina 100 mcg, Ramiprilo 5 mg y ácido acetilsalicílico 100 mg. Acude a urgencias por presentar desde una semana antes debilidad generalizada, estreñimiento, náuseas y vómitos diarios. No fiebre ni síntomas respiratorios o urinarios. En la exploración tensión arterial sistólica de 110 mmHg, frecuencia cardíaca 90 sístoles/minuto, palidez mucocutánea, abdomen timpánico duro y distendido. Se practica analítica sanguínea, orina y radiografía de abdomen que se muestra en la Imagen n.º 2. ¿Cuál cree que es la valoración más adecuada de esta radiografía de abdomen?

- 1) Se trata de una radiografía de mala calidad, con una proyección inadecuada que no permite un diagnóstico.
- 2) La radiografía muestra una dilatación de asas intestinales con gas fuera de las asas.
- 3) La radiografía evidencia una gran distensión de asas de intestino delgado con niveles hidroaéreos que sugieren una obstrucción a nivel de la válvula ileocecal.
- 4) Se observa gran cantidad de gas dentro de asas muy distendidas de colon y sigma así como abundantes heces en ampolla rectal que sugiere la presencia de un fecaloma.
- 5) La dilatación de asas y la presencia de una masa en plano anterior sugiere la existencia de una neoplasia abdominal.

Respuesta correcta: 2

P001 MIR 2010-2011

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. Mujer de 83 años con antecedentes personales de diabetes mellitus, hernia de hiato, úlcera duodenal y herniorrafia inguinal bilateral. Sigue tratamiento habitual con metformina, omeprazol y hierro por anemia desde hace meses. Acude a Urgencias por dolor abdominal cólico con náuseas, vómitos y estreñimiento de 48 h de evolución. Exploración física: abdomen distendido y doloroso difusamente, sin signos de irritación peritoneal. Ruidos hidroaéreos disminuidos. No masas palpables. Analítica: Hb: 8,5 g/dL, VCM 80 fL, plaquetas 240.000/μL, leucocitos 10.200/μL (81% granulocitos). pH: 7,31. HCO₃ - 17 mmol/L. Na + 134 mmol/L. K 3,1 mmol/L. Amilasa 150 U/L (28-100). LDH 252 U/L (135-225). Creatinina 1,1 mg/dL. Resto normal. Radiología de abdomen: ver imagen 1. Su sospecha diagnóstica sería:

- 1) Estreñimiento secundario a tratamiento con hierro.
- 2) Pancreatitis aguda.
- 3) Gastritis aguda.
- 4) Íleo paralítico secundario a alteraciones iónicas.
- 5) Obstrucción intestinal mecánica a nivel de íleon distal o ciego.

Respuesta correcta: 5

P002 MIR 2010-2011

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. El manejo clínico inicial más adecuado para el paciente sería:

- 1) Dieta absoluta, sonda con aspiración nasogástrica y sueroterapia con CIK. Solicitar TAC abdominal urgente.
- 2) Enemas de limpieza hasta resolución del cuadro. Repetir Rx de control.
- 3) Sueroterapia con bicarbonato 1/6 M, ClNa y CIK intravenosos.
- 4) Dieta absoluta 8 h, probar tolerancia y alta a domicilio con lactulosa y domperidona vía oral.
- 5) Analgesia y omeprazol intravenoso. Si no mejora, valorar gastroscopia urgente.

Respuesta correcta: 1

P047 MIR 2012-2013

Mujer de 55 años, intervenida de apendicitis hace 24 años, que acude porque, estando previamente bien, ha comenzado con vómitos de repetición tras desayunar, hace unas 12 horas, asociado a distensión abdominal. Ha presentado una deposición diarreaica a las pocas horas de comenzar el cuadro. En la exploración se evidencia distensión abdominal, timpanismo y aumento de ruidos intestinales, pero no irritación peritoneal. La analítica no presenta alteraciones. En la radiografía de abdomen aparece dilatación de asas de intestino delgado, sin poder objetivarse gas en la ampolla rectal. Respecto a este caso, es cierto que:

- 1) Se trata de un cuadro de obstrucción intestinal por bridas que requiere laparotomía de urgencia.
- 2) Lo más probable es que nos encontremos ante un caso de obstrucción a nivel de intestino grueso.
- 3) El hecho de que la paciente haya presentado una deposición diarreaica nos permite excluir el diagnóstico de obstrucción intestinal. Son necesarios más estudios de imagen para asegurar un diagnóstico.
- 4) Deberíamos indicar la práctica de una colonoscopia descompresiva.
- 5) El manejo inicial debe ser conservador, con sueroterapia, aspiración nasogástrica y vigilancia clínica, analítica y radiográfica periódica.

Respuesta correcta: 5

P013 MIR 2015-2016

Pregunta vinculada a la imagen nº 13. Un paciente de 78 años con historia de síndrome depresivo, hipertensión y dislipemia, en tratamiento con trazodona, enalapril y simvastatina, y antecedentes de apendicectomía hace 20 años, ingresa por un ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral media izquierda sin criterios de fibrinólisis. En el 5º día de ingreso, el paciente presenta una marcada distensión abdominal y ausencia de eliminación de heces y gas. El abdomen es discretamente doloroso a la palpación de forma difusa sin peritonismo y el peristaltismo está disminuido. Se solicita una radiografía de abdomen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Vólvulo de sigma.
- 2) Síndrome de Ogilvie.
- 3) Oclusión intestinal por bridas, en relación a la cirugía previa.
- 4) Obstrucción intestinal por neoplasia de ciego.

Respuesta correcta: 2

P011 MIR 2016-2017

Pregunta vinculada a la imagen nº 11. Paciente de 78 años, con antecedentes de sigmoidectomía por diverticulitis hace 12 años. Consulta por distensión abdominal, acompañada de dolor abdominal difuso, náuseas y vómitos alimentarios, con deposiciones escasas líquidas. En la exploración física está afebril, hemodinámicamente estable, con dolor difuso a la palpación del abdomen, que está distendido y timpanizado sin peritonismo. Los ruidos hidroaéreos están aumentados. Los estudios analíticos, que incluyen hemograma, bioquímica, hemostasia y gaseometría, son normales. En la imagen se muestran Rx de abdomen y TAC. ¿Cuál es el diagnóstico?

- 1) Pseudoobstrucción intestinal.
- 2) Oclusión intestinal por bridas.
- 3) Isquemia intestinal.
- 4) Cáncer de colon.

Respuesta correcta: 4

P072 MIR 2016-2017

Hombre de 83 años, institucionalizado, dependiente para las actividades de la vida diaria, diabético e hipertenso, sin historia de cirugía abdominal previa. Acude a urgencias por presentar distensión abdominal, ausencia de emisión de gas y heces. En la exploración destaca abdomen distendido y timpanizado, algo doloroso, sin peritonismo. No se palpan hernias. Analítica normal. En la radiografía simple se detecta una imagen en abdomen en "grano de café en sigma". Señale según el diagnóstico que sospeche la actitud MÁS CORRECTA a seguir de las siguientes:

- 1) Realizar TC abdominal por sospecha de diverticulitis.
- 2) Realización urgente de arteriografía por sospecha de isquemia mesentérica.

- 3) Devolvulación por endoscopia digestiva baja.
- 4) Infusión de neostigmina bajo control hemodinámico por Síndrome de Ogilvie.

Respuesta correcta: 3

P083 MIR 2016-2017

La pseudoobstrucción intestinal crónica es una enfermedad caracterizada por:

- 1) Múltiples estenosis y ulceraciones del intestino delgado.
- 2) Hipertensión portal secundaria con estasis venoso intestinal.
- 3) Propulsión ineficaz del contenido del intestino delgado con dolor y distensión abdominal.
- 4) Relajación defectuosa del esfínter anal con evacuación dificultosa de heces.

Respuesta correcta: 3

P035 MIR 2018-2019

Pregunta vinculada a la imagen nº 35. Está de guardia en planta de medicina y le avisan para comprobar si la sonda nasogástrica (SNG) se encuentra situada correctamente antes de iniciar una nutrición enteral. Tras examinar la radiografía de tórax (imagen vinculada), ¿Cuál debe ser la actitud a seguir?

- 1) Retirar la SNG y volverla a introducir.
- 2) Conectar una jeringa a la sonda e insuflar 10-20 cc de aire mientras escucho ruidos en el estómago con el fonendoscopio.
- 3) Iniciar nutrición enteral, ya que la SNG está en posición correcta.
- 4) Progresar la SNG 4 cm más.

Respuesta correcta: 1

P154 MIR 2020-2021

Hombre de 82 años que acude a Urgencias por cuadro de estreñimiento junto con gran distensión abdominal. En la radiología simple de abdomen se observa el signo de grano de café y en el enema opaco el signo de pico de pájaro. El tratamiento, si no existen signos de gangrena o peritonitis, consistirá en PRIMER lugar en:

- 1) Detorsión endoscópica.
- 2) Colectomía segmentaria y Hartmann.

- 3) Colectomía segmentaria y anastomosis colorrectal laparoscópica.
- 4) Detorsión quirúrgica y pexia de sigmoides.

Respuesta correcta: 1

P009 MIR 2023-2024

Pregunta vinculada a la imagen nº 9. Hombre de 72 años con diagnóstico de carcinoma de cavidad oral intervenido hace tres meses con resección completa, en tratamiento con quimioterapia, portador de gastrostomía endoscópica percutánea profiláctica, que acude a urgencias por dolor y distensión abdominal de tres días de evolución, intolerancia oral y ausencia de deposiciones. Se realiza la TC abdominopélvica con contraste intravenoso que se muestra en la imagen. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable?

- 1) Obstrucción intestinal secundaria a neoplasia estenosante de colon descendente.
- 2) Obstrucción intestinal de causa extrínseca por carcinomatosis peritoneal.
- 3) Obstrucción intestinal por migración e impacción de la sonda de gastrostomía.
- 4) Obstrucción funcional o íleo pseudoobstrutivo por fármacos.

Respuesta correcta: 1

T24 Patología vascular intestinal

P001 MIR 2009-2010

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. Un hombre de 78 años de edad, con buen estado funcional físico y cognitivo, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatía en fibrilación auricular acude al servicio de urgencias de un hospital terciario por dolor abdominal intenso, continuo, difuso, de unas 4 horas de evolución. Las constantes vitales son normales. El abdomen es blando y levemente doloroso a la palpación sin defensa ni rebote. El ECG muestra fibrilación auricular sin otros hallazgos y la glucemia capilar es 140 mg/dl. La Imagen 1 muestra la radiografía simple del abdomen a su llegada a urgencias. En relación con la lectura de la radiografía, señale, entre las siguientes, la respuesta correcta:



- 1) Dilatación de asas de intestino delgado y grueso, compatible con obstrucción en sigma.
- 2) Asas de intestino delgado ligeramente dilatadas, con aire y presencia de heces y gas en marco cólico.
- 3) Asas de intestino delgado dilatadas e imagen de colon cortado asociado a pancreatitis aguda.
- 4) Dilatación de asas de intestino delgado y grueso, por fecaloma en ampolla rectal.
- 5) Asas de intestino delgado dilatadas con aire en la pared ("neumatosis intestinal").

Respuesta correcta: 2

P002 MIR 2009-2010

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. ¿Cuál de las siguientes es la prueba diagnóstica más adecuada en el estudio del dolor abdominal de este paciente?

- 1) TC abdominal sin contraste para disminuir el riesgo de daño renal.
- 2) Repetir radiografía simple de abdomen para descartar aire libre intraperitoneal.
- 3) Hacer una ecografía abdominal para descartar patología biliar y/o renoureteral.
- 4) Colonoscopia para valorar la integridad de la mucosa del colon.
- 5) Angiografía por medio de tomografía axial computarizada (angio-TC).

Respuesta correcta: 5

P203 MIR 2014-2015

Revisando la angioTC de un hombre de 70 años en estudio por aneurisma de aorta abdominal el radiólogo informa de la presencia de una oclusión completa de la arteria mesentérica inferior. El paciente se encuentra completamente asintomático. La oclusión de la arteria mesentérica inferior cursa de manera asintomática en muchas ocasiones ya que el territorio que irriga puede recibir flujo proveniente de:

- 1) La arteria cólica media.
- 2) La arteria gastroduodenal.
- 3) La arteria epigástrica inferior izquierda.
- 4) La arteria esplénica.
- 5) La arteria gastroepiploica.

Respuesta correcta: 1

P076 MIR 2017-2018

Mujer de 78 años con demencia e institucionalizada es traída por sus cuidadores por dolor abdominal importante con deterioro del estado general y distensión abdominal. Analítica con leucocitosis, hematocrito elevado, insuficiencia renal y acidosis metabólica. El ECG muestra fibrilación auricular. La tomografía abdominal detecta asas de intestino delgado edematizadas, con neumatosis intestinal y portal. El diagnóstico MÁS probable es:

- 1) Perforación de *ulcus* gástrico o duodenal.
- 2) Íleo biliar.
- 3) Neoplasia obstructiva de sigma con perforación.
- 4) Isquemia mesentérica.

Respuesta correcta: 4

P016 MIR 2019-2020

Pregunta vinculada a la imagen nº 16. Mujer de 94 años que acude a Urgencias por dolor abdominal difuso e intenso de 12 horas de evolución y defensa abdominal. Entre sus antecedentes destacan cardiopatía isquémica crónica, fibrilación auricular persistente y enfermedad renal crónica. A raíz de los hallazgos de la radiografía de abdomen de la imagen vinculada indique la actitud a seguir:

- 1) Ecografía urgente como test de cribado inicial, si es normal no son necesarios más estudios radiológicos.
- 2) Radiografía de abdomen en bipedestación o decúbito lateral izquierdo para valorar presencia de gas ectópico.
- 3) TC abdominopélvico con contraste intravenoso con protocolo de angioTC por sospecha de isquemia mesentérica.
- 4) Arteriografía para descartar oclusión aguda de arteria mesentérica.

Respuesta correcta: 3

P018 MIR 2024-2025

Pregunta vinculada a la imagen nº 18. Pregunta asociada a la imagen 18. Mujer de 90 años que acude a Urgencias por hipotensión, vómitos oscuros y dolor abdominal. Se realiza una TC abdominal que se muestra en la imagen. De las siguientes opciones, ¿cuál es la más probable?

- 1) Se observa gas en el sistema portal siendo indicativo de mal pronóstico.
- 2) Se trata de una aerobilia y por tanto el diagnóstico más probable es el de colangitis.
- 3) Se observa aerobilia y neumatosis gástrica.
- 4) Se trata de un hallazgo no relevante en relación con una CPRE o cirugía previa.

Respuesta correcta: 1

P003 MIR 2025-2026

Ingresa una paciente de 83 años para tratamiento de aneurisma de aorta abdominal de 50 mm de diámetro, por crecimiento rápido en los últimos seis meses. Entre sus antecedentes destacan: hipertensión arterial, dislipemia y portadora de marcapasos por bloqueo auriculoventricular completo. Veinticuatro horas tras la cirugía la paciente presenta distensión, dolor abdominal y rectorragias, acompañado de leucocitosis 32.100 mclL, con el 95% de neutrófilos y 278 de LDH como únicas alteraciones analíticas, por lo que se realiza una angio-TC, con la siguiente imagen vinculada. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

- 1) Isquemia mesentérica aguda.
- 2) Isquemia mesentérica crónica.
- 3) Isquemia mesentérica no oclusiva.
- 4) Colitis isquémica.

Respuesta correcta: 4

T25

Estudio del paciente con enfermedad hepatobiliar

P137 MIR 2011-2012

Niña de 12 años de edad, hija única de padres sanos no consanguíneos. No refieren antecedentes personales ni familiares de interés. En el examen clínico para iniciar una actividad deportiva, usted encuentra una discreta hepatomegalia de consistencia normal, por lo que solicita una analítica, en la que destaca una ASAT de 80 U/L, ALAT 105 U/L, proteinograma electroforético con todas las fracciones proteínas en rango normal y negatividad de la serología de virus hepatotropos. ¿Qué debería descartar y qué prueba indicaría para ello?

- 1) Déficit de alfa 1 antitripsina. TC torácico para confirmar enfisema.
- 2) Mucoviscidosis. Determinación de cloro en sudor.
- 3) Hepatitis autoinmune. Biopsia hepática.
- 4) Glucogenosis tipo VI (déficit de fosforilasa). Biopsia muscular.
- 5) Enfermedad de Wilson. Determinar ceruloplasmina y cobre en sangre y orina.

Respuesta correcta: 5

P077 MIR 2013-2014

El procedimiento inicial de elección para investigar una posible obstrucción de las vías biliares es:

- 1) Ecografía hepatobiliar.
- 2) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE).
- 3) Colangiorresonancia Magnética.
- 4) Tomografía computarizada. TC abdominal.
- 5) Colangiografía transhepática percutánea.

Respuesta correcta: 1

P086 MIR 2018-2019

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA con respecto a la ecografía/ultrasonografía de vesícula y vías biliares?

- 1) Es una prueba sensible, económica, fiable y reproducible.
- 2) Se considera la prueba de elección de la evaluación inicial de ictericia o síntomas de enfermedad biliar.
- 3) Facilita el diagnóstico de colecistitis aguda cuando hay engrosamiento de la pared vesicular y líquido pericolecístico.
- 4) Permite distinguir los cálculos vesiculares (no dejan sombra posterior) de pólipos de vesícula (dejan una sombra evidente).

Respuesta correcta: 4

P130 MIR 2022-2023

Paciente de 71 años que consulta por ictericia con bilirrubina total 6 mg/dL (bilirrubina directa 4 mg/dL), transaminasas normales y elevación de GGT 349 U/L y fosfatasa alcalina 260 U/L. En la ecografía de abdomen se aprecia dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. No tiene dolor y refiere pérdida de peso de unos 5 kg en el último mes. Se le realiza una

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica apreciándose una estenosis abrupta del colédoco distal. ¿Cuál es su PRIMERA sospecha diagnóstica?

- 1) Colangitis esclerosante primaria.
- 2) Coledocolitiasis.
- 3) Cáncer de páncreas.
- 4) Hepatitis aguda.

Respuesta correcta: 3

T26

Alteraciones del metabolismo de la bilirrubina

P092 MIR 2013-2014

Un chico de 17 años, deportista y sin antecedentes de interés, acude al médico por presentar ictericia conjuntival ocasionalmente. Niega ingesta de fármacos y dolor abdominal. En los análisis realizados se observan cifras de ALT, AST, GGT, y FA normales, con bilirrubina total de 3,2 mg/dL y bilirrubina directa de 0,4 mg/dL. No tiene anemia y el hígado es ecográficamente normal. ¿Cuál es su diagnóstico?

- 1) Síndrome de Rotor.
- 2) Coledocolitiasis.
- 3) Síndrome de Dubin-Johnson.
- 4) Hepatitis aguda.
- 5) Síndrome de Gilbert.

Respuesta correcta: 5

T27

Hepatitis víricas

P034 MIR 2009-2010

Un paciente de 28 años, adicto a drogas por vía parenteral presenta un cuadro gripal seguido de ictericia. La analítica muestra ALT 950 U/L, AST 825 U/L, fosfatasa alcalina y gamma GT dentro de la normalidad, bilirrubina total 4,64 mg/dL directa 3,94 mg/dL. Serologías: HBs Ag negativo, Anti Hbc IgM negativo. Anti VHC negativo, Anti VHA IgM negativo. ¿Cuál de los siguientes exámenes debe incluirse en la siguiente aproximación diagnóstica?

- 1) Anti VHA IgG.
- 2) Anti hepatitis D IgM.

- 3) Anti Hbc IgG.
- 4) DNA del virus B.
- 5) RNA del virus C.

Respuesta correcta: 5

P040 MIR 2010-2011

Un hombre de 25 años presenta de forma brusca astenia e ictericia, detectándose unas transaminasas (ALT y AST) superiores a 2.000 UI/L. Los marcadores serológicos muestran el siguiente patrón: anti-VHA IgM negativo, HBsAg negativo, antiHbc IgM positivo y anti-VHC negativo. ¿Cuál es su diagnóstico?

- 1) Hepatitis crónica B.
- 2) Hepatitis aguda no viral.
- 3) Hepatitis aguda B.
- 4) Sobreinfección por virus D (delta).
- 5) Hepatitis aguda A y B.

Respuesta correcta: 3

P029 MIR 2011-2012

Pregunta vinculada a la imagen nº 15. Hombre ADVP de 32 años de edad que acude a Urgencias por fractura de peroné. La exploración física general rutinaria muestra hepatomegalia. La analítica muestra una ligera disminución de las proteínas totales y la albúmina con un incremento en los valores de ALT y AST. Los anticuerpos séricos anti-VHC son positivos, así como los anti-VHBs. Tras el tratamiento de su fractura se le realiza una biopsia hepática percutánea que se muestra en la imagen. ¿Cuál cree que es el diagnóstico más probable?

- 1) Cirrosis en el contexto de una hepatitis C.
- 2) Necrosis hepática submasiva por tóxicos.
- 3) Hepatitis crónica B sin actividad.
- 4) Hepatitis crónica activa C.
- 5) Hepatitis por VIH sin actividad en el momento actual.

Respuesta correcta: 4

P030 MIR 2011-2012

Pregunta vinculada a la imagen nº 15. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta en relación con las posibilidades evolutivas en este caso?



- 1) La esperanza de vida de este paciente, dejado a su libre evolución, puede cifrarse en 2-3 años.
- 2) Sin tratamiento alguno, el riesgo de desarrollar un hepatocarcinoma a largo plazo es significativo.
- 3) El riesgo de padecer hepatitis fulminante es, por lo menos un 15% por lo que hay indicación para inclusión inmediata en programa de trasplante.
- 4) El paciente padece un tipo de enfermedad limitada exclusivamente al hígado, por lo que no es de esperar patología extrahepática en el futuro.
- 5) Los tratamientos actuales de esta enfermedad no permiten esperar mejorías duraderas.

Respuesta correcta: 2

P197 MIR 2011-2012

Médico traumatólogo de 40 años que en una serología rutinaria se le detecta niveles de antiHBs de 30 UI/l. Refiere vacunación completa según pauta estándar frente hepatitis B hace 4 años. Sería recomendable:

- 1) Reiniciar pauta vacunal (0-1-6 meses).
- 2) Reiniciar pauta vacunal (0-1-2-12 meses).
- 3) No revacunar.
- 4) Darle una dosis de recuerdo o Booster.
- 5) Darle inmunoglobulina antihepatitis B y reiniciar pauta vacunal (0-1-2-12 meses).

Respuesta correcta: 3

P207 MIR 2011-2012

Debido a las características de su ciclo de replicación, ¿cuál de los siguientes virus puede ser erradicado del organismo tras ser sometido a tratamiento antiviral con agentes de acción directa?

- 1) El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
- 2) El virus del herpes simple (VHS).
- 3) El virus de Epstein-Barr (VEB).
- 4) Citomegalovirus (CMV).
- 5) El virus de la hepatitis C (VHC).

Respuesta correcta: 5

P040 MIR 2012-2013

Hombre de 20 años, previamente sano y sin antecedentes personales de interés,

que es llevado al servicio de urgencias por presentar agitación durante las últimas 24 horas. Durante la semana previa sus familiares le han notado coloración amarillenta de piel y de conjuntivas. Consumidor ocasional de cocaína y éxtasis y, los fines de semana, de alcohol (20 gramos). Mantiene relaciones sexuales de riesgo sin protección adecuada. Temperatura 37 °C. Presión arterial 110/60 mmHg. En la exploración física se observa agitación psicomotriz y desorientación en tiempo y en espacio, asterixis e ictericia en piel y mucosas, gingivorragias y epistaxis. El resto de la exploración física sin datos patológicos. Las pruebas de laboratorio demuestran hiperbilirrubinemia (25 mg/dL), ALT (GPT) y AST (GOT) mayores de 1.000 UI/L; prolongación del tiempo de protrombina (actividad < 40%, INR 15). Indique el diagnóstico más probable del cuadro que presenta el paciente:

- 1) Síndrome hemolítico urémico.
- 2) Hepatitis alcohólica (esteatohepatitis alcohólica grave).
- 3) Hepatitis aguda fulminante (insuficiencia hepática aguda grave).
- 4) Intoxicación por éxtasis.
- 5) Síndrome de abstinencia de cocaína.

Respuesta correcta: 3

P041 MIR 2012-2013

En relación con el virus de la hepatitis C, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- 1) Es un virus RNA.
- 2) El genotipo más frecuente en España es el genotipo 1.
- 3) El genotipo 3 responde mejor al tratamiento que el genotipo 1.
- 4) Puede ser causa de cirrosis hepática.
- 5) El tratamiento consiste en administrar ribavirina en monoterapia.

Respuesta correcta: 5

P042 MIR 2013-2014

¿Cuál de los siguientes virus de la hepatitis es subsidiario de tratamiento con inhibidores de la proteasa viral?

- 1) El virus de la hepatitis C.
- 2) El virus de la hepatitis B.

- 3) El virus de la hepatitis A.
- 4) El virus de la hepatitis E.
- 5) El virus TTV.

Respuesta correcta: 1

P051 MIR 2013-2014

Los hepatocitos en vidrio esmerilado son característicos de:

- 1) Hepatitis crónica por VHB.
- 2) Hepatitis crónica por VHC.
- 3) Hepatitis crónica por VH delta.
- 4) Hepatitis por tóxicos.
- 5) Hepatitis por alcohol.

Respuesta correcta: 1

P054 MIR 2015-2016

Una de las siguientes afirmaciones acerca de los virus de la hepatitis NO es correcta. Indíquela:

- 1) En contraste con el VHB y VHC, la transmisión por sangre del VHA es poco común, porque la viremia es breve y de bajo título.
- 2) El VHE es un virus defectivo que usa el antígeno de superficie del VHB como su proteína de envoltura.
- 3) La polimerasa codificada por el VHB actúa como una transcriptasa inversa, usando el RNAm vírico como molde para la síntesis de los genomas de DNA progenie.
- 4) La detección del HBsAg durante más de seis meses indica un estado del portador crónico.

Respuesta correcta: 2

P075 MIR 2015-2016

Indique la situación clínica que, en relación con la infección por virus de la hepatitis B, presenta un paciente de 5 años procedente de Nigeria, con exploración física normal y con la siguiente serología frente a hepatitis B: HBsAg + / ANTI-HBs - / HBeAg - / ANTI-HBe + / ANTI-HBc IgM - / ANTI-HBc IgG + / DNA VHB +:

- 1) Infección aguda.
- 2) Infección crónica.
- 3) Paciente vacunado.
- 4) Portador asintomático.

Respuesta correcta: 2

P108 MIR 2015-2016

Uno de los siguientes fármacos NO se utiliza en el tratamiento de la hepatitis crónica B:

- 1) Entecavir.
- 2) Adefovir.
- 3) Tenofovir.
- 4) Sofosbuvir.

Respuesta correcta: 4

P128 MIR 2016-2017

Un profesional sanitario, no vacunado frente al Virus de la hepatitis B (VHB), se pincha accidentalmente con una aguja con sangre de un paciente con infección crónica por dicho virus. ¿Cuál de las siguientes actuaciones a realizar, en el más breve espacio de tiempo posible, sobre el profesional sanitario es la CORRECTA?

- 1) Administrar una primera dosis de vacuna frente al VHB y simultáneamente coadministrar la inmunoglobulina antihepatitis B.
- 2) Administrar una primera dosis de vacuna frente al VHB y simultáneamente iniciar el tratamiento con el antiviral ribavirina.
- 3) Administrar la inmunoglobulina antihepatitis B y simultáneamente iniciar el tratamiento con el antiviral ribavirina.
- 4) Administrar únicamente la inmunoglobulina antihepatitis B.

Respuesta correcta: 1

P122 MIR 2017-2018

Con respecto a la infección por el virus de la hepatitis C (VHC), señale la respuesta CORRECTA:

- 1) En el mundo, la vía de transmisión más frecuente del VHC es la vertical.
- 2) Si el VHC se adquiere en edad adulta, se cronifica en el 5-10% de los casos.
- 3) La mayoría de los pacientes con infección crónica por el VHC presentan anticuerpos anti VHC positivos.
- 4) La infección aguda por el VHC cursa con ictericia franca en más del 80% de los casos.

Respuesta correcta: 3

P233 MIR 2018-2019

Acude a consulta un hombre de 70 años refiriendo que hace una hora se ha pinchado de forma accidental en el parque con una aguja conectada a una jeringa abandonada con restos de sangre. El paciente no ha padecido hepatitis B ni ha recibido vacunación. ¿Cuál es la actitud MÁS correcta?

- 1) Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y una dosis de vacuna.
- 2) Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y vacunación completa.
- 3) Administrar una dosis de gammaglobulina frente a VHB y realizar antisepsia de la zona.
- 4) Realizar antisepsia de la zona y vacunación completa.

Respuesta correcta: 2

P031 MIR 2025-2026

¿Cuál de los siguientes NO se considera un grupo de riesgo que requiera vacunación frente al virus de la hepatitis A?

- 1) Pacientes diagnosticados de VIH.
- 2) Pacientes candidatos a trasplante hepático.
- 3) Pacientes diagnosticados de asplenia anatómica o disfunción esplénica grave.
- 4) Pacientes diagnosticados de enfermedad hepática crónica.

Respuesta correcta: 3

T28 Fármacos e hígado

P033 MIR 2009-2010

Hombre de 28 años, informático, habitualmente sano, deportista de gimnasio (halterofilia), sin antecedentes patológicos recientes, consulta por malestar general, ictericia, coluria y prurito discreto. En la analítica destaca: bilirrubina directa 96 $\mu\text{mol/L}$ (5,6 mg/dL), total 100 $\mu\text{mol/L}$ (5,8 mg/dL), ALT 80 U/L ($n < 40$) AST, 75 U/L ($n < 40$), fosfatasa alcalina 180 U/L ($n < 120$) y gamma GT 79 U/L ($n < 45$). ¿Cuál es el diagnóstico más probable entre los siguientes?

- 1) Enfermedad de Gilbert.
- 2) Hepatitis viral aguda.

- 3) Toxicidad por paracetamol.
- 4) Toxicidad por anabolizantes por vía oral.
- 5) Toxicidad por amoxicilina-clavulánico.

Respuesta correcta: 4

P201 MIR 2011-2012

Un niño de 2 años de edad es traído al servicio de Urgencias porque se ha tomado el contenido del frasco de Apiretal® (paracetamol) que estaba hacia la mitad, hace aproximadamente 30 minutos. El niño tiene buen estado general y la exploración física es anodina. Se inicia la administración de carbón activado y se mantiene en observación. ¿Cuál es la actitud a seguir a partir de ese momento?

- 1) Solicitar las transaminasas hepáticas en sangre y si no están alteradas darle el alta.
- 2) Mantenerlo en observación hasta que hayan pasado 4 h desde la ingesta, extraer sangre para determinar la concentración de paracetamol y comprobar que se dispone de N-acetilcisteína intravenosa por si hubiera que administrarla.
- 3) Mantenerlo en observación hasta que hayan pasado 4 h desde la ingesta, extraer sangre para determinar la concentración de paracetamol y comprobar que se dispone de protamina que es el antídoto necesario.
- 4) Mantenerlo en observación hasta que hayan pasado 6 h desde la ingesta, extraer sangre para determinar la concentración de paracetamol y comprobar que se dispone de atropina que es el antídoto necesario.
- 5) Ponerse en contacto con el coordinador de trasplantes por si fuera necesario el trasplante hepático.

Respuesta correcta: 2

P042 MIR 2014-2015

Un hombre de 25 años consulta por ictericia. Practica el culturismo y se ha inyectado esteroides anabolizantes sustitutos del 17 alfa-alquil, tres semanas antes. Por una amigdalitis había tomado amoxicilina-clavulánico que retiró hace 15 días. Analítica: AST 1200 UI/L (límite superior normal, LSN 40), ALT 1300 UI/L (LSN 40), GGT 150 UI/L, (1511 50), fosfatasa alcalina 180 UI/L (LSN 105), bilirrubina total 4,8 mg/dL con predominio de bilirrubina directa. Serología de virus 13: Anti-HBs y



Anti-HBc positivos. La ecografía sugiere esteatosis grado I. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- 1) Hepatitis por amoxicilina-clavulánico.
- 2) Hepatitis por esteroides anabólicos.
- 3) Hepatitis aguda por virus B.
- 4) Esteatohepatitis no alcohólica.
- 5) Colestasis por fármacos.

Respuesta correcta: 1

P036 MIR 2015-2016

Respecto a la hepatotoxicidad por paracetamol, señale la respuesta correcta:

- 1) Resulta agravada por el déficit de vitamina E.
- 2) La N-acetilsalicilina reduce la gravedad de la necrosis.
- 3) Se produce por la acumulación de un metabolito tóxico del glutatión.
- 4) El patrón de presentación más habitual es el colestásico.

Respuesta correcta: 1

P078 MIR 2018-2019

¿Cuál de los siguientes fármacos es la causa MÁS frecuente de hepatotoxicidad en nuestro medio?

- 1) Fosfomicina.
- 2) Isoniazida.
- 3) Amoxicilina-clavulánico.
- 4) Eritromicina.

Respuesta correcta: 3

P151 MIR 2020-2021

Varón de 43 años sin antecedentes de interés que consulta por un cuadro de diez días de evolución de ictericia de piel y mucosas, coluria y acolia. No refiere dolor abdominal, pérdida de peso ni otra clínica, salvo prurito generalizado. Niega consumo de alcohol. No toma medicación salvo ibuprofeno ocasional por dolores musculares tras actividad deportiva. La analítica muestra una bilirrubina aumentada a expensas de directa. Una ecografía urgente muestra un hígado normal, co-

lesterolosis vesicular y ausencia de dilatación de vía biliar, sin otras alteraciones de interés. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

- 1) Colangitis aguda por barro biliar.
- 2) Hepatitis tóxica por ibuprofeno.
- 3) Colangiocarcinoma.
- 4) Síndrome de Gilbert.

Respuesta correcta: 2

P195 MIR 2022-2023

Chica de 14 años que es llevada a Urgencias por sus padres tras haber ingerido 12 horas antes múltiples comprimidos de paracetamol (no saben concretar la cantidad). Está nauseosa, pálida y sudorosa. Se solicitan niveles de paracetamol en sangre que se encuentran en rango de probable toxicidad hepática. Las pruebas de función hepática y coagulación son normales. ¿Cuál será la actitud a seguir?

- 1) Observación y repetición de niveles de paracetamol en 4 horas.
- 2) Iniciar tratamiento con N-acetilcisteína y mantenerlo durante 12 horas.
- 3) Observación y repetición de niveles de paracetamol, pruebas hepáticas y coagulación en 4 horas.
- 4) Iniciar tratamiento con N-acetilcisteína y mantenerlo en función de la evolución de los niveles de paracetamol, pruebas hepáticas y renales.

Respuesta correcta: 4

T29 Hepatitis autoinmunitaria

P226 MIR 2014-2015

¿Cuál de los siguientes fármacos NO se emplea en el tratamiento de la hepatitis autoinmune?

- 1) Prednisona.
- 2) Azatioprina.
- 3) Budesonida.
- 4) Lamivudina.
- 5) Micofenolato mofetil.

Respuesta correcta: 4

P076 MIR 2023-2024

Niña de 10 años que presenta en un análisis una importante elevación de transaminasas, que persiste en controles posteriores. Entre los estudios complementarios destaca la presencia en sangre de anticuerpos antimicrosómicos de hígado-riñón tipo 1 (anti-LKM-1). El cuadro que presenta tiene todas las características siguientes, EXCEPTO una de las siguientes:

- 1) Hipogammaglobulinemia.
- 2) En la biopsia hepática presentará una típica hepatitis de interfase.
- 3) Es más frecuente en el sexo femenino.
- 4) Se trata de una hepatitis autoinmune tipo 2.

Respuesta correcta: 1

T30

Trastornos asociados al consumo de alcohol

P094 MIR 2013-2014

Mujer de 50 años que acude al servicio de urgencias por astenia, anorexia, pérdida de peso, ictericia, fiebre y dolor abdominal. No refiere antecedentes recientes de transfusión sanguínea, contactos sexuales de riesgo ni adicción a drogas de uso parenteral. Consumo habitual de 60 gramos diarios de alcohol durante los últimos cinco años, consumo que ha incrementado durante el mes previo por problemas familiares. Temperatura 38,5 °C, tensión arterial 100/60 mmHg. En la exploración física se observa desorientación temporoespacial, malnutrición, asterixis, ictericia y hepatomegalia dolorosa. No ascitis ni datos de irritación peritoneal. En los exámenes de laboratorio destacan leucocitos 15.000/microlitro con 90% de polimorfonucleares, hematíes 3 millones/mm³, hemoglobina 10 g/dL, volumen corpuscular medio 115 fL, bilirrubina 15 mg/dL de predominio directo, AST (GOT) 300 U/L, ALT (GPT) 120 UI/L, GGT 635 UI/L, prolongación del tiempo de protrombina mayor del 50%. ¿Cuál es el diagnóstico más probable del cuadro que presenta la paciente?

- 1) Absceso hepático.
- 2) Colecistitis aguda.
- 3) Colangitis aguda.
- 4) Hepatitis alcohólica.
- 5) Pancreatitis aguda.

Respuesta correcta: 4

T31 Cirrosis

P077 MIR 2018-2019

¿Cuál de los siguientes parámetros NO es evaluado en la fórmula del MELD (Model For End-Stage Liver Disease) para la priorización de pacientes en lista de espera de trasplante hepático?

- 1) Hemoglobina.
- 2) INR.
- 3) Creatinina.
- 4) Bilirrubina.

Respuesta correcta: 1

P097 MIR 2019-2020

Hombre de 42 años con antecedente de cirrosis hepática compensada, traído a Urgencias por ictericia, fiebre, aumento del perímetro abdominal y deterioro significativo del estado general. ¿Cuál de los siguientes parámetros analíticos NO le aportaría información acerca del pronóstico?

- 1) Albúmina sérica.
- 2) Índice internacional normalizado (INR).
- 3) Bilirrubina total sérica.
- 4) Transaminasas (valor de ALT y AST).

Respuesta correcta: 4

P017 MIR 2024-2025

Pregunta vinculada a la imagen nº 17. Pregunta asociada a la imagen 17. Paciente de 63 años consulta por dolor en flanco derecho, ictericia y aumento del perímetro abdominal. Se realiza ecografía doppler y TC de hígado como se muestra en la imagen. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción terapéutica?

- 1) Colocación de una derivación intrahepática percutánea (TIPS).

- 2) Anticoagulación oral.
- 3) Trasplante hepático.
- 4) Angioplastia percutánea.

Respuesta correcta: 2

T32 Complicaciones de la cirrosis

P035 MIR 2009-2010

Un hombre de 54 años, con cirrosis hepática por virus C e hipertensión portal conocidas, presenta un episodio de hematemesis con repercusión hemodinámica. Se estabiliza con reposición energética de la volemia, y es trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde se le transfunden 3 concentrados de hematíes y se instaura una perfusión endovenosa de somatostatina. ¿Cuál de las siguientes opciones intervencionistas sería de elección en las siguientes 24 horas?

- 1) Endoscopia con escleroterapia mediante inyección de adrenalina.
- 2) Taponamiento con sonda-balón de Sengstaken-Blakemore.
- 3) Endoscopia con ligadura mediante bandas elásticas.
- 4) Embolización percutánea con coils de las varices esofágicas.
- 5) Derivación portosistémica intrahepática percutánea (por vía transyugular, conocida por sus siglas inglesas como TIPS).

Respuesta correcta: 3

P042 MIR 2010-2011

¿Cuál de los siguientes grupos de fármacos está contraindicado en pacientes con cirrosis y ascitis?

- 1) Quinolonas.
- 2) Bloqueantes betaadrenérgicos.
- 3) Antiinflamatorios no esteroideos.
- 4) Antidiabéticos orales.
- 5) Analgésicos no antiinflamatorios.

Respuesta correcta: 3

P201 MIR 2012-2013

La vena porta está formada por la confluencia de varias venas. De las respues-

tas que se ofrecen, ¿Cuál es la verdadera?

- 1) Vena mesentérica superior, vena gástrica izquierda y vena gastro-omental izquierda.
- 2) Vena mesentérica inferior, vena gástrica izquierda y vena renal.
- 3) Vena esplénica, vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior.
- 4) Vena esplénica, venas pancreatoduodenales y vena omental izquierda.
- 5) Venas pancreatoduodenales, vena mesentérica superior y vena mesentérica inferior.

Respuesta correcta: 3

P087 MIR 2013-2014

En un paciente trasplantado de hígado que está recibiendo inmunosupresión con *tacrolimus*, ¿Cuál de los siguientes antibióticos incrementa de forma notable los niveles del inmunosupresor y por tanto debe evitarse?

- 1) Amoxicilina-clavulánico.
- 2) Ciprofloxacino.
- 3) Eritromicina.
- 4) Cefuroxima.
- 5) Norfloxacino.

Respuesta correcta: 3

P164 MIR 2013-2014

Mujer de 80 años que consulta por presentar, desde hace 1 mes, aumento progresivo del perímetro abdominal. Durante los 4-5 meses previos nota astenia, anorexia y adelgazamiento no precisado. En la exploración física se aprecia ascitis a tensión y edemas maleolares, sin otros signos relevantes. Una ecografía y TAC de abdomen demuestran la presencia de ascitis, de densidad homogénea, sin apreciarse implantes peritoneales ni masas abdominales o pélvicas. Hígado, páncreas, suprarrenales, bazo y riñones sin hallazgos significativos. Se realiza paracentesis a través de aguja gruesa, obteniéndose con dificultad un líquido algo amarillento, denso y gelatinoso. ¿Cuál es la etiología más probable?

- 1) Descompensación hidrópica secundaria a cirrosis hepática.
- 2) Ascitis quílosa por linfoma no Hodgkin.
- 3) Tuberculosis peritoneal.



- 4) Metástasis peritoneal de adenocarcinoma.
- 5) Ascitis secundaria a pericarditis constrictiva.

Respuesta correcta: 4

P235 MIR 2013-2014

En un paciente con cirrosis hepática, ¿Cuál de los siguientes es el procedimiento más útil para medir la respuesta de la ascitis al tratamiento diurético?

- 1) Medir el volumen de orina de 24 horas.
- 2) Medir el perímetro abdominal diariamente.
- 3) Determinar cada semana el gradiente de albúmina entre el suero y la ascitis.
- 4) Registrar el peso cada día.
- 5) Evaluar la natriuresis cada 48.

Respuesta correcta: 4

P005 MIR 2014-2015

Pregunta vinculada a la imagen nº 3. Paciente de 58 años trasplantado hepático por cirrosis VHC+. Después de un postoperatorio sin complicaciones el paciente es remitido a su domicilio. A las 6 semanas del trasplante es visitado en la consulta externa, apreciándose febrícula, empeoramiento del estado general, un nivel de GOT de 60 UI/L (8-40) y una GPT de 65 UI/L (8-50), junto con un patrón de colestasis marcada (GGT x 10 y FA x 8) con bilirrubina total de 1,7 mg/dL (0,3-1). Así mismo se apreció un elevado número de copias del VHC. Se decidió practicar una ecografía doppler en el que se informó de una trombosis arterial completa. A la vista de estos datos se solicitó una TC y una colangiografía, cuyas imágenes se presentan en las figuras. Por los datos clínicos, analíticos y radiológicos, indique cuál es el diagnóstico más probable del problema actual:

- 1) Rechazo agudo mediado por anticuerpos con trombosis arterial asociada.
- 2) Recidiva precoz del VHC.
- 3) Estenosis de la anastomosis biliar.
- 4) Lesión isquémica extensa de las vías biliares intrahepáticas.
- 5) Trombosis completa de las ramas portales intrahepáticas.

Respuesta correcta: 4

P006 MIR 2014-2015

Pregunta vinculada a la imagen nº 3. Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado. ¿Cuál es el tratamiento que probablemente necesitará el paciente?

- 1) Retrasplante hepático.
- 2) Tratamiento con Sofosbuvir y Daclatasvir.
- 3) Hepaticoyeyunostomía.
- 4) Administración de 3 bolus de metilprednisolona e incremento de la inmunosupresión basal.
- 5) Anticoagulación.

Respuesta correcta: 1

P043 MIR 2014-2015

Hombre de 66 años de edad, diagnosticado previamente de cirrosis hepática de etiología alcohólica, que es traído al servicio de Urgencias por aumento del perímetro abdominal y desorientación temporoespacial. En la exploración física se constata la existencia de ascitis y de Flapping tremor o asterixis. ¿Cuál de las siguientes exploraciones debe realizarse con carácter urgente?

- 1) Una tomografía computarizada craneal para descartar un accidente cerebrovascular.
- 2) Una ecografía abdominal para confirmar la presencia de ascitis.
- 3) Una paracentesis exploradora para descartar una peritonitis bacteriana espontánea.
- 4) Un electroencefalograma para confirmar la existencia de encefalopatía hepática.
- 5) Una tomografía computarizada abdominal para descartar un carcinoma hepatocelular.

Respuesta correcta: 3

P012 MIR 2015-2016

Pregunta vinculada a la imagen nº 12. ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO esperaría encontrar en el líquido que se muestra en la imagen?

- 1) Triglicéridos 90 mg/dL.
- 2) Proteínas totales 3 g/dL.
- 3) Leucocitos > 500/mm³.
- 4) Gradiente de albúmina 0.9 g/dL.

Respuesta correcta: 1

P074 MIR 2015-2016

Un hombre de 67 años, diagnosticado de cirrosis hepática y bebedor activo, ingresa por cuadro de distensión abdominal progresiva con malestar difuso, de dos semanas de evolución. No refiere fiebre ni otros síntomas. En la exploración, destaca matidez cambiante a la percusión abdominal, con ausencia de edemas. Se realiza una paracentesis diagnóstica, encontrando un líquido ligeramente turbio, con 2.300 células/mL, de las cuales 30% son linfocitos, 60% polimorfonucleares y 10% hematíes. ¿Cuál es la primera medida terapéutica que pautaría en este paciente de forma inmediata?

- 1) Restricción de sal y líquidos.
- 2) Tratamiento diurético.
- 3) Tratamiento con una cefalosporina de tercera generación.
- 4) Paracentesis evacuadora.

Respuesta correcta: 3

P076 MIR 2015-2016

En relación con el trasplante hepático, señale de las siguientes la respuesta correcta:

- 1) La indicación de trasplante hepático más frecuente en la actualidad es la cirrosis por infección del virus B (VHB).
- 2) Las metástasis hepáticas por cáncer de colon constituyen una indicación aprobada para trasplante hepático.
- 3) El sistema MELD es un modelo pronóstico que permite la priorización para el trasplante hepático de los enfermos en lista.
- 4) El trasplante hepático sería la mejor opción de tratamiento para un paciente de 45 años con un hepatocarcinoma difuso.

Respuesta correcta: 3

P077 MIR 2016-2017

Acude a su consulta un hombre de 63 años con antecedentes de cirrosis hepática alcohólica estable, que no realiza seguimiento ni tratamiento tras haber estado viviendo en el extranjero. No presenta datos de encefalopatía, hay ascitis moderada a la exploración y en la analítica presenta una bilirrubina de 1,8 mg/dL, una albúmina de 3,4 g/dL y una actividad de protrombi-

na del 50% (Child-Pugh B-8). Aporta pruebas complementarias realizadas hace dos años: una ecografía abdominal sin ascitis, vena porta de 15 mm de diámetro y esplenomegalia, así como una endoscopia oral con presencia de varices esofágicas grado IV, si bien no ha tenido hasta la fecha hemorragia digestiva alta conocida. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones le parece MENOS adecuada para este paciente?

- 1) Aunque esté estable y no tenga fiebre ni dolor, debe realizarse una paracentesis diagnóstica, al ser el primer episodio conocido de ascitis.
- 2) Esta indicado realizar una nueva ecografía para descartar causas que puedan provocar una ascitis de *novo* (trombosis de vena porta, hepatocarcinoma, etc.).
- 3) Está indicado el inicio de tratamiento con betabloqueantes no cardiosselectivos porque presenta varices grandes, aunque nunca haya sangrado, ya que prolongan la supervivencia.
- 4) La instauración del tratamiento diurético debemos iniciarla en un periodo corto de hospitalización para asegurarnos que no aparece fallo renal o hiponatremia grave asociada.

Respuesta correcta: 4

P080 MIR 2016-2017

En el diagnóstico diferencial de un paciente con ascitis, el gradiente seroascítico de albúmina es muy importante. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas NO se asocia a un gradiente mayor de 1,1 g/dL?

- 1) Cirrosis hepática.
- 2) Carcinomatosis peritoneal.
- 3) Síndrome de Budd-Chiari.
- 4) Insuficiencia hepática aguda (hepatitis fulminante).

Respuesta correcta: 2

P099 MIR 2019-2020

Paciente con cirrosis hepática estadio B de Child con ascitis y antecedentes de peritonitis bacteriana espontánea (PBE). ¿Cuál de las siguientes pautas de tratamiento antibiótico se considera ADECUADA como profilaxis de la PBE?

- 1) Vancomicina 500 mg / día.
- 2) Norfloxacin 400 mg / día.
- 3) Metronidazol 250 mg / día.
- 4) Amoxicilina 1.000 mg / día.

Respuesta correcta: 2

P133 MIR 2023-2024

Hombre de 57 años con cirrosis hepática metabólica que consulta por un cuadro recidivante de confusión y desorientación a pesar del tratamiento con rifaximina y lactulosa. En la angio-CT se aprecia una comunicación portosistémica de gran calibre. La función hepática está alterada con MELD 17p y ChildPugh B8. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más apropiado?

- 1) Trasplante hepático.
- 2) Oclusión de la comunicación portosistémica.
- 3) Colocación de TIPS (protesis intrahepática percutánea transyugular).
- 4) Trasplante de microbiota fecal.

Respuesta correcta: 1

P122 MIR 2024-2025

Mujer de 67 años con antecedentes de infección por VHC que acude a Urgencias por hematemesis. A la exploración observamos ascitis y ligera ictericia. ¿Cuál es la actitud diagnóstica y terapéutica más adecuada?

- 1) Estabilizar hemodinámicamente, hacer una endoscopia y colocar un TIPS si tiene hemorragia por varices.
- 2) Realizar una paracentesis, seguido de una endoscopia y ligadura de varices.
- 3) Estabilizar al paciente, iniciar un fármaco vasoactivo, realizar una endoscopia y practicar una ligadura si hay hemorragia por varices.
- 4) Esperar al resultado de la endoscopia para actuar en consecuencia.

Respuesta correcta: 3

P208 MIR 2025-2026

Mujer de 67 años diagnosticada de cirrosis hepática, con antecedentes de descompensaciones ascíticas en tratamiento con espironolactona y furosemida. Su familia la trae a urgencias por alteración

del nivel de conciencia. La paciente se encuentra ligeramente desorientada en tiempo y espacio y somnolienta. Tiene asterixis franca. ¿Cuál de las siguientes medidas NO se encuentra indicada a su ingreso?

- 1) Paracentesis diagnóstica.
- 2) Medición de los niveles plasmáticos de amoníaco.
- 3) Administración de lactulosa por vía oral.
- 4) Antibioterapia de amplio espectro.

Respuesta correcta: Anulada

T33 Colestasis crónicas

P232 MIR 2010-2011

Mujer de 52 años que consulta por haber notado durante la semana previa coloración amarillenta de conjuntivas. No refiere conductas sexuales de riesgo ni antecedentes epidemiológicos de riesgo de hepatitis vírica. No consume alcohol ni fármacos hepatotóxicos. Relata historia de un año de evolución de prurito generalizado, astenia, sequedad de boca, y ausencia de lagrimeo de causa no filiada. Resto de la anamnesis sin datos patológicos. En la exploración física se observan lesiones de rascado, ictericia conjuntival y hepatomegalia no dolorosa. Aporta analítica realizada en su empresa con los siguientes resultados patológicos: bilirrubina total 3 mg/dL, fosfatasa alcalina 400 UI, velocidad de sedimentación 40 mm a la primera hora. Indique cuál sería la recomendación más acertada para establecer el diagnóstico etiológico del cuadro que presenta la paciente:

- 1) Anticuerpos antimitocondriales.
- 2) Estudio del metabolismo del hierro.
- 3) Estudio del metabolismo del cobre.
- 4) Resonancia magnética hepática.
- 5) Serología de virus B y virus C.

Respuesta correcta: 1

T34 Enfermedades metabólicas hepáticas

P032 MIR 2009-2010



Un paciente obeso de 35 años de edad, con un consumo de alcohol de 30 g/día consulta por aumento ligero de transaminasas y gammaglutamiltranspeptidasa (inferior a dos veces los valores normales). El paciente se halla asintomático y la exploración demuestra sólo hepatomegalia de 3 cm por debajo del reborde costal. En la ecografía abdominal se constata un aumento difuso de la ecogenicidad hepática sin otras alteraciones. El diagnóstico más probable es:

- 1) Esteatosis hepática alcohólica.
- 2) Hemocromatosis.
- 3) Cirrosis hepática.
- 4) Esteatosis hepática no alcohólica.
- 5) Enfermedad de Wilson.

Respuesta correcta: Anulada

P218 MIR 2010-2011

Un hombre 56 años, diabético y con sobrepeso moderado, presenta una discreta hepatomegalia. El enfermo indica que no es bebedor habitual, sólo excepcionalmente toma algo de vino. Una biopsia de hígado muestra acúmulos de vacuolas claras citoplásmicas en un 50% de los hepatocitos. Focos inflamatorios múltiples con neutrófilos, degeneración hialina de Mallory y fibrosis alrededor de las vénulas hepáticas terminales. Señale la respuesta correcta en este caso:

- 1) Debe repetirse la biopsia para saber si los cambios son difusos.
- 2) El diagnóstico es de una glucogenosis hepática asociada a la diabetes.
- 3) Los cambios histológicos son irreversibles y acabarán produciendo una cirrosis.
- 4) La lesión está causada claramente por el alcohol a pesar de la negativa del enfermo.
- 5) Es importante disminuir peso y controlar adecuadamente la diabetes para evitar el posible desarrollo de una cirrosis.

Respuesta correcta: 5

P037 MIR 2011-2012

Hombre de 52 años que consulta para una segunda opinión sobre la necesidad de realizarse biopsia hepática para estudio de hipertransaminasemia detectada hace dos años en análisis rutinarios de empresa. Entre sus antecedentes familia-

res destaca el fallecimiento de su padre por cirrosis hepática de etiología no filiada. Asintomático y realizando vida social y laboral sin limitaciones. Niega consumo de alcohol. En la exploración física destaca pigmentación metálica de piel y mínima hepatomegalia no dolorosa. Resto de la exploración física normal. Índice de masa corporal 23. Aporta analítica con los siguientes resultados: bilirrubina, albúmina, transaminasas AST y ALT, hemograma y tiempo de protrombina normales; glucemia 150 mg/dL; ferritina sérica 950 ng/mL; saturación de transferrina > 45%. Estudio de virus hepatotropos negativo. Ecografía abdominal normal. Le han realizado estudio genético del gen HFE siendo homocigoto para la mutación C282Y. ¿Cuál sería la recomendación más acertada con la información disponible?

- 1) Realizar biopsia hepática.
- 2) Realizar resonancia magnética hepática.
- 3) Iniciar tratamiento con flebotomías.
- 4) Iniciar tratamiento con deferroxamina.
- 5) Iniciar tratamiento con vitamina E.

Respuesta correcta: 3

P090 MIR 2017-2018

¿Cuál de los siguientes fármacos se ha demostrado EFICAZ en la reducción de la fibrosis en paciente con esteatohepatitis no alcohólica?

- 1) Pioglitazona.
- 2) Pentoxifilina.
- 3) Ácido ursodesoxicólico.
- 4) Fenofibrato.

Respuesta correcta: 1

P098 MIR 2019-2020

Hombre de 55 años remitido a la consulta por detectarse en un examen de salud hipertransaminasemia y esteatosis hepática en la ecografía. Es hipotiroideo en tratamiento sustitutivo y diabético bien controlado con metformina. Bebe alcohol muy ocasionalmente. En la exploración física destaca una obesidad tipo I (índice de masa corporal, IMC 33 kg/m²). La analítica muestra: aspartato aminotransferasa (AST) 87 UI/L, alanino aminotransferasa (ALT) 65 UI/L, gamma-glutamyltransferasa (GGT) 100 UI/L, colesterol total 230 mg/

dL, glucemia basal 132 mg/dL. Bilirrubina, fosfatasa alcalina, hormonas tiroideas y ferritina normales. Coagulación normal. La serología de hepatitis vírica (VHA, VHB y VHC) y de autoinmunidad (ANA, AMA, AML, antiLKM) son negativas. Señale la afirmación MÁS apropiada:

- 1) Tiene una esteatosis hepática sin riesgo de desarrollar cirrosis ni hepatocarcinoma, por lo que es suficiente el control metabólico periódico.
- 2) Está indicado realizar una biopsia hepática por la sospecha de hepatitis autoinmune.
- 3) Es útil realizar una elastografía de transición (Fibroscan®) para determinar la existencia o no de fibrosis.
- 4) Está indicado sustituir la metformina por pioglitazona que ha demostrado ser más eficaz para mejorar la esteatosis hepática.

Respuesta correcta: 3

T35 Tumores hepáticos

P043 MIR 2010-2011

En relación con el hepatocarcinoma es cierto que:

- 1) Se prevé un aumento de su incidencia en los próximos años.
- 2) Suele diagnosticarse en pacientes entre 40 y 50 años.
- 3) En nuestro medio se relaciona habitualmente con la infección por el virus de la hepatitis B.
- 4) En la TC se manifiesta como una lesión hipovascular en fase arterial.
- 5) En la actualidad no se dispone de ningún fármaco capaz de mejorar la supervivencia de los pacientes con hepatocarcinoma avanzado.

Respuesta correcta: 1

P001 MIR 2011-2012

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. Paciente de 55 años de edad exfumador y exenólico. Hemorragia digestiva alta por *ulcus* antral que requirió transfusión sanguínea. Cirrosis hepática con serologías virales positivas (VHC+). Child-Pugh de 6 puntos. La imagen muestra dos secciones axiales en fase arterial y tardía del TC rea-

lizado a la paciente. En relación con los hallazgos de la prueba radiológica, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- 1) Se observa una lesión focal hipervascular en fase arterial compatible con pseudoaneurisma de la arteria hepática.
- 2) Se observa un nódulo hipervascular en fase arterial con lavado en fase venosa compatible con carcinoma hepatocelular.
- 3) Se observa una lesión focal hipovascular compatible con colangiocarcinoma periférico.
- 4) Se trata de una lesión quística. Probable quiste hidatídico.
- 5) Se observa una gran trombosis portal tumoral.

Respuesta correcta: 2

P002 MIR 2011-2012

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. En el caso anterior ¿Qué tratamiento, entre los siguientes, propondría en primer lugar?

- 1) Trasplante hepático.
- 2) Radioterapia externa.
- 3) Ablación con radiofrecuencia.
- 4) Embolización arterial.
- 5) Quimioterapia sistémica.

Respuesta correcta: 1

P038 MIR 2011-2012

Hombre de 64 años con cirrosis hepática Child A sin antecedentes de descompensación. Tras detección de una lesión focal hepática en ecografía de cribado se completa el estudio con una TC toracoabdominal. En esta exploración se objetiva la presencia de 4 lesiones hepáticas (una de ellas de hasta 6 cm) con patrón de captación típico de hepatocarcinoma, invasión vascular tumoral y una metástasis en glándula suprarrenal derecha. No se observa ascitis. El paciente refiere únicamente astenia, pero no presenta síndrome general. El tratamiento de elección en este paciente sería:

- 1) Tratamiento sintomático y de soporte ya que presenta un hepatocarcinoma avanzado con invasión vascular y metástasis.
- 2) Quimioembolización transarterial (TACE) ya que este tratamiento aumenta la supervivencia en los pacientes con hepatocarcinoma avanzado.

- 3) Quimioterapia sistémica con doxorubicina i.v. ya que presenta enfermedad diseminada pero mantiene buen estado general.
- 4) Tratamiento con sorafenib oral ya que se trata de un enfermo con buen estado general, Child A y hepatocarcinoma en estadio avanzado BCLC-C.
- 5) El tratamiento adecuado es el trasplante hepático ya que es el único procedimiento que elimina completamente el tumor primario y evita las complicaciones futuras de la cirrosis.

Respuesta correcta: 4

P039 MIR 2012-2013

A un paciente de 75 años con cirrosis hepática que presenta ascitis moderada y tiene varices esofágicas grandes y una puntuación de Child-Pugh de 9 puntos (clase B), se le ha detectado en una ecografía abdominal una lesión hepática única de 3 cm de diámetro que es hipervascular en fase arterial del angioTAC. ¿Cuál es la actitud terapéutica más correcta en este caso?

- 1) Iniciar sorafenib oral.
- 2) Practicar una resección quirúrgica del tumor.
- 3) Realizar un tratamiento local mediante técnicas de ablación percutánea.
- 4) Proponer un trasplante hepático.
- 5) Tratar con quimioembolización arterial del tumor.

Respuesta correcta: 3

P084 MIR 2013-2014

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la hiperplasia nodular focal hepática es cierta?

- 1) Se considera que su aparición está relacionada con el consumo de anticonceptivos.
- 2) El riesgo de hemoperitoneo por rotura es similar al del adenoma.
- 3) Existe riesgo de degeneración tumoral.
- 4) Se comporta como una lesión focal hipovascular en la tomografía computarizada con administración de contraste.
- 5) En el estudio histológico de la lesión, además de hepatocitos, pueden observarse conductos biliares y otras células hepáticas.

Respuesta correcta: 5

P035 MIR 2014-2015

¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto con respecto a los hemangiomas hepáticos?

- 1) Pueden asociarse al síndrome de Kasabach-Merritt (trombocitopenia y coagulopatía de consumo), especialmente los hemangiomas gigantes.
- 2) Se debe indicar la exéresis quirúrgica desde el momento que se diagnostique si su diámetro es mayor de 3 cm.
- 3) La opción terapéutica más recomendable para este tipo de tumor es la embolización percutánea.
- 4) El mejor método para su confirmación diagnóstica es la biopsia percutánea de la lesión hepática.
- 5) La RM hepática no suele ofrecer mucha ayuda para su caracterización diagnóstica.

Respuesta correcta: 1

P078 MIR 2016-2017

En el diagnóstico de carcinoma hepatocelular, señale la RESPUESTA CORRECTA:

- 1) El estudio histológico es obligatorio en todos los casos.
- 2) En pacientes cirróticos el diagnóstico se puede realizar mediante técnicas de imagen dinámicas.
- 3) En pacientes cirróticos el diagnóstico se puede realizar ante la sospecha clínica y niveles de la alfa fetoproteína mayores de 100 ng/dL.
- 4) La arteriografía es la única técnica que demuestra de forma fiable la característica fundamental de este tumor que es la hipervascularización arterial.

Respuesta correcta: 2

P079 MIR 2016-2017

Un hombre de 57 años con cirrosis hepática etílica, en abstinencia de más de 6 años, tiene una función hepática en grado A de Child, varices esofágicas grado II y buena situación clínica (ECOG 1). Es diagnosticado de un carcinoma hepatocelular en el lóbulo hepático derecho, de 8 cm de diámetro y con trombosis de la rama portal adyacente. El tratamiento indicado es:



- 1) Trasplante hepático.
- 2) Resección quirúrgica.
- 3) Quimioembolización transarterial con microesferas liberadoras de fármacos (TA-CE-DBE).
- 4) Sorafenib.

Respuesta correcta: 4

P084 MIR 2017-2018

Un hombre de 67 años con cirrosis alcohólica en seguimiento por el servicio de hepatología es diagnosticado de un hepatocarcinoma de 3 cm de diámetro localizado en el lóbulo izquierdo, segmento 3. Sometido a estudio para valoración del tratamiento a seguir se demuestra que el paciente no tiene hipertensión portal, presenta una función hepática normal, un MELD score de 7 y un Child-Pugh grado A. La alfa-fetoproteína es inferior a 50 ng/mL y no se han objetivado metástasis a distancia. ¿Cuál es el tratamiento MÁS indicado en este paciente?

- 1) Aplicar inyección de etanol percutánea.
- 2) Resección hepática.
- 3) Trasplante hepático.
- 4) Quimioembolización transarterial.

Respuesta correcta: 2

P137 MIR 2021-2022

Paciente de 55 años con cirrosis hepática alcohólica, abstinentes, sin datos de hipertensión portal. Análisis: AST 34 U/L (normal < 37 U/L); ALT 19 U/L (normal < 41 U/L); bilirrubina total 0,78 mg/dL (normal < 1 mg/dL); alfa-fetoproteína 7 ng/mL (normal < 10 ng/mL). Se le realiza una ecografía hepática que detecta una lesión ocupante de espacio hipoecogénica de 1,5 cm de diámetro. La resonancia magnética muestra una lesión con captación en fase arterial y lavado en fase venosa. ¿Qué actitud de las siguientes es MÁS correcta?

- 1) Realizar biopsia del nódulo, ya que el tamaño es inferior a 2 cm.
- 2) Repetir la ecografía a los 3 meses.
- 3) Indicar un trasplante hepático.
- 4) Solicitar estudio de extensión.

Respuesta correcta: 4

P131 MIR 2022-2023

Varón de 58 años con cirrosis compensada Child A-5 secundaria a hígado graso no alcohólico, sin otros antecedentes. Refiere astenia sin anorexia ni pérdida de peso. En una ecografía abdominal de cribado y posteriormente en una TC toracoabdominal trifásica se detectan cuatro lesiones hepáticas (una de ellas de 6 cm), hipervasculares en fase arterial y con lavado en fase venosa, con invasión de vena porta y sin metástasis extrahepáticas. No se observa ascitis. ¿Cuál de los siguientes es el MEJOR tratamiento?

- 1) Quimioembolización transarterial.
- 2) Sorafenib.
- 3) Trasplante hepático.
- 4) Ablación con radiofrecuencia.

Respuesta correcta: 2

P130 MIR 2023-2024

En un paciente con esteatosis hepática metabólica (antes enfermedad hepática por depósito de grasa) el riesgo de desarrollo de hepatocarcinoma en comparación con otras etiologías frecuentes como la hepatopatía alcohólica o la hepatitis C, se caracteriza por:

- 1) Aparecer en personas más jóvenes.
- 2) Se beneficia de los programas de diagnóstico precoz.
- 3) Aparece más frecuentemente en fases previas a la cirrosis.
- 4) Presenta una incidencia acumulada anual mayor que en la hepatitis C.

Respuesta correcta: 3

T36

Enfermedades de la vesícula biliar y conductos biliares

P039 MIR 2009-2010

De las cinco afirmaciones que se hacen sobre la colangitis aguda, una de ellas es FALSA:

- 1) La presentación clásica se caracteriza por fiebre alta, ictericia y dolor abdominal.

- 2) Una causa frecuente de colangitis es la estenosis maligna del colédoco.
- 3) Es obligatoria la hospitalización, reposición hidroelectrolítica, soporte general y terapéutica antibiótica.
- 4) La endoscopia precoz permite el diagnóstico por colangiografía y el drenaje de la vía biliar.
- 5) La cirugía de drenaje de la vía biliar se realiza cuando no son posibles otras opciones.

Respuesta correcta: 2

P040 MIR 2009-2010

La colecistectomía laparoscópica tiene como ventaja sobre la colecistectomía por laparotomía:

- 1) La reducción de la estancia hospitalaria.
- 2) Permite conservar la vesícula.
- 3) No se asocia a lesiones de la vía biliar.
- 4) Es una técnica exenta de mortalidad.
- 5) Es siempre posible realizarla mediante el abordaje laparoscópico.

Respuesta correcta: 1

P036 MIR 2010-2011

Un paciente de 87 años con antecedentes de bronquitis crónica e insuficiencia cardíaca ha sido diagnosticado de colecistitis aguda litiasica. Tras cuatro días de hospitalización en tratamiento con dieta absoluta, sueroterapia, piperacilina/tazobactam, el paciente continúa con fiebre, dolor abdominal persistente y leucocitosis. La actitud más adecuada en este momento sería:

- 1) Tratamiento quirúrgico (colecistostomía) urgente.
- 2) Drenaje biliar mediante colecistostomía percutánea.
- 3) Sustituir la piperacilina/tazobactam por metronidazol + cefotaxima.
- 4) Sustituir la piperacilina/tazobactam por amikacina + clindamicina.
- 5) Añadir al tratamiento un aminoglucósido como gentamicina.

Respuesta correcta: 2

P003 MIR 2011-2012

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. Hombre de 69 años de edad con antece-

dentes de diabetes mellitus y consumo moderado de alcohol desde hacía años, que acude a Urgencias por dolor abdominal tipo cólico, de 7 días de evolución en hemiabdomen superior, más localizado en hipocondrio derecho. Asocia prurito generalizado que le dificulta el sueño y orinas oscuras en los últimos dos días. En la exploración física destacaba TA 130/61, FC 102 lpm, temperatura 36,8 °C. El abdomen estaba blando, depresible, doloroso a la palpación profunda y sensación de masa en el hipocondrio derecho. Los análisis de sangre muestran proteína C reactiva 12,0 mg/dL, Glucosa 115 mg/dL, Urea 45 mg/dL, Creatinina 0,72 mg/dL, Bilirrubina total 8-15 mg/dL, electrolitos normales, ALT (GPT plasma) 45 U/L, GGT 112 U/L, LDH 110 U/L, Lipasa 16 U/L. Leucocitos 9,3 10³/mCL, hemáties 4,08 10E6/mCL, hemoglobina 12,3 g/dL, hematocrito 35,9%, VCM 87,9 fL, recuento de plaquetas 217 10³/mCL, (N 69,3%, L 26,2%, M 4,5%, Eo 0,0%, B 0,0%). Se efectuó ecografía abdominal que se muestra en la imagen. ¿Cuáles son los hallazgos de la ecografía?

- 1) Vesícula biliar distendida con litiasis en su interior.
- 2) Engrosamiento de la pared de la vesícula biliar.
- 3) Inflamación hipoecoica de la cabeza del páncreas.
- 4) Litiasis y dilatación del colédoco.
- 5) Aumento de calibre de la vena cava.

Respuesta correcta: 4

P004 MIR 2011-2012

Pregunta vinculada a la imagen nº 2. ¿Cuál es la actitud más recomendable en este momento?

- 1) Cirugía abierta urgente de la vía biliar.
- 2) Antibioterapia y medidas sintomáticas.
- 3) Colangiografía retrógrada endoscópica con papilotomía.
- 4) Plantear colecistectomía diferida.
- 5) Solicitar una ecoendoscopia para valorar el páncreas.

Respuesta correcta: 3

P047 MIR 2014-2015

Una mujer de 49 años acude de Urgencias por presentar tiritona, fiebre de 39° C, dolor

en hipocondrio derecho, ictericia y vómitos. La exploración revela TA 100/50 mmHg, FC 110 lpm. Postración y dolor a la palpación en cuadrante derecho, con Murphy positivo. La analítica muestra leucocitosis con desviación izquierda y la ecografía abdominal, colelitiasis, coledocolitiasis y dilatación de la vía biliar extrahepática. Se inicia tratamiento empírico con antibiótico y fluidoterapia. ¿Cuál es el procedimiento más eficaz para realizar a continuación?

- 1) Mantener tratamiento antibiótico y medidas de soporte con colecistectomía reglada posterior.
- 2) Colecistectomía laparoscópica.
- 3) Colocación de un drenaje biliar externo.
- 4) Colecistectomía urgente con canulación del colédoco.
- 5) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía.

Respuesta correcta: 5

P013 MIR 2016-2017

Pregunta vinculada a la imagen nº 13. Mujer de 65 años sin antecedentes patológicos de interés que acude a Urgencias de un Hospital por náuseas y molestias persistentes en hipocondrio derecho que se han agudizado en las últimas 24 horas; se acompaña de anorexia con cierto grado de astenia y sensación distérmica. A su entrada en Urgencias está febril (38,2 °C), normotensa (125/75 mmHg), y con dolor a la palpación selectiva en hipocondrio derecho; el resto de la exploración física en anodina. La analítica realizada revela como únicos parámetros alterados una leucocitosis de 13.000/mm³ con neutrofilia asociada. En este contexto clínico el cirujano de guardia solicita una ecografía abdominal. Señale la RESPUESTA CORRECTA:

- 1) La ecografía muestra una vesícula biliar distendida, de paredes engrosadas y edematosas, con litiasis infundibular. Estos hallazgos sugieren el diagnóstico de colecistitis aguda litiásica.
- 2) La ecografía muestra una vesícula biliar distendida, de paredes engrosadas y edematosas, sin evidencia de litiasis vesicular. Estos hallazgos sugieren el diagnóstico de colecistitis aguda alitiásica.
- 3) La ecografía muestra una vesícula biliar poco distendida de paredes engrosadas (por su poca distensión) sin evidencia de

litiasis. Estos hallazgos excluyen el diagnóstico de colecistitis aguda litiásica.

- 4) En este contexto clínico, la primera prueba a realizarse debería ser siempre la TC abdominal pues muestra mayor sensibilidad en la detección de litiasis vesicular.

Respuesta correcta: 1

P006 MIR 2017-2018

Pregunta vinculada a la imagen nº 6. Mujer de 84 años con antecedente de colecistectomía que presenta dolor abdominal e ictericia. Se realizó una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). ¿Cuál es el diagnóstico CORRECTO?

- 1) Síndrome de Mirizzi.
- 2) Neoplasia de páncreas.
- 3) Coledocolitiasis.
- 4) Estenosis postquirúrgica del colédoco.

Respuesta correcta: 3

P076 MIR 2018-2019

Mujer de 50 años que acude a Urgencias por cuadro de dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. La ecografía informa de colecistitis aguda litiásica con dilatación de la vía biliar principal por posible coledocolitiasis. ¿Qué considera MÁS apropiado hacer primero?

- 1) Cirugía urgente.
- 2) Colangiorresonancia magnética.
- 3) TC abdominal.
- 4) Colangiopancreatografía endoscópica con esfinterotomía.

Respuesta correcta: 4

P022 MIR 2019-2020

Pregunta vinculada a la imagen nº 22. Mujer de 85 años que acude a Urgencias por náuseas, vómitos y distensión abdominal. No refiere cirugías abdominales previas, pero sí varios episodios de colecistitis. En la analítica urgente se evidencia discreta leucocitosis con desviación izquierda y PCR elevada. Se aporta radiografía simple de abdomen y TC abdominal (imagen vinculada). ¿Cuál de las siguientes actuaciones considera MÁS recomendable?



- 1) Colectomía laparoscópica.
- 2) Sonda nasogástrica descompresiva.
- 3) Enterolitotomía quirúrgica.
- 4) Resección segmentaria de íleon terminal.

Respuesta correcta: 3

P132 MIR 2019-2020

Mujer de 67 años, obesa, que acude a Urgencias por dolor abdominal en cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre de 39,5 °C y orinas muy oscuras. Ante este cuadro se debería sospechar en primer lugar:

- 1) Colectitis aguda alitiásica.
- 2) Coledocolitiasis.
- 3) Colectitis aguda litiásica.
- 4) Colangitis ascendente.

Respuesta correcta: 4

P178 MIR 2019-2020

¿Cuál de los siguientes factores NO se asocia al desarrollo de cálculos de pigmento en la vesícula biliar?

- 1) Hemólisis crónica.
- 2) Anemia perniciosa.
- 3) Infección crónica de vías biliares.
- 4) Colangitis biliar primaria.

Respuesta correcta: 4

P139 MIR 2021-2022

Mujer de 69 años que acude a Urgencias por un cuadro de vómitos, estreñimiento, retortijones y distensión abdominal. En la exploración se observa abdomen distendido, sin dolor a la palpación, con ruidos intestinales metálicos. En la radiografía simple de abdomen en bipedestación se observan múltiples niveles hidroaéreos y aerobilia. De entre los siguientes, el diagnóstico MÁS probable es:

- 1) Colectitis enfisematosa.
- 2) Fitobezoar.
- 3) Íleo biliar.
- 4) Colitis isquémica.

Respuesta correcta: 3

P008 MIR 2022-2023

Pregunta vinculada a la imagen nº 8. Mujer de 82 años que acude a Urgencias por un cuadro de dolor abdominal localizado en flanco derecho, irradiado a espalda y febrícula de 37,3 °C. Se le realiza ecografía abdominal que en hipocondrio derecho muestra los resultados de la imagen vinculada. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

- 1) Colectitis aguda.
- 2) Enfermedad de Caroli.
- 3) Vesícula en porcelana.
- 4) Cólico biliar.

Respuesta correcta: 1

P116 MIR 2024-2025

En una mujer de 72 años con litiasis biliar asintomática se indicaría colectomía laparoscópica en caso de:

- 1) Microlitiasis por alto riesgo de pancreatitis aguda.
- 2) Litiasis biliar de más de 2,5 cm de diámetro.
- 3) Vesícula con paredes calcificadas en porcelana.
- 4) Presencia de cálculos de bilirrubina.

Respuesta correcta: 3

P005 MIR 2025-2026

Varón de 58 años con antecedente de coledocolitiasis en una ecografía abdominal que se hizo por otra causa. Refiere dolor abdominal continuo en epigastrio-hipocondrio derecho que irradia hacia la espalda. El dolor le ha comenzado tras la ingesta y ha cedido parcialmente tras tomar un espasmolítico. Así mismo refiere que se nota un poco amarillo y que la orina es muy oscura. Constantes: tensión arterial 140/75 mmHg; frecuencia cardíaca 100 lpm; temperatura 36,8 °C. A la exploración presenta dolor a la palpación en hipocondrio derecho con signo de Murphy negativo. En la analítica de sangre: bilirrubina total de 4 mg/dL con bilirrubina directa de 3,5 mg/dL, amilasa y lipasa normal, no tiene leucocitosis. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y tratamiento que aplicaría? Use las imágenes vinculadas de ayuda.

- 1) Cólico biliar por coledocolitiasis y colectomía.
- 2) Cólico biliar por coledocolitiasis, CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) y colectomía.
- 3) Colangitis y CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica).
- 4) Neoplasia de vía biliar extrahepática y cirugía oncológica.

Respuesta correcta: 2

T37 Tumores de la vía biliar

P080 MIR 2015-2016

¿Cuál de los siguientes NO se considera factor de riesgo de carcinoma de la vesícula biliar?

- 1) Litiasis biliar.
- 2) Alcoholismo crónico.
- 3) Vesícula en porcelana.
- 4) Pólipo vesicular de 15 mm.

Respuesta correcta: 2

P133 MIR 2022-2023

Paciente de 45 años con un episodio de coledocolitiasis hace tres meses en el que se encontró coledocolitiasis por ecografía. Ahora presenta fosfatasa alcalina alta y en una nueva ecografía litiasis vesiculares de pequeño tamaño con vía biliar de 1 cm de diámetro. ¿Qué exploración de las siguientes realizaría ANTES de la intervención quirúrgica?

- 1) Colangiografía retrógrada endoscópica.
- 2) Ecoendoscopia.
- 3) Colangiografía transparietohepática.
- 4) Colangiografía resonancia.

Respuesta correcta: 4

P014 MIR 2023-2024

Pregunta vinculada a la imagen nº 14. Paciente de 54 años que acude a realizarse una ecografía abdominal como control de una enfermedad de Crohn. Nunca ha presentado cólicos biliares y no tiene otra comorbilidad relevante. En la imagen se muestran los hallazgos de la ecografía (izquierda modo B y derecha con contraste

IV). De las siguientes, señale la afirmación CORRECTA:

- 1) A pesar de que nunca ha tenido síntomas de origen biliar está indicada la colecistectomía como prevención del cáncer de vesícula biliar.
- 2) Dado que está asintomático y no tiene riesgo aumentado de cáncer de vesícula biliar no se recomienda la colecistectomía y no es preciso seguimiento por este motivo.
- 3) La imagen no es suficientemente concluyente como para tomar una decisión terapéutica. Sería necesario ampliar el estudio con RM y/o PET/TC.
- 4) No está indicada la colecistectomía por estar asintomático, pero sí el seguimiento periódico.

Respuesta correcta: 1

P132 MIR 2023-2024

Mujer de 73 años que acude a urgencias por prurito, ictericia, astenia y pérdida de peso de un mes de evolución. Recientemente ha recibido tratamiento con amoxicilina/clavulánico por una infección urinaria. Se realiza una ecografía que informa de dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con vesícula biliar distendida. De las siguientes ¿cuál es la primera sospecha diagnóstica y actitud?

- 1) Toxicidad por fármacos. Retirada del antibiótico.
- 2) Colecistitis aguda. Colecistectomía urgente.
- 3) Coledocolitiasis distal. Solicitar una colangiorresonancia magnética.
- 4) Tumoración maligna obstructiva de colédoco distal. Solicitar una TC abdominal para estudio de extensión local y a distancia.

Respuesta correcta: 4

P124 MIR 2024-2025

Mujer de 58 años que consulta por presentar desde hace varios meses dolor abdominal epigástrico intermitente, náuseas y pérdida de peso involuntaria de 8 kg. Refiere episodios ocasionales de vómitos biliosos, sin haber notado sangre en los vómitos ni en las heces. Ha estado tomando antiácidos sin mucho alivio. En la exploración física se aprecia abdomen blando, con dolor a la palpación profunda en el epigastrio, sin masas palpables ni signos

de peritonitis. Los análisis muestran anemia microcítica e hipocrómica y ferropenia. En la gastroscopia lesión ulcerada en la segunda porción del duodeno, que se biopsia. El informe histológico confirma la presencia de adenocarcinoma duodenal. Una TC abdominal muestra la lesión limitada al duodeno, sin evidencia de diseminación a ganglios linfáticos o metástasis a distancia. ¿Cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de esta paciente?

- 1) Observación y seguimiento periódico con endoscopia digestiva alta debido a la localización del tumor.
- 2) Quimioterapia neoadyuvante seguida de una nueva evaluación para posible resección quirúrgica.
- 3) Duodenopancreatectomía cefálica (procedimiento de Whipple) como tratamiento de elección.
- 4) Radioterapia dirigida al duodeno para controlar la enfermedad local antes de considerar la cirugía.

Respuesta correcta: 3

P126 MIR 2024-2025

Hombre de 77 años que acude a Urgencias por prurito, ictericia y síndrome tóxico de un mes de evolución. Refiere ingesta de amoxicilina-clavulánico desde hace 10 días por un resfriado. A su llegada se realiza una ecografía que se informa de dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con vesícula biliar distendida. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica y la actitud a seguir?

- 1) Colecistitis aguda e indicación de colecistectomía urgente.
- 2) Coledocolitiasis distal y solicitud de colangiorresonancia magnética.
- 3) Toxicidad por fármacos y suspensión de la medicación.
- 4) Tumoración maligna obstructiva de colédoco distal y solicitar TC abdominal.

Respuesta correcta: 4

T38 Pancreatitis aguda

P037 MIR 2009-2010

¿Cuál de los siguientes criterios NO servirá para sospechar que se trata de una

pancreatitis aguda grave?

- 1) Amilasemia > 3.000 UI/L.
- 2) Criterios de Ranson > 3.
- 3) Apache II > 10.
- 4) PCR > 150 mg/L (a partir de las 48 horas del inicio de los síntomas).
- 5) Score de TC abdominal > 7 (a partir de las 72 horas).

Respuesta correcta: 1

P039 MIR 2011-2012

Los criterios de Ranson sirven como marcadores pronósticos tempranos en la pancreatitis aguda. Cuál de estos criterios no es correcto como predictor de mal pronóstico:

- 1) Glucemia > 200 mg/dL.
- 2) Leucocitosis > 16.000/mm³.
- 3) Edad < 55 años.
- 4) LDH sérica > 350 UI/L.
- 5) GOT sérica > 250 UI/L.

Respuesta correcta: 3

P040 MIR 2011-2012

Todas las siguientes están descritas como causa de pancreatitis aguda, EXCEPTO:

- 1) Litiasis vesicular.
- 2) Hipertrigliceridemia.
- 3) Alcohol.
- 4) Hipercolesterolemia.
- 5) Traumatismo abdominal.

Respuesta correcta: 4

P043 MIR 2012-2013

Una mujer de 55 años ingresa en el hospital con el diagnóstico de pancreatitis aguda. ¿Cuál de las siguientes pruebas o determinaciones analíticas NO es útil para predecir la gravedad de esta enfermedad?

- 1) Tomografía axial computarizada (TAC) del abdomen.
- 2) Creatinina en sangre.
- 3) Niveles de amilasa y lipasa en sangre.
- 4) Hematocrito.
- 5) Nitrógeno ureico en sangre (BUN).

Respuesta correcta: 3



P044 MIR 2012-2013

Paciente con pancreatitis aguda. En Tomografía Axial Computarizada (TAC) realizada a las 72 horas de ingreso se aprecia una necrosis del 50% del páncreas. A la tercera semana de ingreso, el paciente comienza con fiebre elevada y leucocitosis. Se solicita radiografía de tórax urgente y sedimento urinario, siendo ambos normales. Señale el siguiente paso a seguir:

- 1) Punción aspiración con aguja fina de necrosis pancreática guiada por ecografía o TAC.
- 2) Aspirado broncoalveolar, cultivo de orina y hemocultivos.
- 3) Resonancia Magnética Nuclear abdominal.
- 4) Colectectomía urgente.
- 5) Ecoendoscopia con punción de la necrosis.

Respuesta correcta: 1

P014 MIR 2015-2016

Pregunta vinculada a la imagen nº 14. Paciente de 40 años, fumador de 25 paquetes/año. Consumidor de alcohol de 20 UBEs (Unidades de bebida estándar)/día en los últimos meses. Diagnosticado de infección por el VHC hace 8 años, sin tratamiento. Relata un cuadro de dolor abdominal de varios días de evolución, 2 meses antes, por el que no llegó a consultar y que duró aproximadamente 1 semana. Consulta ahora por dolor abdominal, inicialmente en epigastrio y posteriormente difuso. En el momento del ingreso se aprecia mal estado general, edemas en extremidades inferiores y un abdomen distendido con signos de ascitis. En la analítica practicada en una muestra de sangre se apreciaron los siguientes datos: creatinina 0,68 mg/dL (0,4-1,2), glucosa 84 mg/dL (75-115), AST 21 UI/L (0-35), ALT 15 UI/L (0-35), albúmina 21 g (35-52), bilirrubina 0,6 mg/dL (0,3-1,2), hemoglobina 10,7 g/dL, plaquetas 288.000/mm³, leucocitos 8.200 /mm³, ratio del tiempo de protrombina 1,12 (0,8-1,2). Se realizó una TC abdominal que se presenta en la imagen asociada, y también una paracentesis, obteniéndose un líquido amarillento claro con los siguientes datos analíticos: glucosa 68 mg/dL, albúmina 17 g/L, bilirrubina 0,4 mg/dL, amilasa 3200 U/L y 200 células/mm³ (70% neutrófilos). Con los datos disponibles, ¿Cuál es, entre los siguientes, el diagnóstico más probable en este caso?

- 1) Pseudoquiste pancreático con ascitis pancreática.
- 2) Neoplasia quística pancreática con ascitis por carcinomatosis.
- 3) Peritonitis secundaria por perforación del tubo digestivo.
- 4) Descompensación ascítica en paciente con hepatopatía crónica avanzada.

Respuesta correcta: 1

P084 MIR 2016-2017

El marcador serológico más útil para el diagnóstico de una pancreatitis autoinmune tipo I es:

- 1) El anticuerpo anticitoplasma de los neutrófilos (ANCA).
- 2) El anticuerpo antimitocondrial (AMA).
- 3) El anticuerpo antimicrosomal.
- 4) El nivel de Ig G4.

Respuesta correcta: 4

P085 MIR 2016-2017

Mujer de 64 años, obesa, con dolor epigástrico intenso irradiado en cinturón, febrícula, hiperamilasemia marcada, hematocrito del 48% y creatinina sérica discretamente elevada. En la TC abdominal se evidencia un páncreas con agrandamiento difuso, contorno irregular, inflamación alrededor de la glándula y una acumulación de líquido intrapancreática. ¿Cuál de estas opciones es CIERTA en relación con el manejo del paciente?

- 1) La reanimación mediante fluidoterapia enérgica es básica en el tratamiento.
- 2) Debe administrarse desde el inicio antibioterapia con fines profilácticos para evitar la necrosis infectada.
- 3) La nutrición parenteral total está indicada a partir de las 48-72 horas.
- 4) El uso de inhibidores de la proteasa (aprotinina) ha demostrado un efecto beneficioso en estos casos.

Respuesta correcta: 1

P168 MIR 2019-2020

Hombre de 57 años que acude a Urgencias por un dolor epigástrico de elevada intensidad, irradiado a espalda y a hipocondrio

derecho, junto a náuseas y vómitos de 12 horas de evolución. En la exploración se encuentra afebril, estable hemodinámicamente, lúcido y con buena perfusión. En la analítica destacan 18.000 leucocitos (80% neutrófilos), siendo el resto del hemograma normal. La bioquímica es normal, incluyendo calcio, LDH y triglicéridos, excepto una amilasa de 3.000 U/L. Señale la afirmación CORRECTA:

- 1) El cuadro clínico sugiere una colangitis aguda.
- 2) El paciente tiene probablemente una isquemia mesentérica aguda.
- 3) No es necesario realizar prueba de imagen en Urgencias o en todo caso una ecografía abdominal.
- 4) Es preciso realizar una TC abdominal urgente.

Respuesta correcta: 3

P152 MIR 2025-2026

Paciente con pancreatitis aguda grave por litiasis biliar, necrosis extensa estéril del cuerpo y cola. A las tres semanas, presenta fiebre, dolor persistente, PCR elevada. En la TAC de abdomen con contraste se observa una colección encapsulada con niveles líquido aire y necrosis pancreática. ¿Cuál es la conducta MÁS adecuada?

- 1) Laparotomía urgente con necrosectomía abierta.
- 2) Mantener tratamiento conservador, la presencia de gas no sugiere infección.
- 3) Abordaje escalonado: drenaje mínimamente invasivo (endoscópico/percutáneo) guiado y necrosectomía diferida si es necesario.
- 4) Esclerosis percutánea con alcohol absoluto.

Respuesta correcta: 3

T39 Pancreatitis crónica

P042 MIR 2012-2013

Mujer de 62 años que ingresa por ictericia franca. Se realiza una colangiorresonancia magnética nuclear que muestra una masa en la cabeza del páncreas y estenosis de colédoco adyacente a la masa, pero también una estenosis de conducto hepático común. Una punción aspiración

con aguja fina de la masa no muestra células malignas. Debido a una crisis de broncoespasmo no relacionada con el problema pancreático se administran corticoides. Curiosamente la ictericia cede. Se realiza una TC abdominal y la masa ha disminuido de tamaño, apreciándose una menor dilatación de la vía biliar. ¿Qué prueba sería más útil para confirmar la causa más probable del cuadro?

- 1) Determinación serológica de IgG4.
- 2) PET-TAC.
- 3) Gammagrafía con octreótido marcado.
- 4) Radiografía de tórax.
- 5) Estudio serológico de Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Respuesta correcta: 1

P039 MIR 2017-2018

Mujer de 58 años con antecedente de tiroiditis de Riedel. Presenta dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia obstructiva. Ante la sospecha radiológica de carcinoma de páncreas, se realiza una duodenopancreatectomía cefálica. En el estudio anatomopatológico no encontramos un carcinoma, sino abundantes células inflamatorias con tendencia a rodear ductos, marcada fibrosis, flebitis obliterante y más de 50 células plasmáticas IgG4+ por campo de gran aumento. ¿Cuál es el diagnóstico?

- 1) Hamartoma pancreático.
- 2) Pancreatitis autoinmune.
- 3) Malacoplaquia.
- 4) Pancreatitis del surco.

Respuesta correcta: 2

P177 MIR 2020-2021

En la TC de abdomen con contraste intravenoso realizada para estudio de pancreatitis crónica, ¿Cuál de los siguientes hallazgos es TÍPICO de esta enfermedad?

- 1) Ensanchamiento del marco duodenal.
- 2) Áreas focales de necrosis pancreática.
- 3) Aumento en el realce glandular en fase arterial.
- 4) Dilatación de conducto pancreático.

Respuesta correcta: 4

P022 MIR 2022-2023

Pregunta vinculada a la imagen nº 22. Varón de 75 años con dolor abdominal intermitente, dispepsia y pérdida de peso. Se le realiza TC abdominal con contraste (imagen vinculada). Además de la observación casual de un quiste renal izquierdo ¿cuál de los siguientes hallazgos se encuentra?

- 1) Tumoración en cola pancreática con calcificaciones e invasión tumoral de arteria esplénica.
- 2) Calcificaciones pancreáticas difusas en cuerpo y cola pancreática, indicativas de pancreatitis aguda.
- 3) Tumoración en cabeza pancreática con calcificaciones e invasión tumoral de arteria esplénica.
- 4) Calcificaciones pancreáticas difusas en cuerpo y cola pancreática, indicativas de pancreatitis crónica.

Respuesta correcta: 4

T40 Tumores del páncreas exocrino

P036 MIR 2009-2010

Paciente de 52 años con datos clínico-biológicos de ictericia obstructiva de evolución intermitente y sangre oculta en heces positiva, con dieta idónea. De los diagnósticos que se reseñan, ¿Cuál es el más probable?

- 1) Carcinoma pancreático.
- 2) Litiasis vesicular.
- 3) Colecistitis crónica.
- 4) Ampuloma.
- 5) Colangiocarcinoma intrahepático.

Respuesta correcta: 4

P037 MIR 2010-2011

Una mujer de 76 años, sin otros antecedentes que hipertensión arterial, consulta por ictericia indolora y prurito, con anorexia. Analíticamente, destaca una bilirrubina total de 12 mg/dL (con 9,5 mg/dL de bilirrubina directa). La ecografía abdominal muestra dilatación biliar intra y extrahepática, junto con un nódulo hepático único menor de 2 cm, localizado periféricamente,

en la cara anterior del lóbulo izquierdo. La TC confirma estos hallazgos, demostrando además la presencia de una masa de 3,5 cm en la cabeza pancreática. La punción aspirativa con aguja fina del nódulo hepático resulta concluyente para adenocarcinoma. Señale la mejor opción terapéutica:

- 1) Quimio/radioterapia neoadyuvante condicionando la opción de cirugía radical a la respuesta inicial.
- 2) Drenaje biliar externo percutáneo con carácter paliativo, con eventual reconversión a drenaje interno en caso de intolerancia o complicaciones.
- 3) Derivación biliar quirúrgica paliativa, con o sin gastro-yeyunostomía profiláctica en función de los hallazgos intraoperatorios.
- 4) Prótesis biliar metálica mediante colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, con opción a quimioterapia paliativa.
- 5) Duodenopancreatectomía cefálica, con ablación percutánea mediante radiofrecuencia o alcoholización de la lesión hepática.

Respuesta correcta: 4

P001 MIR 2013-2014

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. Hombre de 40 años sin antecedentes de interés. Desde hace 4 semanas, refiere cuadro de deposiciones diarreicas, asociado a ictericia de piel y mucosas, coluria, hipocolia y dolor en hipocondrio derecho, acompañado de pérdida de peso (10 kg aprox.) y prurito intenso. En la analítica destaca: bilirrubina total: 15,3 mg/dL. Alanina-aminotransferasa: 70 U/L. Aspartato-aminotransferasa: 85 U/L. Serología para hepatitis negativa y elevación del CA 19-9. Se realiza TC abdominal. Se muestran 3 secciones axiales. En relación a los hallazgos de la prueba radiológica, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- 1) Se observa una masa tumoral en cabeza de páncreas que condiciona dilatación biliar y ductal compatible con adenocarcinoma.
- 2) Presencia de engrosamiento difuso del páncreas con Wirsung arrosariado compatible con pancreatitis linfoplasmocitaria.
- 3) Se identifica una masa tumoral en infundíbulo vesicular compatible con adenocarcinoma vesicular.



- 4) Se observan voluminosas adenopatías tumorales en hilio hepático que producen dilatación de la vía biliar.
- 5) Presencia de múltiples lesiones focales hepáticas sólidas compatibles con metástasis hepáticas difusas.

Respuesta correcta: 1

P002 MIR 2013-2014

Pregunta vinculada a la imagen nº 1. En el paciente anterior, ¿Cuál de los siguientes tratamientos está indicado?

- 1) Drenaje biliar por vía endoscópica retrógrada y quimioterapia sistémica.
- 2) Duodenopancreatectomía cefálica con resección vascular.
- 3) Embolización hepática con esferas cargadas de quimioterapia.
- 4) Drenaje biliar transparietohepático y quimioterapia sistémica.
- 5) Tratamiento con corticoides.

Respuesta correcta: 2

P055 MIR 2013-2014

El cáncer de páncreas más frecuente es:

- 1) El tumor papilar mucinoso intraductal.
- 2) El carcinoma neuroendocrino de páncreas.
- 3) El cistoadenocarcinoma de páncreas.
- 4) El insulinoma maligno.
- 5) El adenocarcinoma ductal de páncreas.

Respuesta correcta: 5

P046 MIR 2014-2015

En relación con los tumores mucinosos papilares intraductales de páncreas, señalar el enunciado INCORRECTO:

- 1) Son tumores potencialmente malignos.
- 2) Su frecuencia se ha incrementado notablemente en la última década.
- 3) Se distinguen tres subtipos: de conducto principal, de conducto secundario y mixto.
- 4) Deben ser extirpados tan pronto como se diagnostiquen, excepto la variedad de conducto principal.
- 5) Su primera manifestación clínica puede ser un cuadro de pancreatitis aguda.

Respuesta correcta: 4

P004 MIR 2015-2016

Pregunta vinculada a la imagen nº 4. Mujer de 65 años. Consulta por síndrome constitucional asociado a dolor abdominal epigástrico progresivo irradiado a espalda, de dos meses de evolución. El diagnóstico de sospecha de adenocarcinoma de páncreas se confirma por biopsia guiada por ecoendoscopia. Se realiza TC de abdomen tras administración de contraste intravenoso para valoración de estructuras vasculares próximas al tumor pancreático, a fin de establecer su posible afectación (ver imagen). ¿Qué estructura vascular está ausente, trombosa por infiltración tumoral, condicionando circulación colateral en la pared gástrica?

- 1) Vena mesentérica superior.
- 2) Vena coronaria estomáquica.
- 3) Vena esplénica.
- 4) Vena porta.

Respuesta correcta: 3

P066 MIR 2015-2016

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la estadificación del cáncer de páncreas?

- 1) La estadificación local puede realizarse con RM y TC.
- 2) La invasión tumoral arterial es un criterio de irreseccabilidad.
- 3) La infiltración focal de la vena mesentérica superior no es una contraindicación a la cirugía.
- 4) La biopsia preoperatoria de los tumores pancreáticos es habitualmente necesaria para decidir el tratamiento quirúrgico.

Respuesta correcta: 4

P079 MIR 2015-2016

¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación al tumor mucinoso papilar intraductal pancreático?

- 1) Se consideran lesiones premalignas.
- 2) Pueden afectar tanto al conducto pancreático principal como a las ramas secundarias y se caracterizan por presentar epitelio productor de mucina.

- 3) La presencia de nódulos en la pared de la lesión no constituye un signo de alarma.
- 4) Cuando afecta a las ramas secundarias, la resección quirúrgica está indicada si es mayor de 3 cm.

Respuesta correcta: 3

P075 MIR 2017-2018

Respecto a la cirugía de resección del adenocarcinoma de cabeza de páncreas, señale cuál es la técnica MÁS empleada:

- 1) La duodenopancreatectomía cefálica con linfadenectomía regional.
- 2) La pancreatocoyeyunostomía, que consiste en la derivación del ducto pancreático al intestino.
- 3) La pancreatectomía corporocaudal por laparoscopia.
- 4) La enucleación del tumor sin necesidad de linfadenectomía.

Respuesta correcta: 1

P087 MIR 2017-2018

De las siguientes, ¿Qué afirmación sobre el cáncer de páncreas es CORRECTA?

- 1) Los factores de riesgo implicados en esta neoplasia incluyen tabaquismo, obesidad y pancreatitis aguda.
- 2) La prueba diagnóstica de imagen más adecuada es la TC helicoidal sin contraste y doble fase.
- 3) Es necesaria la confirmación diagnóstica anatomopatológica preoperatoria antes de realizar el tratamiento quirúrgico con finalidad curativa.
- 4) La alteración genética detectada con más frecuencia es la delección del gen p16.

Respuesta correcta: 4

P085 MIR 2018-2019

Aproximadamente el 90% de los tumores malignos del páncreas exocrino son adenocarcinomas ductales. ¿Cuál de las siguientes situaciones define ADECUADAMENTE la relación entre diabetes y cáncer de páncreas?

- 1) Los pacientes con diabetes de larga evolución tienen un riesgo > 50% de desarrollar cáncer de páncreas.

- 2) La diabetes está presente en un tercio de los pacientes con cáncer de páncreas avanzado y en muchos de ellos es de instauración reciente.
- 3) En la mayoría de pacientes con cáncer de páncreas, la diabetes se instaure cuando aparece ictericia.
- 4) La diabetes desaparece después de la exéresis del tumor.

Respuesta correcta: 2

P227 MIR 2018-2019

Mujer de 76 años con clínica de ictericia indolora de tres semanas de evolución. En el estudio con ecografía abdominal se identifica una lesión de 3 cm en cabeza pancreática. ¿Cuál es el PRIMER estudio complementario para el diagnóstico y estadificación de esta lesión?

- 1) PET-TC.
- 2) Ecoendoscopia.
- 3) TC toraco-abdomino-pélvico con contraste.
- 4) Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.

Respuesta correcta: 3

P147 MIR 2020-2021

El cáncer de páncreas localmente avanzado:

- 1) Es una presentación clínica infrecuente (< 10%).
- 2) Tiene una supervivencia mediana inferior a 3 meses.
- 3) Es candidato a quimio-radioterapia neoadyuvante.
- 4) Es mínimamente sintomático.

Respuesta correcta: Anulada

P148 MIR 2020-2021

Mujer de 72 años sin antecedentes de interés. Tras un cólico renal complicado se encuentra casualmente en la TC abdominal una lesión quística en cola de páncreas de 2 cm, junto con múltiples lesiones quísticas renales bilaterales. La ultrasonografía endoscópica muestra una lesión poliquística formada por múltiples vesículas con calcificación central en cola de páncreas sin conexión con el conducto de Wirsung. El análisis del líquido es compatible con un cistoadenoma seroso. De las siguientes, ¿Cuál es la actitud MÁS correcta con respecto al manejo de esta paciente?

- 1) Resección quirúrgica (pancreatectomía corporocaudal).
- 2) Punción guiada mediante ultrasonografía endoscópica y etanolización de la misma.
- 3) Seguimiento de la lesión mediante RM.
- 4) Trasplante de riñón-páncreas.

Respuesta correcta: 3

P135 MIR 2023-2024

Mujer de 62 años que consulta por dolor abdominal persistente, pérdida de peso no intencionada de 10 kg en los últimos tres meses, ictericia y acolia. En las últimas horas presenta vómitos de retención gástrica. Las analíticas muestran elevación de bilirrubina y enzimas hepáticas así como hipopotasemia. La TC abdominal revela una masa en la cabeza del páncreas y proceso uncinado que provoca obstrucción de la vía biliar, infiltración inextirpable vascular, distensión y retención gástrica. Tras estabilizarla se efectúa

ecoendoscopia con biopsia que demuestra la existencia de un adenocarcinoma pancreático con estenosis infranqueable del duodeno. ¿Cuál de las siguientes es la mejor actitud terapéutica?

- 1) Doble derivación bilio-digestiva.
- 2) Intervención de Whipple.
- 3) Intervención de Puestow.
- 4) Coledocoduodenostomía.

Respuesta correcta: 1

P095 MIR 2025-2026

La complicación MÁS frecuente y grave de la duodenopancreatectomía cefálica es:

- 1) Hemorragia.
- 2) Absceso intrabdominal.
- 3) Fístula pancreática.
- 4) Infección de la herida.

Respuesta correcta: 3

P097 MIR 2025-2026

Indique la afirmación FALSA en relación con la neoplasia mucinosa papilar intra-ductal (NPIM) del páncreas:

- 1) Se localiza en la cabeza y el cuerpo, pero el 10% es multifocal (*skip lesions*).
- 2) Se realiza una pancreatectomía total, ya que maligniza y es multifocal.
- 3) Existen tres tipos (I: ducto principal; II: rama secundaria; III: mixto).
- 4) En el tipo I durante la CPRE (colangiopancreatografía retrógrada endoscópica) se produce salida de moco de la papila.

Respuesta correcta: 2